HÔPITAUX Paris

Saint Joseph Marie Lannelongue

# LIVRET IOA




Service des urgences

Hôpital Paris Saint-Joseph

Année 2024

# TABLE DES MATIERES


I. Rôle et missions IOA ..... 4
1. Rôle de l'IOA ..... 4
2. Missions de l'IOA ..... 4
3. Le tri ..... 5
4. La grille de tri HPSJ ..... 6
4.1. Tri rouge = SAUV ..... 8
4.2. `Tri Orange = Zone 2A `` ..... 9
4.3. Tri Jaune = Zone 2 A et B ..... 9
4.4. Tri Rose = Zone 2B ..... 9
4.5. Tri Violet = Zone 1 ..... 10
4.6. Tri Bleu = Zone 1 ..... 10
4.7. Tri Vert = MAO / Zone 1 ..... 10
II. Aide-mémoire IOA ..... 11
1. Le 3Q2C ..... 11
2. Exemple d'un Motif IOA ..... 11
3. AIDE-mémoire IOA ..... 12
4. Deux scores a l'IOA ..... 14
4.1. QSOFA ..... 14
4.2. FTPA ..... 15
5. Schema : PEC de la douleur ..... 16
III. Protocoles et procédures SAU / IOA ..... 17
1. Agressions sexuelles ..... 17
2. PEC de femmes victimes de violences conjugales ..... 19
3. PEC d'une victime d'agression sexuelle ..... 21
4. Analgesie pour acte de traumatologie douloureux chez l'adulte au SAU ..... 25
5. Delivrance d'antalgiques par l'infirmier a l'accueil des urgences ..... 27
6. PEC de la douleur chez l'enfant accueilli aux urgences ..... 29
7. CAT en cas de non reponse a l'appel d'un patient par un personnel des urgences ..... 32
8. CAT devant une personne occupant la salle d'attente du SAU sans demande de PEC médicale ..... 34
9. PEC par le service des urgences d'un patient adressé par un autre service ..... 36
10. PEC d'un enfant mineur dont l'un des parents et/ou responsable légal est hospitalisé en urgence. ..... 37
11. Accueil des mineurs en consultation et hospitalisation : recommandations ..... 40
12. PEC des SDF ..... 42
13. CAT en cas de consultation et/ou d'hospitalisation d'un detenu ..... 44
14. Patient porteur d'arme ou de drogue ..... 48
15. CAT en cas de gâle ..... 50

16. PEC d'un patient suspect ou atteint d'infection due au monkeypox virus ..... 54
17. PEC d'un patient suspect d'infection due au Coronavirus du Moyen Orient (MERS-CoV)..... 71
18. PEC d'un patient suspect ou atteint de rougeole ..... 74
19. Urgences psychiatrique hors presence médecin psychiatre au SAU ..... 78
20. Contention physique au SAU..... 79
21. Coopération professionnelle IOA – Urgences : prescription de radiographie..... 81
22. Protocole de coopération professionnelle : Intoxication au monoxyde de carbone (CO)..... 82
23. Protocole de coopération professionnelle : Rétention aiguë d'urine ..... 84
24. Protocole de coopération professionnelle : PEC des plaies ..... 86
25. ACR chez l'enfant ..... 87
26. Alerte thrombolyse ..... 90
27. Hyperkaliémie ..... 90
28. Protocole ECG a L'IOA ..... 91
29. Gestion des effets personnels des patients..... 92
IV. Autres ..... 95
1. Règles de bonnes pratiques IOA..... 95
2. IOA 3 (Triplage de l'IOA)..... 96
3. Ré-évaluation a l'IOA ..... 97
4. IOA en mode en procedure degradée..... 98
5. Fiches de précautions complémentaires ..... 100
5.1. Précaution complémentaire : contact..... 100
5.2. Précaution complémentaire : goutelettes ..... 101
5.3. Précaution complémentaire : air..... 102
5.4. Précaution complémentaire contact renforcées : C. difficile..... 103
5.5. Précaution complémentaire contact renforcées : ectoparasites, gâle ..... 104
5.6. Précaution complémentaire contact renforcées : BHRe..... 105
5.7. Précaution complémentaire contact renforcées : Candida Auris ..... 106
5.8. Isolement protecteur..... 107

# I. ROLE ET MISSIONS IOA

## 1. ROLE DE L'IOA

Une des spécificités des services d'urgences est la mise en place d'infirmier d'accueil et d'orientation. Afin de pouvoir prétendre à ce poste, les IDE doivent justifier de plusieurs mois d'expérience au sein du service, puis, avoir bénéficié d'une formation spécifique IOA effectuée par des organismes agréés par les sociétés savantes de l'urgence. Le poste d'IOA est régi dans un cadre législatif via des circulaires[1] et des décrets[2].

La société française de médecine d'urgence (SFMU), nous en donne la définition suivante : ***Accueillir de façon personnalisée le patient et ses accompagnants à leur arrivée, définir les priorités de soins en fonction des besoins exprimés et/ou constatés, et, en fonction de ces derniers, décider du lieu de soins adapté. Ces actions ont pour objectif d'améliorer la qualité de prise en charge des patients et de leurs accompagnants dès l'accueil. Elles sont menées en lien constant avec le médecin référent chargé de superviser le fonctionnement du service et la gestion des flux. »***[3]

## 2. MISSIONS DE L'IOA

➔ **Accueillir :**

L'infirmier organisateur de l'accueil (IOA) doit concilier le soin relation infirmier auprès du patient afin de diminuer le stress de l'admission et d'évaluer rapidement le degré d'urgence afin de privilégier la prise en charge du patient présentant un réel caractère d'urgence.

➔ **Décider du lieu de soins adapté**

L'IOA décide (avec le médecin référent) du lieu de soins appropriés à son état, après recueil et synthèse des informations.

➔ **Installer**

L'IOA installe le patient en fonction de la pathologie, des moyens disponibles dans le service.

➔ **Informer, aider, rassurer**

L'IOA informe le patient et son entourage de l'organisation des soins, des différents circuits du service, du délai et des raisons de l'attente.
L'IOA rassure le patient et ses accompagnants et informe des soins.

➔ **Surveiller**

L'IOA surveille les patients dans les différentes salles d'attentes. Il est responsable des patients et de leur évolution au sein du service des urgences.

➔ **Anticiper**

---

[1] Circulaire DH.4B/D.G.S. 3E/91 – 34 du 14 mai 1991.
[2] Décret n°95-647 du 9 mai 1995 ; Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 ; Décret n°2006-577 du 22 mai 2006 ; Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016.
[3] Référentiel SFMU IOA 2020 : https://www.sfmu.org/upload/referentielsSFMU/IOA_référentiel_SFMU2020.pdf

L'IOA peut assurer une liaison directe avec les centres de traitement de l'alerte des sapeurs-pompiers, les centres de réception et de régulation des appels du SAMU, la police et anticipe la venue des patients à risque (détenus, patient consultant sur réquisition judiciaire...).

➔ **Communiquer et coordonnées**

L'IOA centralise les différentes informations.

➔ **Enseigner**

L'IOA, dans son domaine de compétences et de sa spécialité, encadre les étudiants infirmiers lors de leur stage.

Rôle et missions : 8 étapes de l'IOA




## 3. LE TRI

Le premier objectif de l'IOA est de mettre en place une relation de confiance et de poser les bases d'une relation soignant-soigné de qualité. Il s'agit de permettre au patient et à ses proches de partager les informations les plus pertinentes pour sa prise-en-charge, mais aussi de comprendre les soins et d'y consentir dans les meilleures conditions. Par accueil, on entend donc en particulier : information, écoute, gestion du stress ; installation, confort, prise en charge de la douleur.

Les étapes de cet accueil sont immuables : civilités (saluer et se présenter), écoute et recueil de données, information (pour expliquer succinctement le fonctionnement du service : le patient ne passe pas par ordre d'arrivée).

Les qualités fondamentales de cette relation soignant-soigné sont l'écoute, l'ouverture, la neutralité et la bienveillance. L'instauration de cette relation de confiance est à la fois un challenge et un impératif à l'accueil d'un service d'urgence. Elle est indispensable et facilitera le processus de tri que l'IOA réalise simultanément.

Les deux missions assumées par l'IOA sont l'accueil et le tri initial. L'IOA, accueil toutes les personnes se présentant et s'enregistrant à l'entrée du service, de plus il établi un ordre de priorités parmi tous les patients présents en salle d'attente et organise le circuit de chacun (en se posant la question : qui peut attendre sans risque ?).

Il est important de rappeler que la consultation IOA doit avoir lieu le plus tôt possible après l'arrivée du patient et ne peut dépasser les dix minutes (sauf cas spéciaux).

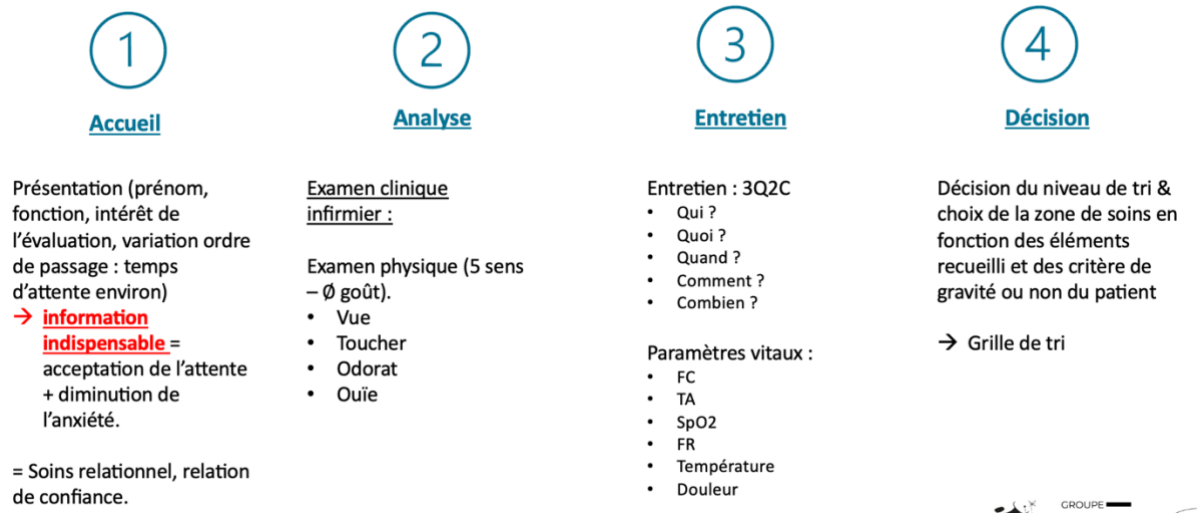
Le processus de tri, comporte quatre étapes :

- L'accueil
- L'examen physique du patient (qui a souvent lieu dès l'entrée du patient dans le box de consultation, l'IOA fait appel à ses connaissances et à son expérience, notamment en utilisant certains des sens de l'être humain : vue, toucher, ouïe et l'odorat).
- L'analyse de la situation, à l'aide d'un bref examen clinique articulant l'examen physique (précédemment établi), mesure de paramètres vitaux et interrogatoire.
- La décision du niveau de tri et le choix de la zone de soins adapté, à l'aide d'une grille de tri et d'une connaissance fine des organisations spécifiques.

Pour revenir à l'interrogatoire, il s'agit d'un entretien semi-directif aidant à préciser le problème de santé. Le moyen mnémotechnique 3Q2C peut être utiliser pour structurer l'interrogatoire :

- Le Qui : Age, sexe, ATCD, épisodes similaires, TTT spécifiques
- Le Quoi : Motif (peut-être différent de celui énoncé en 1er lieu ou par les secours)
- Le Quand : Date et heure de début
- Le Comment : Facteurs déclenchants, circonstances, mode de début et d'évolution
- Le Combien : Intensité du symptôme, pics, évolution

Schéma récapitulatif des 4 étapes de l'IOA :




## 4. LA GRILLE DE TRI HPSJ

Il existe différentes grilles permettant aux IOA d'effectuer un tri rapide et efficace des patients, nous pouvons cités la grille FRENCH[4] (créée par la SFMU) et utiliser dans de nombreux services d'urgences en France. Cependant, certains services, peuvent élaborer leur propre grille.

Dans notre service, la grille de tri, s'inspire de la grille FRENCH, mais elle fut élaborée par les équipes, afin qu'elle soit adaptée au service.

[4] SFMU – FRENCH Triage – Version 1.2 du 6/12/2019 : https://www.sfmu.org/upload/referentielsSFMU/2019%2012%2006%20FRENCH%20pour%20PDF%20A4%20V1.2%20site.pdf

Dans la grille FRENCH, nous retrouvons un classement allant du tri 1 (urgence immédiate) à 5 (urgence minime).

Dans le service des urgences de Saint-Joseph, nous utilisons une grille de tri par couleur, comprenant 7 couleurs, en fonction de la zone choisie et de l'urgence du patient.

**Rouge = Urgence immédiate**

Les patients présentent plusieurs critères de gravités et nécessite une prise en charge médicale immédiate. Ils sont donc directement installés en Salle d'Accueil des Urgences Vitales (SAUV).

**Orange :**

Les patients présentent un critère de gravité et/ou une pathologie potentiellement grave et/ou urgent, nécessitant une prise en charge dans les 60 min après leur arrivée.
Les patients triés en orange, sont des patients nécessitant d'être alité, ils seront donc pris en charge par l'équipe de la zone couchée (Zone 2).

**Jaune :**

Les patients ne présentent aucun critère de gravité, ni d'urgence, ils sont eux aussi alité et donc pris en charge par l'équipe de la zone couchée (zone 2).
Les patients triés en jaune, nécessitent une prise en charge dans les 90 minutes après leur arrivée.

**Rose :**

Le tri rose est un tri particulier, ils regroupent certains motifs précis. Les patients sont alités mais leur prise en charge de ses patients est plutôt simple et ne nécessite pas ou très peu d'examens complémentaires.
Ils sont pris en charge en zone couchée, par une équipe dédiée.

**Violet :**

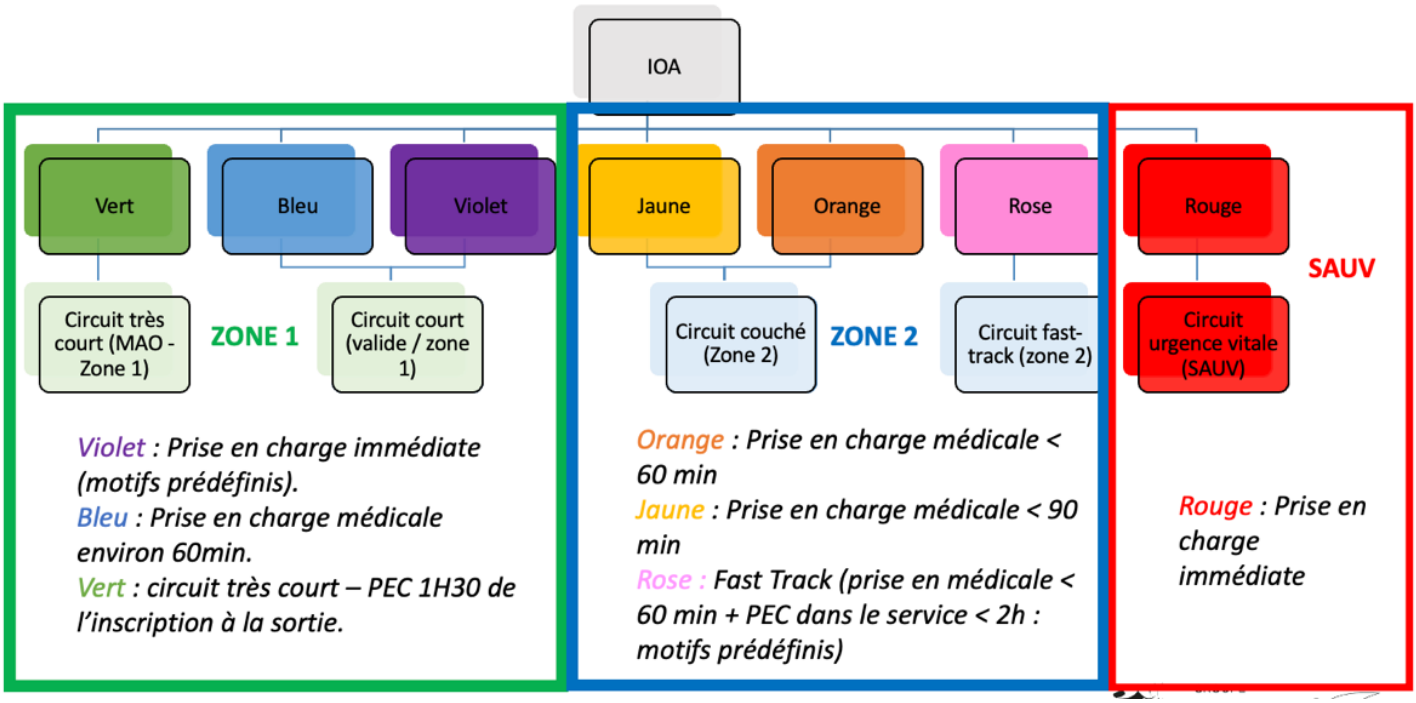
Le tri violet est l'équivalent du tri rose, cependant pour ce tri les patients sont valides, ils sont donc pris en charge par l'équipe de la zone valide (zone 1).

**Bleu :**

En bleu, nous retrouvons les patients valides, ne présentant aucun signe de gravités ou d'urgence, mais nécessitant une prise en charge aux urgences.
Ils sont pris en charge en zone valide (zone 1).

**Vert :**

Le tri vert correspond au « circuit très court » (CTC). Le patient présente un des motifs présents dans la liste de ce tri. Le plus souvent, ces patients sont pris en charge uniquement par le médecin d'accueil et d'orientation (MAO).




## 4.1. TRI ROUGE = SAUV

**ROUGE**

*Patient présentant une détresse ou pathologie nécessitant installation immédiate*

| |
|---|
| **CARDIO-VASCULAIRE/ HEMODYNAMIQUE** |
| - ACR<br>- Tas < 80mmHg et/ou Signes périphériques de choc (marbrures - cyanose des extrémités)<br>- FC > 140 ou FC < 45<br>- Douleur thoracique avec modification ECG<br>- TAS > 220mmHg symptomatique<br>- Patient présentant un QSofa > ou = 2 critères. |
| **RESPIRATOIRE** |
| - FR < 10<br>- SpO2 < 94% sous 6L/min d'O2 ET FR > 22<br>- Hémoptysie active ou hémoptysie avec SAT < 94%<br>- Détresse respiratoire haute (laryngée) ou CE avec hyper sialorrhée |
| **NEUROLOGIQUE** |
| - Coma avec score de Glasgow < 9<br>- **Déficit neurologique < 4h30 (même si constaté au réveil)** |
| **DIGESTIF** |
| - Hémorragie digestive active : hématémèse – méléna – rectorragies très abondantes (avec défaillance hémodynamique) |
| **INFECTIOLOGIE** |
| - Hypothermie avec **modification ECG** |
| **INTOXICATION quelle que soit la nature** |
| - **Avec modification ECG** |
| **MÉTABOLIQUE** |
| - Hyperglycémie (dextro = HI) avec cétonémie > 1,5<br>- Hypoglycémie avec dextro ≤ 0.3<br>- Hyperkaliémie > 6 mmol/L avec modification ECG<br>- Hypokaliémie < 2,5 même sans modification ECG |
| **TRAUMATOLOGIE** |
| - Amputation de membre complète ou quasi complète (sauf doigts et orteils)<br>- Plaie artérielle évidente/ou garrot mis en place<br>- Brûlures : étendues (> 10% SC) et/ou circulaire AVEC antalgie par anesthésie vigile ou siège particulier : ORL – tête – périnée<br>- Traumatisme pénétrant (arme blanche ou arme à feu) du thorax ou abdomen ou crânien ou cervical<br>- Electrisation ou électrocution avec modification ECG après accord du MAO |
| **PÉDIATRIE : SAU sans activité pédiatrique** |
| - ACR<br>- Coma |

## 4.2. `TRI ORANGE = ZONE 2A ``

**ORANGE**

*Patient alité présentant une constante d'alerte ou une pathologie potentiellement grave et/ou urgente*

| |
|---|
| **CARDIO-VASCULAIRE/ HEMODYNAMIQUE** |
| - Syncope sans prodromes ***(À SCOPER)*** |
| - Association de 2 critères suivants : ***(À SCOPER)*** |
| • PAS ≤ 100 mmHg |
| • Polypnée ≥ à 22/min |
| • Trouble des fonctions supérieures (confusion, désorientation, Glasgow < 15) |
| - Douleur thoracique typique persistante sans trouble de la repolarisation à l'ECG ***(À SCOPER)*** |
| - TAS > 220mmHg non symptomatique |
| **RESPIRATOIRE** |
| - FR > 30/min ***(À SCOPER hors crise d'angoisse)*** |
| - Ou Signes de lutte respiratoire ***(À SCOPER)*** |
| **NEUROLOGIQUE** |
| - Troubles de la conscience avec score de Glasgow 9 - 14 |
| - > 2 crises épilepsie dans l'heure (non épileptique connu) ***(À SCOPER)*** |
| **INFECTIOLOGIE** |
| - Hyperthermie > 39°C |
| **INTOXICATION quelle que soit la nature** |
| - Glasgow < 15 et > 9 |
| **MÉTABOLIQUE** |
| - Hypoglycémie avec score de Glasgow de 14 ou 15 |
| - Hyperkaliémie > 6 mmol/L sans modification ECG |
| **TRAUMATOLOGIE** |
| - Brûlures : étendues (> 10% SC) SANS antalgie par anesthésie vigile ou SANS siège particulier : ORL – tête – périnée (non circulaire) |
| - Plaie du scalp de grande taille très hémorragique **après accord du MAO** |
| **DOULEUR** |
| - EN > 7 pour titration en morphine → Avec transmissions orales (IDE/MEDECIN) |
| - EN entre 5 et 7 nécessitant la prise d'Oxynorm |

## 4.3. TRI JAUNE = ZONE 2 A ET B

**JAUNE**

*Patient alité mais ne présentant ni signe de gravité, ni d'urgence*

## 4.4. TRI ROSE = ZONE 2B

**ROSE**

*Fast Track Zone non valide*

- Rétention aigue d'urine
- **Déficit neurologique constitué ou transitoire de + de 6h et – de 24h.**
- Problème de matériel médical
- Mono traumatisme de membre hors tronc
- Traumatisme **bassin/hanche** ne pouvant pas être en zone valide.
- **TC sans signe** de focalisation de la personne non valide **(pas de prise d'anticoagulant**).
- Patient adressé pour réalisation d'un Angioscanner devant des **Ddimères** augmentés.
- Crise convulsive résolutive d'un patient **épileptique connu**
- Anémie **sans autres anomalies** (paramètres vitaux stable + pas de saignement extériorisé)
- Mauvaise évolution d'un **ulcère suivi au GHPSJ**
- Colique néphrétique hyperalgique
- Ebriété sur la voie publique**, Glasgow 14 et/ou somnolent mais réveillable.**
- IMV du sujet non délirant, **Glasgow 15 (non agité et sans ATCD psychiatrique).**
- Epistaxis **non traumatique** avec stabilité hémodynamique
- Douleur abdominale du sujet de **moins de 30 ans, sans ATCD,** nécessitant d'être couché.
- Douleur thoracique atypique du sujet de **moins de 30 ans, sans ATCD,** nécessitant d'être couché.
- **FTPA (seulement si correspond aux critères suivants) :**
  - **+ de 75 ans, sans problème sociaux**
  - **Motif de consultation simple et aigu (<7 jours) et/ou chutes à répétitions.**

## 4.5. TRI VIOLET = ZONE 1

**VIOLET**

*Patient valide présentant un des motifs suivants :*

- Crise d'asthme
- Eruption cutanée supposée allergique récente et évolutive
- Douleur des organes génitaux externe (OGE).
- Patient arrivant pour un problème psychiatrique (sans problème somatique) ou **CPU psychiatrique.**
- Patient arrivant avec un diagnostic chirurgical **avéré**
- Patient adressé des urgences gynécologiques
- Patient reconvoqué par les urgences nécessitant des examens complémentaires (bilan sang, imagerie, un avis spécialisé ou une hospitalisation)

## 4.6. TRI BLEU = ZONE 1

**BLEU**

*Patient valide ne présentant ni signes de gravité, ni d'urgence*

- Plaies
- Trauma des extrémités avec fracture ou signes cliniques de fracture (déformation)
- Patient nécessitant un bilan sang et/ou un examen d'imagerie (TDM, Echo)
- Patient nécessitant un avis spécialisé

## 4.7. TRI VERT = MAO / ZONE 1

**VERT**

*Patient valide (avec un objectif de qualité institutionnelle de prise en charge ≤ à 1h30)*

- Traumatisme simple des extrémités (non fracturé) avec prescription de radios anticipées
- AES
- CNA
- Panaris collecté isolé
- Consultation simple ne pouvant être réorientée
- Patient reconvoqué (par les urgences) pour une simple consultation/ordonnance

# II. AIDE-MEMOIRE IOA

## 1. LE 3Q2C

**3Q2C**

Outil permettant de réaliser l'interrogatoire clinique

| | |
|---|---|
| **QUI** | Age, Sexe, ATCD, épisodes similaires, TTT Spécifiques |
| **QUOI** | Motif (attention peut être différent à l'arrivée) |
| **QUAND** | Date et heure de début |
| **COMMENT** | Facteurs déclenchants, circonstances, mode de début et d'évolution |
| **COMBIEN** | Intensité du symptômes, pics, évolution |

## 2. EXEMPLE D'UN MOTIF IOA

**IOA**

Exemple d'un recueil IOA

| | |
|---|---|
| Qui ? | Me W, 31 ans. |
| Quoi ? | Patiente vient pour douleurs au niveau de l'hypochondre droit. |
| Comment ? | Douleur d'apparition brutale ce jour vers 18h, avec nausées sans vomissements. |
| Quand ? | Pas de SFU, pas de troubles du transit associés.<br>DDR : Il y a 2 semaines, patiente sous contraception et pas de risque de grossesse. |
| Combien ? | A l'IOA, douleurs présente, intensifié à la palpation, sans irradiation.<br>Abdomen souple.<br>Présente des nausées. |

# 3. AIDE-MEMOIRE IOA

## 1-MALAISE

Avec prodromes : vertiges, douleur, nausées, bourdonnements d'oreilles…
Sans prodromes : **SYNCOPE** = patient scopé
Autres : TC, PC, Douleur thoracique
Soins particuliers: **ECG pour tous**, dextro

## 2-DOULEUR THORACIQUE

Type : pique, pince, serre, brûle…
Irradiation : bras, mâchoire, dos…
Autres : Localisation, présente à l'IOA, heure de début, durée, arrivée à l'effort ou au repos, continue ou discontinue, dyspnée associée, installation brutale ou progressive.
Facteurs de risque : Tabac, cholestérol, HTA, dyslipidémie, Diabète, Surpoids.
ATCD familiaux : IDM < 60ans
Soin particulier: **ECG**

Pour la douleur thoracique : Bien pensé aux facteurs de risques cardiovasculaire (Tabac, cholestérol, surpoids) et/ou ATCD familiaux → Tout patient présentant une douleur thoracique avec un facteur de risque cardiovasculaire doit être allongée.

Pour la douleur thoracique, penser à prendre la TA aux deux bras.

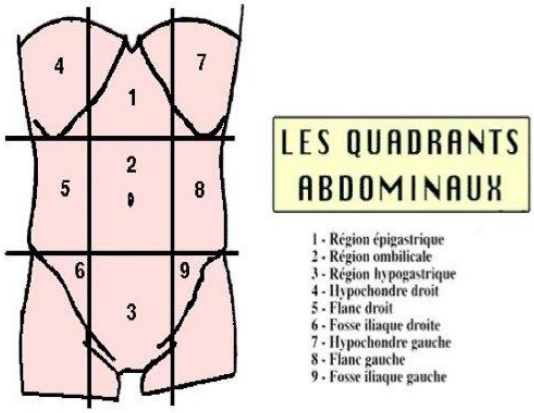
## 3-AVC-AIT

Alerte thrombolyse : Déficit <4h30
- AVC constitué
- AVC du réveil
- AIT

Symptômes :
Déficit moteur, sensitif, troubles du langage, troubles de la vision, pupilles symétriques et réactives, vertiges (type)
Soins (Hors alerte thrombolyse) :
Décubitus, Tension, Saturation, Pouls, Température, Dextro, Glasgow, Déshabillage
Soins (Alerte thrombolyse):
Idem + Décubitus 0° strict, Tension aux deux bras

## 4-DOULEUR ABDOMINALE

SFU : Brulures mictionnelles, Hématurie
Transit : Gaz ? Selles ? Diarrhées ?
Autres : Date des dernières règles, abdomen souple, tendu, douloureux à la palpation, nausées, vomissements, irradiation lombaire…
Localisation :




Soin particulier : BU

Pour les AVC/AIT : retenir que le patient doit être installé en position allongée à 0°C (voir 30°C maximum). Il est préférable de prendre la TA aux deux bras.

## 5-DYSPNEE

Signes cliniques :

- Signes de lutte respiratoire (tirage, balancement thoraco-abdominal, battement des ailes du nez, polypnée, bradypnée…)
- Autres : Marbrures, difficultés à la parole, cyanose, sueur, douleur thoracique associée…

ATCD : BPCO (saturation de base), Asthme
Soins particuliers : Saturation, Fréquence respiratoire

## 6-CRISE D'ASTHME

Nombres de crises, depuis combien de temps, observance du traitement, difficultés à la parole, signes de lutte respiratoire, hospitalisé en réanimation pour crise d'asthme
Soins particuliers : Saturation, Fréquence respiratoire, **Peakflow** (valeur de référence)

## 7-VERTIGES

**Eliminer AVC/AIT**
Appel MAO si vertiges < 4h30
Types (rotatoires, qui tanguent), positionnels ou pas, nausées/vomissements, suite TC

## 8-SAIGNEMENTS

Localisation : méléna, hématurie, hématémèse, hémoptysie,…
Autres : quantité, actif ou non, durée, avec ou sans ATC/AAP
Signes associés : marbrures, dyspnée, pâleur…
Soin particulier : Hemocue, FR

## 9-TRAUMA CRANIEN

Signes cliniques : Perte de connaissance (durée), nausées/vomissements, vertiges, troubles de la vision, signes neurologiques, ATC/AAP
Soin particulier : Glasgow

## 10-TRAUMA

Signes cliniques : Déformation, raccourcissement de membre, plaie ouverte, mobilité, sensibilité, pouls du membre en aval, couleur, chaleur

## 11-PLAIE

Localisation, suturale, taille, saignement actif, depuis combien de temps, mobilité, sensibilité, allure (écoulement, corps étranger…), **VAT**
Soins particulier : détersion, pansement humide provisoire, xylocaïne

## 12-AVP

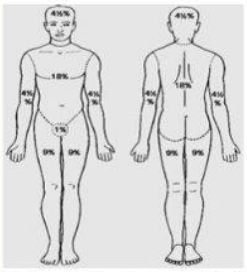
Cinétique (vitesse), ceinture, airbag déclenché, casqué, état du véhicule et du casque, PC initiale, amnésie des faits, TC, surveillance trauma abdominale et thoracique, douleur rachis, signes neurologiques
Soins particuliers : Hemocue, BU si nécessaire

## 13-DEXTRO

Pour tout patient si : vertiges, vomissements, malaise, diabétique, convulsions, troubles neurologiques, troubles du comportement

## 14-CETONEMIE

Pour tout dextro supérieur à 3g

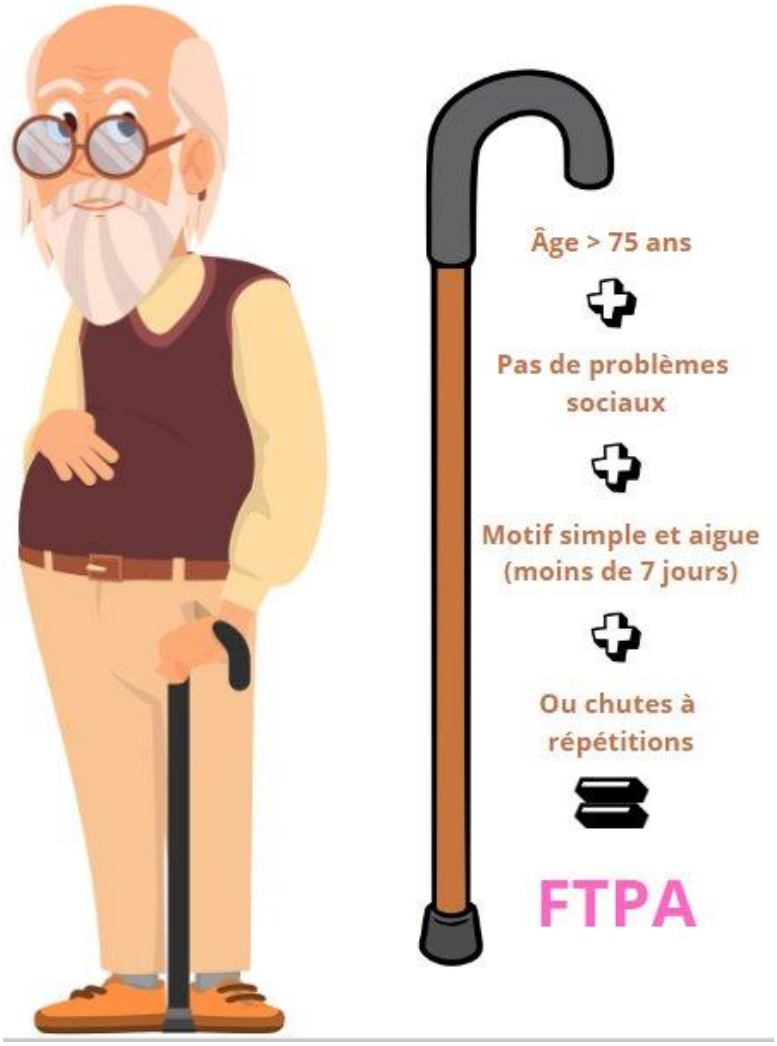
| 15-CEPHALEES | 16-BRULURES |
|---|---|
| Siège : hémicrânie, pariétal, occipital<br>Installation brutale ou progressive<br>**Rappel :** « Coup de tonnerre » = céphalée brutale<br>Type : pulsatile, continue | Localisation, surface, profondeur, inhalation de fumée, dyspnée, présence de suie dans les voies aériennes<br>Brûlure de 1er degré : Douleur, Erythème, Coup de soleil<br>Brûlure de 2e degré superficiel : Douleur intense, Aspect rosé, Phlyctène, Suintement<br>Brûlure de 2e degré profond : Douleur faible, Aspect rosé et blanc, Anesthésie partielle, Phanères adhérents<br>Brûlure de 3e degré profond : Absence de douleur, Aspect cartonné, Anesthésie complète, Phanères non adhérents<br>Evaluation de la surface corporelle brûlée :<br>La règle des 9 de Wallace :<br>  <br>Soins particuliers : Refroidir le zone<br>Brûlures éléctriques : rechercher le point d'entrée et de sortie, **ECG** |

# 4. DEUX SCORES A L'IOA

## 4.1. QSOFA



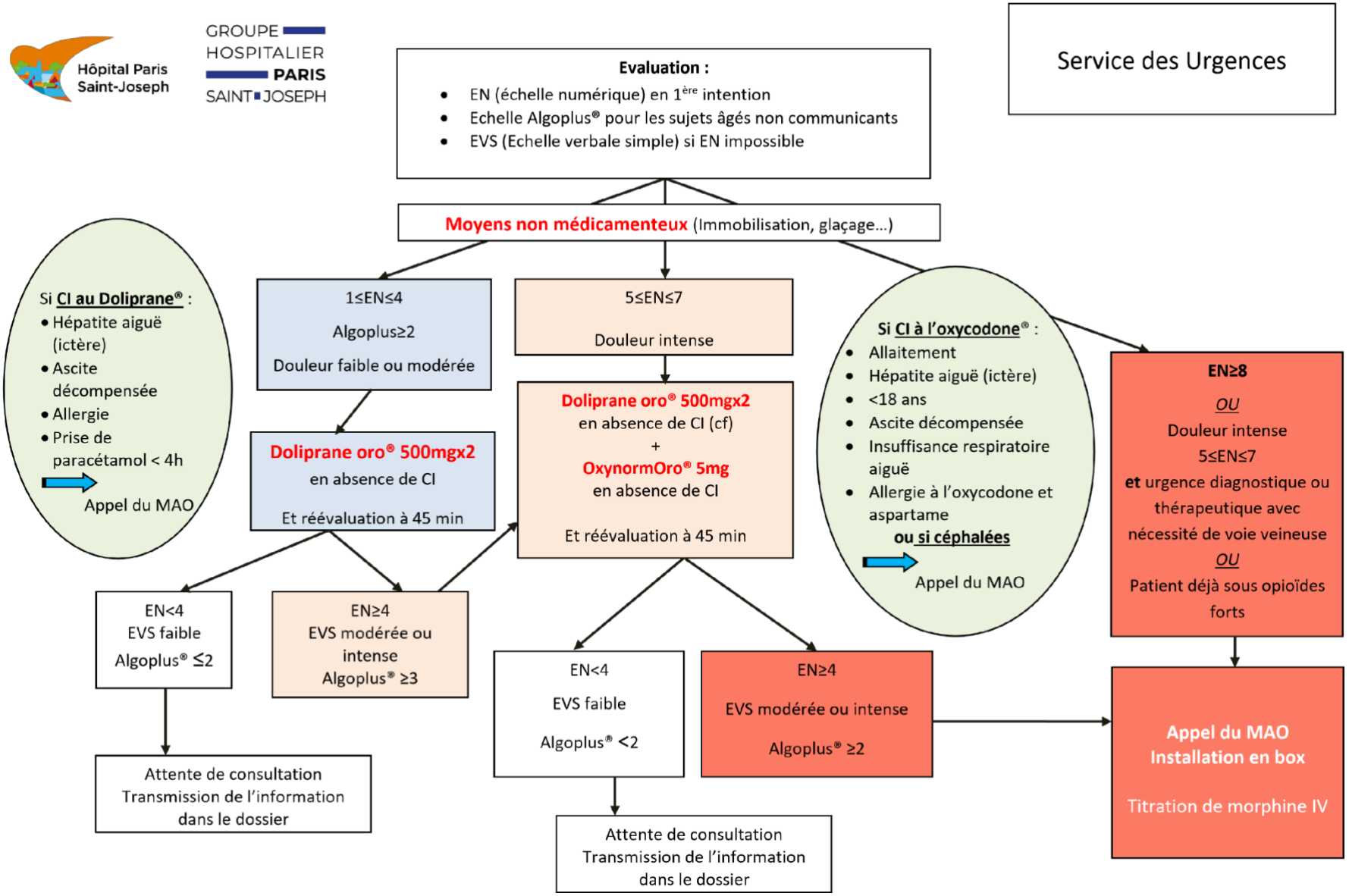
## 4.2. FTPA


Âge > 75 ans
Pas de problèmes sociaux
Motif simple et aigue (moins de 7 jours)
Ou chutes à répétitions
FTPA

Hôpital Paris Saint-Joseph

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH

Service des Urgences



# III. PROTOCOLES ET PROCEDURES SAU / IOA

## 1. AGRESSIONS SEXUELLES

| Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph | **AGRESSIONS SEXUELLES** | **Indexation : Urgences/I/PROT-114/27-08-2018** |
|---|---|---|
| | **Emetteur : Services des Urgences** | **Nombre de pages : 2**<br>**Date de création : Juin 2016** |
| | ***manuel de certification : V2014*** | |
| | rédigée par AL. GIOUX, IDE<br>Dr JL AIM | signature : ALG<br>JLA |
| | validée par Dr N.HOFFMANN | signature : NH |
| | approuvée par Dr O. GANANSIA | signature : OG |

**INFORMATIONS GENERALES :**

**Manuel de certification** : Prise en charge des urgences et des soins non programmés. Le recours aux avis spécialisés permettant de répondre aux besoins des patients est organisé et formalisé.
Les circuits de prise en charge sont définis *et formalisés selon le degré d'urgence et* la typologie des patients (soins immédiats, soins rapides non immédiats, patients debout, patients couchés, traumatologie, filières spécifiques, etc.).

**Objet :** Prise en charge des patients victimes d'agression sexuelle

**Prise en charge IOA**

- Tri vert – prise en charge totale <1h
- Installation box MAO ou box 6
- Examen par un médecin senior - en journée MAO ou médecin zone 1

**Prise en charge soignante**

- Ne pas laver ou laisser se laver le patient jusqu'à la consultation aux UMJ
- Préserver les habits portés lors de l'agression, manipuler avec des gants (conserver en sac vestiaire clos).
- Recueil d'urine à laisser au patient pour d'éventuels dosages de toxiques.

**Prise en charge médicale**

- examen somatique à la recherche de lésions traumatiques externes récentes ou gynécologiques nécessitant des soins urgents (plaies hémorragiques)
  - si possible, prise de clichés des lésions à insérer dans le dossier
  - pas d'examen gynécologique

- chez la femme :
    - prescription et délivrance si nécessaire d'une contraception orale post rapport, de type : Levonorgestrel (Norlevo) dans les 72h ou Ulipristal acétate (Ellaone 30) de 72h à 5j
- bilan AES - pré-thérapeutique et patient exposé (cf. protocole)
    - prescription et délivrance du traitement + feuille d'information
    - délivrance d'un Certificat médical initial
- inciter au dépôt de plainte, si acceptation :
    - appel du commissariat du 14e : 0153741406 pour déclencher la prise en charge (la police organisera la prise en charge aux UMJ après audition)
    - Appel des UMJ Hôtel Dieu 0142348700 (facultatif en fonction du contexte, rôle de la police)

En cas de refus de dépôt de plainte, considérer que la victime peut changer d'avis dans les jours à venir et maintenir l'ensemble de la prise en charge (hors appel police) et en lui expliquant les formalités de dépôt de plainte.

**DOCUMENTS A REMETTRE A LA SORTIE**

- CMI
- Courrier pour l'UMJ / double du dossier médical
- Fiche d'information « agression sexuelle »
- Fiche d'information AES

# 2. PEC DE FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH — Hôpital Paris Saint-Joseph

**PRISE EN CHARGE DE FEMMESVICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES**

**1URG-PRC-019**
**Version : 01**

| | |
|---|---|
| **Emetteur : Services des Urgences** | **Date d'application :** 28/01/2022 **Date de création :** Octobre 2021 |
| **Rédigée par : Dr. N. HOFFMANN urgentiste** | **Signature : NH** |
| **Validée par : Dr. JLAIM chef adjoint des urgences** | **Signature : JLA** |
| **Approuvée par : Dr. O. GANANSIA Chef de service desurgences** | **Signature : OG** |

**Objet :** gestion et prise en charge d'une femme victime de violence conjugale.Domaines

**d'application :** service des urgences

**Vocabulaire :** Femme, victime, violence, certificat descriptif, signalement,

**Documents de référence :**
HAS : Recommandations de bonne pratique.
CNOM : Secret médical et violences au sein du couple
Code pénal.

## Introduction :

Le rôle des urgences est important dans la prise en charge des personnes victimes de violences et en particulier des femmes victimes de violences conjugales.
Peu de femmes lorsqu'elles consultent aux urgences osent parler des violences qu'elles subissent, tout comme très peu de femmes osent porter plainte (moins de 20 %) Et lorsqu'elles le font, on se doit de savoir les prendre en charge de façon pluridisciplinaire.

## L'accueil par l'IAO :

Si une patiente consulte pour des violences conjugales, on la laisse parlerafin de savoir qu'elle est sa demande et de quoi elle a besoin.

- Il s'agit d'une victime, elle consulte pour des violences physiques, psychologiques ou sexuelles.
- Montrer de l'empathie
- Ecouter
- Prévenir le MAO, le psychiatre et l'assistante sociale.

Prise en charge à l'IAO identique que pour les autres patients
Puis installation directe dans un box pour prise en charge médicalepsychologique et sociale

## L'accueil par l'urgentiste :

1. **L'écoute :**
   Montrer de l'empathie et noter la demande de la victime et cedont elle a besoin.

2. **L'examen :**
   - Noter les doléances.
   - Prise en charge identique à toute victime : bilan lésionnel, imagerie si besoin, les soins et le traitement.
   - Faire une prise de photos datées et identifiées, avec l'accord de la victime et en conservant un double des photographies.
   - Si la victime signale une appréhension à son retour à domicile, la prise en charge par l'assistante sociale permettra de lui trouver unhébergement provisoire.

   Si c'est la nuit, on hospitalise la patiente aux lits d'urgences.

3. **le certificat médical :**
   La consultation et l'examen clinique sont un préalable indispensable à larédaction du certificat.
   Ce certificat est essentiel car il est une preuve qui pourra être utile si la patiente souhaite porter plainte et s'il y a une procédure judiciaire, même si la plainte est tardive.
   - Reporter les dires de la victime sur le mode déclaratif, au présent, entreguillemets ; " Mme X…dit avoir été victime de.... " "la victime déclare…" "selon les dires de la victime …"
   - Noter les doléances de façon exhaustive
   - **Décrire avec précision les lésions constatées**
   - **Préciser s'il y a aussi des violences psychologiques.**

4. **Prise en charge pluridisciplinaire :**
   - orientation vers les autres professionnelles
   - orientation vers le psychiatre ou l'IDE psy.
   - orientation vers l'assistante sociale

**Si prise en charge la nuit ou si absence de l'assistante sociale :**

**En cas de situation jugée grave :**

- Conseiller de déposer plainte auprès de la police ou de la gendarmerie.
- Informer du droit de quitter le domicile conjugal avec les enfants, en le signalant à la police (main courante) ou à la gendarmerie.
- Informer du droit de saisir en urgence le juge aux affaires familiales, même sans dépôt de plainte, pour demander une ordonnance de protection.
- Décider d'une hospitalisation des enfants pour protection et évaluation.
- Si besoin faire un signalement avec l'accord de la victime, pour porterà la connaissance du procureur de la république les sévices ou privation constatés, sans nommer l'auteur des faits ; mais cet accord n'est pas nécessaire si la victime est un mineur, une personne vulnérable ou un majeur en danger immédiat et placé dans l'incapacité de se protéger en raison de la contrainte morale résultats de l'emprise exercée par l'auteur des violences (article 226-14 du code pénal)

*" La loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales étend les possibilités de signalement des violences conjugales par les médecins, dans un cadre bien précis "*
**Modèle de signalement au procureur de la république sont disponible sur le site internet du conseil national de l'ordre des médecins.*

# 3. PEC D'UNE VICTIME D'AGRESSION SEXUELLE

**PRISE EN CHARGE D'UNE VICTIME D'AGRESSION SEXUELLE**

**1URG-PRT-022**
**Version : 01**

| | |
|---|---|
| **Emetteur : SJ - Urgences** | **Date d'application : 20/07/2021** |
| Rédigée par : Dr. N. HOFFMANN | signature : NH |
| Validée par : Dr. JL.AIM | signature : JLA |
| Approuvée par : Dr O. GANANSIA | signature : OG |
| **Objet : Protocole à mettre en place en cas de patients victimes d'agression sexuelle.**<br>**Domaines d'application : Service des urgences : IOA. IDE des urgences. Médecins urgentistes. Médecin psychiatres. Psychologues.**<br>**Vocabulaire : Agression sexuelle, viol, coups et blessures, grossesse, sérologie, certificat médical descriptif.**<br>**Documents associés ou de référence : Code pénal. Recommandations UMJ.** | |

**Rappel :**
**Constitue une agression sexuelle " toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise " (article 222-22 du code Pénal). "C'est un délit pouvant entraîner une peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et à une amende de 75 000 Euros."**
**Peuvent relever de l'agression sexuelle, par exemple, des caresses non consenties sur la poitrine ou sur les fesses, des baisers forcés enfin tous les attouchements sexuels.**

**Est considéré comme viol "tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise (Art 222.23 code pénal). C'est un crime pouvant entrainer une peine allant jusqu'à 15ans d'emprisonnement."**
**Tous les actes de pénétration sexuelle sont visés, qu'elle soit buccale, vaginale, anale, avec le sexe, le doigt ou un objet.**

## Prise en charge aux urgences d'une personne victime d'un viol :

Il s'agit d'une urgence thérapeutique, judiciaire et psychologique, en général les faits sont récents, dans les 48 heures.

1- Installation rapide dans un box avec nécessité d'une attention particulière de l'équipe.
2- Mettre en confiance et recueillir les dires de la victime.
3- Expliquer à la victime qu'il existe des structures spécialisées avec une prise en charge adaptée et des soins appropriés.
4- Encourager fortement la victime à porter plainte.

## Deux situations vont se présenter :

### I- La victime accepte de déposer plainte :

1- Appeler le commissariat de police du 14e : 01.53.74.14.50 ou 51 pour déclencher la prise en charge médico-judiciaire qui se fera au commissariat

2- Les faits étant récents dans les 48 heures, c'est une urgence.

3- La victime quitte le service des urgences en compagnie des policiers avec :
Le compte rendu de la prise en charge initiale aux urgences
Et le certificat descriptif des lésions physiques constatées.

4- L'OPJ, après audition au commissariat, organisera la prise en charge aux UMJ, en délivrant une réquisition pour le médecin de l'UMJ.

### II- La victime refuse de déposer plainte :

1- Ne pas hésiter à insister sur l'importance du dépôt de plainte.

2- Lui expliquer que nous allons procéder à une prise en charge qui lui permettra si elle change d'avis, d'avoir toutes les données en rapport avec l'agression.

3- Lui expliquer que si elle change d'avis, elle peut à tout moment aller dans un commissariat ou gendarmerie pour déposer une plainte. Après avoir été entendu (audition) par le policier ou le gendarme, une réquisition lui sera donnée pour une consultation dans une unité médico judiciaire (UMJ) qui est sur RDV.

4- Faire un examen somatique complet à la recherche de lésions traumatiques externes récentes témoins de violences et nécessitant des soins urgents. (Plaies, ecchymoses, hématomes, fracture…)

5- Pas d'examen gynécologique aux urgences, sauf nécessité absolue d'hospitaliser la victime pour lésion importante. Il se fera à l'UMJ si la patiente dépose plainte ultérieurement.

6- Prendre des photos les mettre dans le dossier, et prendre aussi des photos avec le téléphone de la victime afin qu'elle puisse les avoir aussi avec elle.

7- Expliquer à la victime l'importance de récupérer les vêtements et sous-vêtements, si elle ne les a pas changés depuis l'agression. (Pas de toilettes intimes aux urgences, y compris pour BU) La présence de taches de sang ou de sperme ou de poil sur les vêtements (preuves ADN) impose de conserver ceux-ci avec des gants dans un sac en papier (disponible au bureau MAO) aux fins d'une analyse ultérieure par un laboratoire de police technique et scientifique.

8- Faire un bilan type : AES + bilan pré thérapie avec consentement de la victime.

9- Si suspicion de soumission chimique, faire recherche de toxiques et de stupéfiants.

10- Faire la recherche d'IST gonocoque et chlamydiae dans les urines. Recueillir le début du premier jet d'urine : 10 ml du flux d'urine initial dans le flacon stérile. Les envoyer. Si résultats positifs, la victime sera contactée pour le traitement.

11- Débuter le traitement d'urgence et les mesures préventives :

a- La prévention d'une grossesse par l'administration dans les 72 heures de Lévonorgestrel (Norlevo), ou Ellaone entre 72h et 05 jours à donner sur place aux urgences.

b- Indications du traitement anti - rétroviral dans les 48 heures après l'agression, à commencer sur place aux urgences (protocole AES)

c- Une prévention de la séroconversion de l'hépatite B peut être réalisée dans les 48 heures suivant l'agression si la victime n'est pas vaccinée et le statut sérologique de l'agresseur présumé inconnu. Elle comporte une sérovaccination par immunoglobulines anti-HBs et l'injection d'une dose de vaccin dans un autre site.

12- Rédaction d'un certificat descriptif exhaustif.

13- Le certificat médical descriptif est remis à la personne examinée, et à elle seule. Les parents peuvent demander qu'un certificat médical leur soit remis à l'issue de l'examen de leur enfant mineur (si grand mineur, avec son accord)

14- Remettre aussi : Fiche d'information AES et fiche d'information de conseils AS.

## Autre cas :

**Cas 1**

Une personne se présente aux urgences pour signaler qu'elle a été victime d'une agression sexuelle (attouchements, caresses…), donc pas de pénétration, ce n'est pas un viol.

**CAT :**

- L'accueillir comme une consultation habituelle, il ne s'agit plus d'une urgence.
-Insister sur le fait qu'elle doit déposer une plainte auprès du commissariat ou gendarmerie de son choix.
-Lui expliquer les démarches (commissariat, plainte, UMJ)
-Faire son dossier médical des urgences qui va tracer son passage.
-Lui remettre un certificat médical qui notifie sa déclaration avec description des lésions ou traces cicatricielles si constatées.

**Cas 2**

Une personne se présente aux urgences pour déclarer qu'elle a été victime d'un viol qui remonte à plusieurs jours ou plusieurs mois.
Prise en charge idem que cas 1.

- La victime doit savoir qu'en France :
Le délai de prescription pour les viols sur majeur est de 20 ans.
Pour les viols sur des mineurs, il est de 30 ans à partir de la majorité de l'enfant.

# 4. ANALGESIE POUR ACTE DE TRAUMATOLOGIE DOULOUREUX CHEZ L'ADULTE AU SAU

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH — Hôpital Paris Saint-Joseph

**ANALGESIE POUR ACTE DE TRAUMATOLOGIE DOULOUREUX CHEZ L'ADULTE AU SAU**

1URG-PRT-042
Version : 01

| | |
|---|---|
| **Emetteur : Service Accueil des Urgences** | **Date d'application : 25/01/2022**<br>**Date de création : juin 2012** |
| Rédigé par : Dr Maylis Huet, urgentiste | Signature : MH |
| Validé et approuvé par : Dr. Olivier GANANSIA | Signature : OG |

**INFORMATIONS GENERALES :**

**Références législatives :**

Article L.1110-5 du code de la santé publique (loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé)
Décret N° 2004- 802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires du CSP et modifiant certaines dispositions de ce code)
Article R4311-5 du Code de la Santé Publique (rôle propre infirmier)
Article R4311-7du Code de la Santé Publique (rôle infirmier sur prescription médicale)
Article R4311- 8 du Code de la Santé Publique (prise en charge de la douleur)
Article R. 4311-14 du Code de la Santé Publique (protocoles de soins d'urgence)Article R4321-9 du Code de la Santé Publique (masseurs kinésithérapeutes)
Circulaire n° 98/94 du 11 février 1999 relative à la mise en place de protocoles de prise en charge de la douleur aiguë par les équipes pluridisciplinaires médicales et soignantes dans les établissements de santé et institutions médico-sociales

**Références bibliographies :**

Recommandations formalisées d'experts 2010, Sédation et Analgésie en structure d'Urgence
Fitch RW, Kuhn JE, Intraarticular lidocaine versus intravenous procedural sedation with narcotics and benzodiazepines for reduction of the dislocated shoulder: a systematic review. Acad Emerg Med. 2008 Aug ;15(8):703-8

**Documents associés :**

Protocole « Utilisation du MEOPA
»Protocole « Titration morphinique

**Objet :**

Protocole de prise en charge du patient : analgésie pour acte de traumatologie douloureux chez l'adulte

**Domaines d'application :** Service d'Accueil des Urgences

## PRINCIPES DE PRISE EN CHARGETRI

## IAO

**RECONNAITRE LA DEFORMATION ET LA DOULEUR CARACTERISTIQUES**

- **Niveau 1 (prise en charge immédiate) :** Polytraumatisé
- **Niveau 2 (prise en charge<20 min) :** EN ≥ 6, lésion cutanée menaçante, lésion vasculaire menaçante, déficit neurologique
- **Niveau 3 (prise en charge<1 heure) :** EN < 6, pas de déformation visible

## IDE Installation en box

- Evaluer (échelle numérique EN) et soulager la douleur : palier 1 pour tous
- Bilan préopératoire sur le membre non déformé avec pose de VVP
- Antalgie immédiate par MEOPA si EN ≥ 6 (cf protocole MEOPA)

## POUR LE MEDECIN

**APPRECIER LA GRAVITE, POSER UNE INDICATION DE REDUCTION EN URGENCE**

- Risque vasculo-nerveux
- Risque cutané et septique
- Douleur

## ANALGESIE POUR REDUCTION :

***En présence de personnel formé le geste sera encadré d'une hypnoanalgésie.***

- **EN < 6 : palier 1 + MEOPA : Inhalation à débuter 5 minutes avant le geste**

Contre-indications MEOPA : HTIC, troubles de conscience non évalués, pneumothorax, bulles d'emphysème, distensions gazeuses abdominales, fractures des os de la face, nécessité d'oxygénothérapie en O2 pur.

- **EN ≥ 6 : palier 1 + Morphine titrée selon protocole + MEOPA**

**Sauf si Cl créatinine ≤ 30 ml/min : appel anesthésiste.**

**Objectif = EN < 3 à la mobilisation avant tentative de réduction**

Si échec malgré analgésie bien conduite : **MIDAZOLAM 1mg IV** pour traiter agitation et contracture musculaire sous SCOPE en présence permanente du médecin senior → Surveillance rapprochée de l'effet dépresseur respiratoire et prolongée ++ (scope = 2 heures)

**Si besoin, contrôle des nausées liées aux morphiniques par antagonistes 5HT3 (Zophren 4mg IV)**

## SURVEILLANCE

**EN et Score de sédation** pendant la titration (cf protocole titration de morphine IV)
Maintien du **contact avec le patient** pendant le MEOPA
**Scope** pendant titration de morphine, sortie vers un service non monitoré 1h après dernière injection de morphine, **aptitude à la rue 2h après dernière injection IV** de morphine/ midazolam

# 5. DELIVRANCE D'ANTALGIQUES PAR L'INFIRMIER A L'ACCUEIL DES URGENCES

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH — Hôpital Paris Saint-Joseph

**DELIVRANCE D'ANTALGIQUES PAR L'INFIRMIER A L'ACCUEIL DES URGENCES**

**1URG-PRC-015**
**Version : 01**

| **Emetteur : Service d'Accueil des Urgences** | **Date d'application : 17/01/2022** |
|---|---|
| ***Manuel de certification : V2022*** | |
| Rédigé par Dr A. PARIENTE urgentiste | Signature : AP |
| Validée par Dr M. LOUBIERE interniste | Signature : ML |
| Approuvé par Dr. O GANANSIA chef de service des urgences | Signature : OG |

**INFORMATIONS GENERALES :**

*Manuel de certification : Critère 12a (PEP) « Des protocoles analgésiques issus des recommandations de bonne pratique et adaptés au type de chirurgie pratiquée, à la pathologie donnée, aux types de patients, à la douleur induite par les soins sont définis ».*

**Objet :** Modalités de délivrance anticipée d'antalgiques à l'accueil des urgences par l'infirmier d'organisation de l'accueil (IOA)

**Domaines d'application :** IOA, infirmiers des urgences, médecin régulateur des Urgences

**Documents associés ou de référence :**

- Protocole titration morphinique CLUD/T/PROT-001/10-07-2009
- Echelle ALGOPLUS
- Algorithme de délivrance d'antalgiques à l'IOA selon intensité douloureuse
- **Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 :**

- art R.4311-2 : « Les soins infirmiers…ont pour objet (…) de participer à la prévention, àl'évaluation et au soulagement de la douleur (…) »
- art R.4311-5 : « Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants (…)° : « (…) l'évaluation de la douleur »
- art R.4311-8 : « L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers. »

- Oral versus intravenous opioid dosing for the initial treatment of acute musculoskeletal pain in the emergency department. Acad Emerg Med. 2008 Dec;15(12):1234-40. Miner JR, Moore J, Gray RO, Skinner L, Biros MH.
- Use of oxycodone in polytrauma patients: the "Gemelli" experience. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2008 Mar-Apr;12(2):123-6. Franceschi F, Marini M, Ursella S, Carbone L, Candelli M, PignataroG, Gabrielli M, Santarelli L, Ojetti V, Giupponi B, Fiore V, Barbaro F, De Marco G, Buccelletti F, Mancini F, Roccarina D, Gigante G, Gasbarrini A, Gasbarrini G, Silveri NG.
- Recommandations formalisées d'experts SFAR-SFMU 2010 : Sédation et Analgésie en Structure d'Urgence

## EVALUATION DE LA DOULEUR :

- EN (échelle numérique) en 1ère intention
- Echelle Algoplus pour les sujets âgés non communicants
- EVS (Echelle verbale simple) si EN impossible

## Douleur faible ou modérée, EN entre 1 et 4, Algoplus ≥ 3

- Moyens non médicamenteux (immobilisation, positionnement, glaçage, réassurance, orthèse…)
- Proposition de délivrance de Paracetamol **Oro® 500mgx2 ou gelules**
- Sauf si contre-indications : appel du médecin régulateur
  - Hépatite aiguë (ictère)
  - Ascite décompensée
  - Allergie
- Sauf si prise de paracétamol<4h : appel du régulateur
- Réévaluation à 45 minutes
  - Patient soulagé (EN<4, EVS faible, Algoplus ≤2) : Transmission de l'informationdans le dossier et attente de la consultation
  - Patient non soulagé (EN≥4, EVS modérée ou intense, Algoplus ≥3) : proposer **Oxynormoro® 5mg** sauf contre-indications (appel du médecin régulateur) :
    - Hépatite aiguë (ictère)
    - Ascite décompensée
    - Insuffisance respiratoire aiguë
    - Bradypnée (FR < 12/min)
    - Somnolence
    - Grossesse ou allaitement (contre-indication relative)
    - Allergie à l'oxycodone et aspartame

## Douleur intermédiaire, EN entre 5 et 7

- Moyens non médicamenteux (immobilisation, glaçage…)
- Proposition de délivrance d'**Oxynormoro® 5mg,** sauf contre-indications (appel du médecin régulateur) :
  - Hépatite aiguë (ictère)
  - <18 ans
  - Ascite décompensée
  - Insuffisance respiratoire aiguë
  - Bradypnée (FR < 12/min)
  - Somnolence
  - Grossesse ou allaitement (pas une contre-indication absolue)
  - Allergie à l'oxycodone et aspartame

  + **Doliprane Oro® 500mgx2**, sauf si contre-indications (appel du médecin régulateur) :
  - Hépatite aiguë (ictère)
  - Ascite décompensée
  - Allergie
  - Prise de paracétamol<4h

- Réévaluation de la douleur à 45 minutes
  - Patient soulagé (EN<4, EVS faible, Algoplus ≤2) : Transmission de l'informationdans le dossier et attente de la consultation
  - Patient non soulagé (EN≥4, EVS modérée ou intense, Algoplus ≥3) : appel du médecin régulateur et installation en box

## EN ≥ 8 OU Douleur intense 5 ≤ EN ≥ 7 et urgences diagnostique ou thérapeutique avec nécessité de voie veineuse OU Patient déjà sous opioïdes forts

Appel du médecin régulateur et installation en box pour titration de morphine intraveineuse

2mg toutes les 5 minutes en IV si poids <60kg, 3mg si>60kg

(surveillance scopée + conscience et FR)

Surveillance = minimum 3minutes après le dernier bolus de morphine.

# 6. PEC DE LA DOULEUR CHEZ L'ENFANT ACCUEILLI AUX URGENCES

| Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph | **Prise en charge de la douleur chez l'enfant accueilli aux Urgences** | **Indexation : Urgences/T/PROT-039/15-06-2016** |
|---|---|---|
| | **Emetteur : Service des urgences** | **Nombre de pages : Nombre d'exemplaires :** |
| | ***manuel de certification : V2010*** | |
| | rédigée par M. D'USSEL | signature : MDU |
| | validée par O. GANANSIA<br>E. WALTER | signatures : OG<br>EW |
| | approuvée par le CLUD | signature : CLUD |

**INFORMATIONS GENERALES :**

**Manuel de certification** : Critère 12a (PEP) « Des protocoles analgésiques issus des recommandations de bonne pratique et adaptés au type de chirurgie pratiquée, à la pathologie donnée, aux types de patients, à la douleur induite par les soins sont définis. »

**Objet :** Evaluation et traitement de la douleur de l'enfant pris en charge dans le service des urgences du GHPSJ

**Domaines d'application :** Tous les enfants de moins de 15 ans et 3 mois, accueillis aux Urgences, et présentant une douleur.

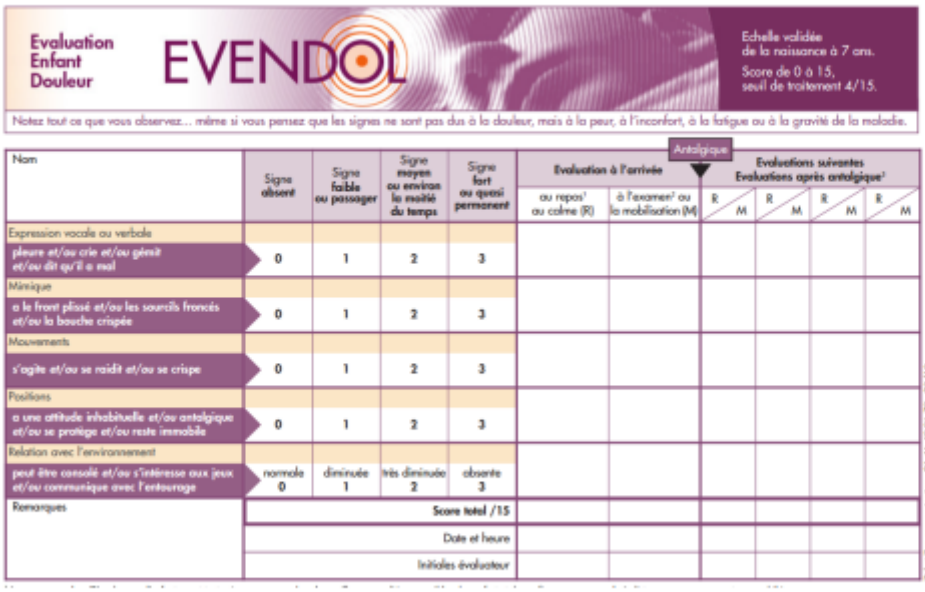
**Documents associés :**
-Protocole Utilisation du MEOPA chez l'adulte
-Protocole : Naloxone-Utilisation pour antagonisation des opioïdes en cas de surdosage

**Documents de référence :**
-Recommandations de la HAS : Prise en charge médicamenteuse de la douleur chez l'enfant : alternatives à la codéine, janvier 2016
-Douleur de l'enfant- l'essentiel, Guide de poche, Pediadol :
http://www.pediadol.org/IMG/html/guide_essentiel-ebook.html
-Archives de Pédiatrie *2006 ; 16 (922) : 129-30*
-Archives de Pédiatrie *2012 ; 19 (922) : 42-44*
-Journées Paris Pédiatrie *2009 : 265-76*
-Pain *2012 ; 153 : 1573-82*
-Veyckemans F. Posologie du paracétamol IV chez le nouveau-né et le nourrisson de moins de 10kg. *Arch Ped* 2014 ; 21 (9) : 932-33

**Destinataires :** IDE et médecins du service des Urgences

## EVALUATION :

- De la naissance à 7 ans : **échelle EVENDOL** (seuil de positivité : ≥4)



Evaluation Enfant Douleur

EVENDOL

Echelle validée de la naissance à 7 ans.
Score de 0 à 15, seuil de traitement 4/15.

Notez tout ce que vous observez... même si vous pensez que les signes ne sont pas dus à la douleur, mais à la peur, à l'inconfort, à la fatigue ou à la gravité de la maladie.

| Nom | Signe absent | Signe faible ou passager | Signe moyen ou environ la moitié du temps | Signe fort ou quasi permanent | Evaluation à l'arrivée au repos[1] ou calme (R) | Evaluation à l'arrivée à l'examen[2] ou la mobilisation (M) | Antalgique — Evaluations suivantes Evaluations après antalgique[3] R/M | R/M | R/M | R/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expression vocale ou verbale | | | | | | | | | | |
| pleure et/ou crie et/ou gémit et/ou dit qu'il a mal | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| Mimique | | | | | | | | | | |
| a le front plissé et/ou les sourcils froncés et/ou la bouche crispée | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| Mouvements | | | | | | | | | | |
| s'agite et/ou se raidit et/ou se crispe | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| Positions | | | | | | | | | | |
| a une attitude inhabituelle et/ou antalgique et/ou se protège et/ou reste immobile | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| Relation avec l'environnement | | | | | | | | | | |
| peut être consolé et/ou s'intéresse aux jeux et/ou communique avec l'entourage | normale 0 | diminuée 1 | très diminuée 2 | absente 3 | | | | | | |
| Remarques | Score total /15 | | | | | | | | | |
| | Date et heure | | | | | | | | | |
| | Initiales évaluateur | | | | | | | | | |

Zdl et Zer communication 01 46 49 06 79 05/12

- A partir de 8 ans : **échelle numérique (EN)**

« On peut donner une note à la douleur entre 0 et 10 : À 0 tu n'as pas mal, à 10 tu as très très mal, c'est une très forte douleur ; peux-tu me dire à combien tu as mal ? »

*Éviter des descriptions inquiétantes ou exagérées de la borne haute, rester très neutre.*

## TRAITEMENT

1. Evendol<4 ou EN<3 : pas de traitement
2. Evendol≥4 ou EN≥3 : paracétamol + AINS
3. Evendol>7 ou EN>5 : morphine orale

- **Paracétamol**
  - Voie orale : Doliprane® sirop (1dose-poids par prise=15mg/kg/prise toutes les 6 heures)
  - Voie intraveineuse : Paracétamol : Solution pour perfusion 10 mg/ml (poche de 100ml : retirer le volume excédentaire pour ajuster la posologie): IVL en 15 minutes car irritant pour les veines : 15 mg/kg/6 h

- **AINS** (Contre-indication en cas de varicelle)
  - Voie orale : Ibuprofène Nurofenpro® sirop 1 dose poidsx3/j (=10mg/kg/prise) ou Ibuprofène 200mgx3/j si poids>20kg, ou 400mgx3/j si > 40kg
  - Voie intraveineuse : pas d'AMM

- **Morphine**
  - Voie orale : Oramorph solution buvable 20mg/ml : 1 goutte=1.25mg
    Posologie 0,2mg/kg/4h (dose de charge possible à double dose en cas de douleur très intense)

| Poids de l'enfant | Posologie |
|---|---|
| 5kg-10kg | 1 goutte |
| 11-15kg | 2 gouttes |
| 16-20kg | 3 gouttes |
| 21-28kg | 4 gouttes |
| 29-34kg | 5 gouttes |
| 35-40kg | 6 gouttes |
| 41-46kg | 7 gouttes |
| 47-53kg | 8 gouttes |
| 54-58kg | 9 gouttes |

    Surveillance de la sédation et de la FR (fréquence respiratoire)

  - Voie intraveineuse : titration
    Toujours utiliser une valve anti reflux
    Dose de charge 0.05 mg/kg IVD (max 4 mg)
    Puis 0.025mg/kg toutes les 5 minutes jusqu'à analgésie suffisante et absence de signes de surdosage

  - Protocole Naloxone (cf) en cas de
    - Somnolence (enfant difficilement réveillable)
    - Bradypnée : FR<10/min (> 6 ans); FR<15/min (1-5 ans), FR<20/min (<1 an)
    - Désaturation SaO2<96%
    - Diluer une ampoule de 400µg de Naloxone dans 9 ml de sérum physiologique et injecter ml par ml jusqu'à récupérer une conscience et une FR normales

- **MEOPA (mélange équimolaire d'oxygène et de protoxyde d'azote (cf protocole)**
  Entraîne une sédation légère, une antalgie et une anxiolyse
  Démarrer le soin après 3 à 4 minutes de ventilation et poursuivre l'inhalation pendant tout le soin

# 7. CAT EN CAS DE NON REPONSE A L'APPEL D'UN PATIENT PAR UN PERSONNEL DES URGENCES

| Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph | **CONDUITE A TENIR EN CAS DE NON REPONSE A L'APPEL D'UN PATIENT PAR UN PERSONNEL DES URGENCES** | **Indexation : Urgences/I/PROC-046/03-01-2019** |
|---|---|---|
| | **Emetteur : Service des Urgences** | **Nombre de pages : 2**<br>**Date de création : mars 2014**<br>**Nombre d'exemplaires : 1** |
| | ***manuel de certification : V2014*** | |
| | rédigée par<br>C.Bertin<br>A. Boureau | signature :<br>CB<br>AB |
| | validée par O.Ganansia | signature : OG |
| | approuvée par O.Ganansia | signature : OG |

**INFORMATIONS GENERALES :**

**Manuel de certification** :

**Objet :** Cette procédure présente la conduite à tenir lorsqu'un patient, appelé par un personnel du Service des Urgences, ne répond pas. Elle doit impérativement être appliquée 24h/24 et 7j/7.

**Domaines d'application :** Service des Urgences

**Vocabulaire :**

**Documents associés ou de référence :**

**CONDUITE A TENIR :**

**Cas A : patient non inscrit administrativement**

1) Appel du patient dans la zone d'attente dans laquelle il est censé se trouver (*communiqué par les agents d'accueil, en fonction de son mode d'arrivée*)
2) En cas de non réponse, appel et recherche du patient dans toutes les zones d'attente du service.

**Cas B : patient déjà inscrit administrativement**

1) Recherche du patient sur le logiciel de géolocalisation
2) Appel oral du patient dans la salle d'attente où ce dernier est censé être installé (*en fonction de son tri défini par l'Infirmière Organisatrice de l'Accueil et/ou en fonction de l'avancement de sa prise en charge au sein du Service des Urgences*).
3) En cas de non réponse, appel et recherche du patient dans toutes les zones d'attente du service.

**Dans tous les cas :**

1) Consulter l'agent d'accueil afin de tenter de recueillir si possible la description la plus précise possible du patient ainsi que son mode d'arrivée (propres moyens, pompiers, ambulances …).

2) Rechercher également à l'extérieur du service, en particulier devant le service : alentours du sas « pompiers » et alentours du sas « patients valides »

3) Poursuivre les recherches en contrôlant les bracelets d'identification et en réveillant tout patient paraissant assoupi, susceptible de correspondre au patient recherché (à minima le sexe, en demeurant vigilants aux éléments de description physiques pouvant induire en erreur).

4) Vérifier visuellement que le patient ne se trouve pas dans les toilettes. En cas de non réponse, face à une porte de toilettes verrouillée de l'intérieur, faire procéder à son ouverture en urgence par le service de sécurité ou par tout moyen utile.

5) Si le patient est en cours de prise en charge, vérifier qu'il ne se trouve ni en imagerie centrale, ni au plateau technique (doppler…), ni en examen dans un autre service.

6) Si au terme de ces recherches le patient demeure introuvable :

   - **Si le patient n'a pas encore été vu par un médecin**, informer aussitôt le médecin régulateur afin de déterminer si son motif de recours indique la possibilité d'un risque pour le patient ou pour autrui, et qui déterminera s'il s'agit d'une sortie à l'insu du service (départ avec refus d'attendre les soins) ou bien s'il s'agit d'une fugue.

     **Dans ce cas**, appliquer la procédure disponible sur l'Intranet (alerter encadrement et sécurité en donnant les éléments de description physique du patient ainsi que l'heure la plus précise possible du constat de sortie ; faire remplir les documents au médecin régulateur).

   - **Si un médecin a débuté la prise en charge du patient**, l'informer aussitôt. Celui-ci déterminera si l'état de santé physique et/ou mentale du patient présente potentiellement un risque pour lui-même ou pour autrui. Il déterminera également s'il s'agit d'une sortie à l'insu du service ou bien s'il s'agit d'une fugue.

     **Dans ce cas,** appliquer la procédure disponible sur l'Intranet (alerter encadrement et sécurité en donnant les éléments de description physique du patient ainsi que l'heure la plus précise possible du constat de sortie ; faire remplir les documents au médecin en charge du patient).

**Notification**

**La notion de recherche, avec les horaires et la décision retenue, doit être notifiée dans le dossier informatique Dxcare, soit dans la fiche IOA soit dans l'observation médicale.**

# 8. CAT DEVANT UNE PERSONNE OCCUPANT LA SALLE D'ATTENTE DU SAU SANS DEMANDE DE PEC MEDICALE

| Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph | **Conduite à tenir devant une personne occupant la salle d'attente du SAU sans demande de prise en charge médicale** | **Indexation : Urgences/I/PROC-066/18-09-2017** |
|---|---|---|
| | **Emetteur : Service des Urgences** | **Nombre de pages : 2**<br>**Date de création : 25/03/2012** |
| | ***manuel de certification : V2014*** | Critère 6.a: Sécurité des biens et des personnes<br>Critère 19.a: Population nécessitant une prise en charge particulière<br>Critère 25.a: Prise en charge des urgences et des soins non programmés |
| | rédigée par Cyrille BERTIN<br>*Cadre de santé du SAU* | signature : CB |
| | validée par Olivier GANANSIA<br>*Chef de service du SAU* | signature : OG |
| | approuvée par Jean Patrick LAJONCHERE<br>*Directeur général de l'établissement* | signature : JPL |

**INFORMATIONS GENERALES :**

**Objet :**
Cette procédure a pour objet de définir la conduite à tenir devant une personne occupant la salle d'attente du SAU SANS demande de prise en charge médicale. Cette présence détourne la salle d'attente des urgences de sa mission de soins pour les patients.

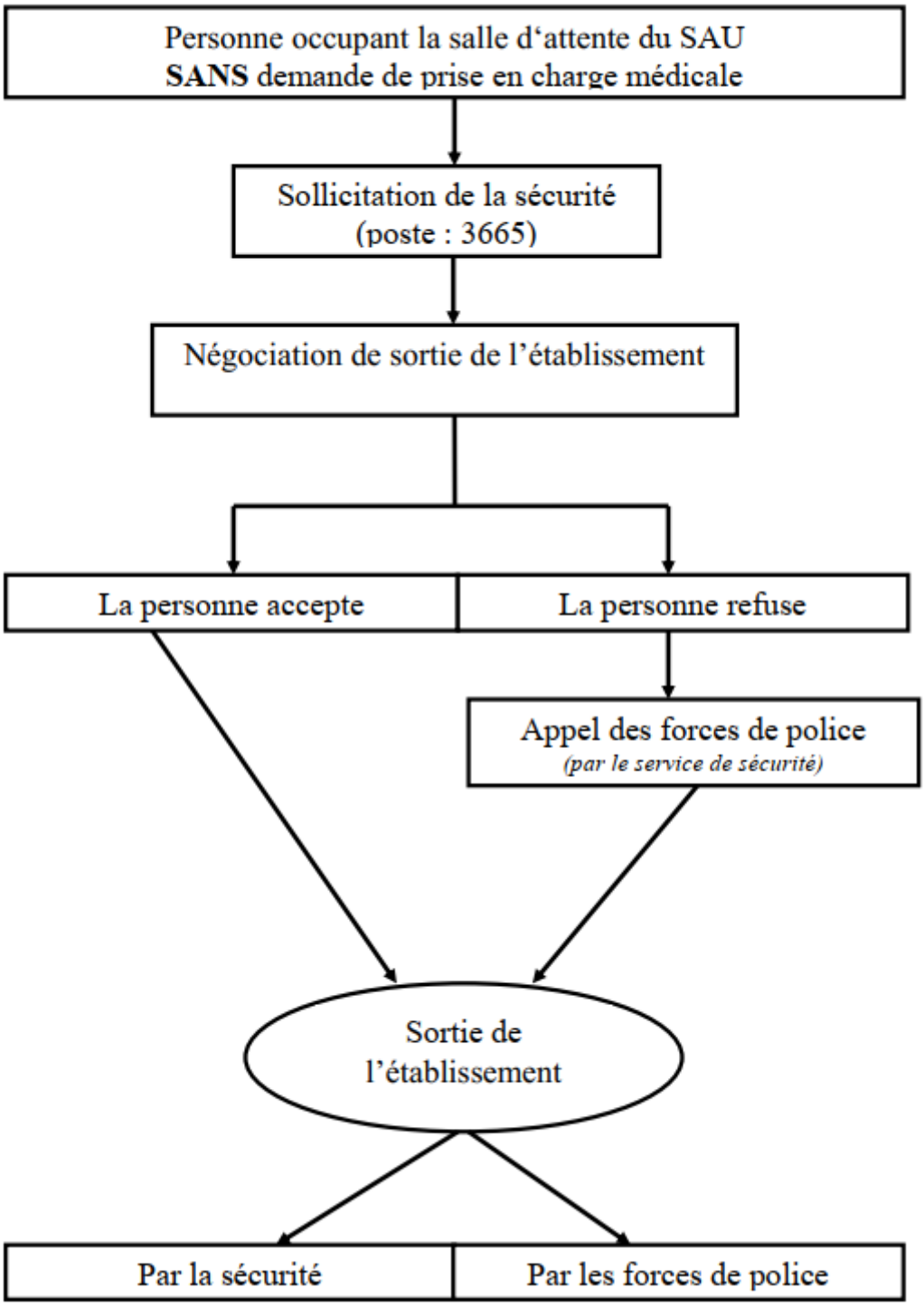
**Domaines d'application :**
Tous les professionnels intervenant dans le circuit de prise en charge des patients au service d'accueil des urgences (jour et nuit).

**Vocabulaire :**
SAU : Service d'Accueil des Urgences
IAO : Infirmière d'Accueil et d'Orientation

**Documents associés ou de référence :**
► Protocole interne « Protocole grand froid » - 009/18-10-2013
► Protocole interne « Prise en charge des SDF » - 127/14-02-2017
► Protocole transversal « **ACCUEIL** DES PERSONNES SDF DANS UN LIEU DE REPOS EN PERIODE DE **GRAND FROID** » RP/T/PROC-017/18-02-2014

**Documents associés ou de référence :**
► Personnel médical, paramédical et administratif exerçant aux SAU, jour et nuit
► Personnel effectuant des gardes jour et nuit (cadres de garde, administrateurs de garde)
► Personnel de sécurité

**CONDUITE A TENIR :**



# 9. PEC PAR LE SERVICE DES URGENCES D'UN PATIENT ADRESSE PAR UN AUTRE SERVICE

| Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph | **Procédure de prise en charge par le Service des Urgences d'un patient adressé par un autre service** | **Indexation : Urgences/T/PROC-030/14-02-2018** |
|---|---|---|
| | **Emetteur : Service des Urgences** | **Nombre de pages : 1**<br>**Date de création : mars 2014**<br>**Nombre d'exemplaires : 1** |
| | ***manuel de certification : V2014*** | |
| | rédigée par A. Boureau, C.Bertin | signature : AB, CB |
| | validée par O.Ganansia | signature : OG |
| | approuvée par O.Ganansia | signature : OG |

**INFORMATIONS GENERALES :**

**Manuel de certification** : Critère 25.a Prise en charge des urgences et des soins non programmés

**Objet :** Ce document est une procédure à respecter pour tout patient devant être orienté en vue de sa prise en charge par le Service des Urgences. Elle doit impérativement être appliquée 24h/24 et 7j/7.

**Domaines d'application :** Service des Urgences, Consultations, Plateau technique, à l'exclusion de tout service d'hospitalisation, Brancardage centralisé.

**Vocabulaire :**

**Documents associés ou de référence :**

**CONDUITE A TENIR :**

1) Appeler le médecin régulateur des urgences au 7790 et lui donner les éléments motivant l'orientation du patient vers le SAU. Le médecin se chargera d'informer l'Infirmière Organisatrice de l'Accueil.

2) Accompagnement du patient à l'accueil des urgences par un personnel (brancardier par le biais du logiciel THEO). Si des éléments importants doivent être communiqués, il est nécessaire qu'une IDE, ou bien une AS, accompagne le patient.

3) Communiquer l'identité du patient à l'agent administratif afin d'enregistrer le patient (étape obligatoire du fait de l'informatisation du dossier aux urgences). Dans la mesure du possible, veiller à ce que le patient soit muni de ses papiers d'identité et de prise en charge (carte vitale, CMU, mutuelle…)

4) Le cas échéant, faire les transmissions à l'Infirmière Organisatrice de l'Accueil qui déterminera la filière de prise en charge de ce patient selon les critères définis dans le service ou en fonction des indications spécifiques du médecin régulateur.

5) Le patient sera ensuite installé, soit sur un brancard, soit sur un fauteuil, selon les directives de l'Infirmière Organisatrice de l'Accueil au vu de son tri.

# 10. PEC D'UN ENFANT MINEUR DONT L'UN DES PARENTS ET/OU RESPONSABLE LEGAL EST HOSPITALISE EN URGENCE.

| | | |
|---|---|---|
| | **Prise en charge d'un enfant mineur dont l'un des parents ou responsable légal est hospitalisé en urgence** | **RP/T/PROC-016/23-10-2018** |
| | Émetteur : Relations Patients | Nombre de pages : 1<br>Date de création : 04/09/2013 |
| | *Manuel de certification* | 19a |
| | rédigée par Davina Sumbal, responsable des relations patients et affaires juridiques médicales par intérim | DS |
| | Validée par<br>- Isabelle Cocheteau, coordonnatrice paramédicale du pôle maternité<br>- Victoire Cappe de Baillon, responsable parcours patient Hospitalisé | IC / VC |
| | Approuvée par Jean-Patrick Lajonchère, directeur général | JPL |

**INFORMATIONS GENERALES :**

***Manuel de certification V2014*** *: Référence 19a « Populations nécessitant une prise en charge particulière ».*

**Objet :** Identifier les enfants mineurs **(moins de 18 ans)** dont le responsable légal est hospitalisé d'urgence sans possibilité de garde.

**Domaine d'application** : tous les services d'hospitalisation, le service d'accueil des urgences, la maternité, la crèche

**Documents associés** : Procédure « prise en charge d'enfants adresses à la crèche par le GHPSJ »

**CONDUITE À TENIR :**

En cas d'hospitalisation d'urgence de l'un des parents ou responsable légal accompagné de ses enfants mineurs :

### I. Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Le service prévient l'assistante sociale de son unité (à défaut, appeler le cadre des assistantes sociales au 33 39) qui :

- ⇨ recherchera la personne ressource désignée par le parent ou le responsable légal pour venir chercher l'enfant, sur présentation d'une pièce d'identité (qui devra être numérisée dans le dossier informatisé du parent ou responsable légal hospitalisé).
- ⇨ en l'absence de personne ressource, contactera :
  - les services de l'**A**ide **S**ociale à l'**E**nfance de Paris (**ASE** : 01 42 76 38 38).
  - la **C**ellule de **R**ecueil des **I**nformations **P**réoccupantes (**CRIP** : 01.42.76.26.17 / DASES-CRIP75@paris.fr)
  - le **Procureur de la République** (01 44 32 51 51) pour obtenir une **ordonnance de placement provisoire** (OPP).

En attendant la réponse du Procureur de la République, le mineur peut être pris en charge :

- par la crèche dans le cadre des heures d'ouverture (7h à 20h30 ; fermée le week-end et les jours fériés), cf conditions et modalités dans la procédure « ***Prise en charge d'enfants adressés à la crèche par le GHPSJ*** » (disponible sur Infopital).
- en dehors des horaires d'ouverture de la crèche, le mineur reste sous la responsabilité du service.

A réception de l'ordonnance de placement provisoire (OPP), l'assistante sociale informe le service et la crèche puis accompagne le professionnel de l'ASE pour récupérer l'enfant. Ce dernier doit présenter sa carte professionnelle et l'ordonnance du juge qui devront être numérisées dans le dossier informatisé du parent ou responsable légal hospitalisé. L'enfant confié est alors sous la responsabilité de l'ASE.

## II. Du lundi au vendredi de 18h à 9h, les week-end et jours fériés

Le service prévient le cadre de garde ou de nuit qui alertera l'administrateur de garde.

L'administrateur de garde contacte le **Procureur d'astreinte** au **06 08 16 87 75** pour obtenir une ordonnance de placement provisoire et lui transmet les informations suivantes :

- Parent ou responsable légal hospitalisé :
  - Nom
  - Prénom
  - Date de naissance
  - Adresse
  - Motif d'hospitalisation
  - Estimation de la durée d'hospitalisation, si possible
- Mineur :
  - Nom
  - Prénom
  - Date de naissance
  - Adresse

La transmission de ces informations doit également se faire par fax au **01 71 39 89 54** en utilisant la trame ***(cf annexe : Fax : Information au Procureur de la République).***

Afin de pouvoir réceptionner l'ordonnance de placement, l'ADG communique au Procureur d'astreinte le numéro du fax situé dans le bureau des cadres de nuit/garde (St Jean porte 2 niveau galerie) :
**01 44 12 31 51**

A réception de l'OPP, l'ADG contacte la **Brigade des Mineurs** au **01 87 27 81 05** (n° de téléphone valable uniquement la nuit, les week-end et les jours fériés), qui viendra chercher l'enfant pour le placer à la Maison de l'Enfance situé dans le 20ème arrondissement. Une copie de l'OPP devra être remise à la Brigade des mineurs.

**Il est important** :

- de rassurer l'enfant.
- dans la mesure du possible, de le laisser auprès de son parent.
- de vérifier les documents d'identité des personnes concernées (représentant légal et personne ressource) et de les numériser dans le dossier informatisé du responsable légal hospitalisé.
- **de tracer toutes les démarches et mesures prises dans le dossier informatisé du responsable légal hospitalisé.**

Groupe hospitalier
Paris Saint-Joseph

**Fax : Information au Procureur de la République**

**Objet : Demande d'une ordonnance de placement provisoire pour un mineur**

Expéditeur : Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph – 185 rue Raymond Losserand, 75674 Paris Cedex 14

Service : ……

tél : 01 44 12 76 29 ou 01 44 12 67 12 fax : 01 44 12 31 51

Destinataires : Procureur de la République de Paris - fax : 01 71 39 89 54

Nombre de pages (y compris celle-ci) : 1

Date : Heure :

Je soussigné(e)……, administrateur de garde du Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph, vous sollicite afin d'obtenir une ordonnance de placement provisoire pour le mineur :

- Nom :
- Prénom :
- Date de naissance :
- Adresse :

accueilli le …… à …… dans le service de……

Et dont le parent ou le responsable légal est actuellement hospitalisé au sein de notre établissement :

- Nom :
- Prénom :
- Date de naissance :
- Adresse :
- Motif d'hospitalisation :
- Estimation de la durée d'hospitalisation (si possible) :

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, le procureur, mes meilleures salutations.

Signature du déclarant :

# 11. ACCUEIL DES MINEURS EN CONSULTATION ET HOSPITALISATION : RECOMMANDATIONS

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

Accueil des mineurs en consultation et hospitalisation : recommandations

**1RP-PRC-003**
**Version : 02**

| **Emetteur : Relations Patients / Qualité** | **Date d'application : 22.03.24** |
|---|---|
| rédigée par : Davina Sumbal, responsable des relations patients et des affaires juridiques médicales | signature : DS |
| Validée et approuvée par : Marie-Hélène Painchaud, coordinatrice paramédicale du pôle qualité | signature : MHP |

**INFORMATIONS GENERALES**

***Manuel de certification V2014*** *« référence 19a : Prise en charge des patients appartenant à une population spécifique »*

**Objet :** Décrire les recommandations à prendre lors de la prise en charge d'un mineur.
**Domaine d'application :** Services de consultation et d'hospitalisation.

**Document associé :**

- Procédure « Autorisation d'hospitalisation, de soins et d'acte interventionnel pour un patient mineur »
- Procédure « Prise en charge d'un enfant mineur dont l'un des parents et/ou responsable légal est hospitalisé en urgence ».

**Documents de référence :**

- Articles L 1111-2, L 1111-5, L 2212-4, L 2212-7, L 3211-10, L 3211-1, L 3213-1, L 3211-12 et L 3213-9, R 1112-34 à R 1112-36 du code de la santé publique (CSP)
- Articles 371, 371-1, 372, 373-2-1 et 373-5 et 390 du code civil (CC), relatifs à l'autorité parentale
- Articles D 132-1 à D 132-5 du code de la sécurité sociale.

L'âge de la majorité en France a été fixé à 18 ans par la loi du 5 juillet 1974.

L'admission d'un mineur est prononcée par le directeur de l'hôpital, sur avis d'un médecin de l'établissement, à la demande d'une personne exerçant l'autorité parentale (père, mère ou représentant légal).

La prise en charge d'un mineur nécessite de suivre les recommandations suivantes :

| | | |
|---|---|---|
| **Moyens** | ⏩ disposer de matériels adaptés (notamment en cas d'urgence vitale,…) | |
| **Consultation d'anesthésie et de chirurgie** | ⏩ **obligatoirement** en présence de l'un des parents ou **du représentant légal.** | |
| **Autorisation d'hospitalisation, de soins et d'acte interventionnel** | ⏩ **Par écrit** par les deux personnes possédant l'autorité parentale ou le représentant légal *(cf Procédure « Autorisation d'hospitalisation, de soins et d'acte interventionnel pour un patient mineur»)* | ➔ En cas d'urgence vitale, ces autorisations ne sont pas requises.<br><br>➔ En cas d'absence des parents, toutes les actions pour les joindre et obtenir leur accord et consentement écrit, doivent être mises en œuvre et tracées dans le dossier.<br><br>➔ En cas de mineur isolé, si l'état du patient requiert un geste urgent, c'est l'ADG qui signe l'autorisation d'opérer, s'il s'agit d'une programmation, un signalement au procureur est effectué par le service social pour mettre en place des mesures de protection par le parquet des mineurs et l'ASE *(cf Procédure Prise en charge d'un enfant mineur dont l'un des parents ou représentant légal est hospitalisé en urgence)* |
| **Hospitalisation** | ⏩ **obligatoirement en chambre seule**, près du poste de soins. | |
| **Sortie du mineur** | ⏩ **réalisée par** l'un des parents titulaire de l'autorité parentale, le représentant légal ou une personne désignée par eux, par écrit | ➔ En cas d'absence des parents, il convient d'avertir le service des Relations Patients (n°3585) ou l'administrateur de garde qui précisera la conduite à tenir. |
| ***Cas particulier de l'adulte arrivant avec un enfant aux urgences et qui doit être hospitalisé.*** | ⏩ cf. procédure « Prise en charge d'un enfant mineur dont l'un des parents et/ou responsable légal est hospitalisé en urgence ». | |

**Documents spécifiques à récupérer** :

- ⇒ Le carnet de santé
- ⇒ Une copie du livret de famille ou un extrait d'acte de naissance
- ⇒ Une copie de la carte d'identité des deux parents ou tuteurs légaux
- ⇒ Une copie du jugement de divorce ou du justificatif de dissolution du PACS en cas de séparation
- ⇒ En cas d'absence des parents, une procuration signée par les deux parents autorisant un autre adulte à venir chercher le mineur. L'identité du majeur doit être citée dans la procuration et vérifiable par une pièce d'identité lors de la sortie du mineur.
- ⇒ En cas de défaillance d'un des deux représentants légaux, l'unique représentant doit produire une attestation sur l'honneur, certifiée conforme par un commissariat ou une mairie, indiquant qu'il est le seul représentant légal de l'enfant.

# 12. PEC DES SDF

| Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph | **Prise en charge des SDF** | **Indexation : Urgences/ I/PROT-127/14-02-2017** |
|---|---|---|
| | **Emetteur :**<br>**Service des urgences** | **Nombre de pages : 2**<br>**Date de création : 08/02/2017**<br>**Nombre d'exemplaires : 1** |
| | ***manuel de certification : V2014*** | Critère 25.a |
| | rédigée par Dr L. GIAUME (médecin urgentiste) | signature : LG |
| | validée par Dr O. GANANSIA | signature : OG |
| | approuvée par le groupe de travail (*) | signature : |

**INFORMATIONS GENERALES :**

**Manuel de certification** : les circuits de prise en charge sont définis et formalisés selon le degré d'urgence et la typologie des patients

**Objet :** Encadrer la prise en charge des patients SDF à l'accueil, et à la sortie.

**Domaines d'application :** Service des Urgences.

**Vocabulaire :**

**Documents associés ou de référence :**

*(*) Groupe de travail : E. DJAMBOU (aide-soignante), N. GUERISEC (ide), M. BOURGUIGNAT (ide), C. CARTON (ide), O. GUSTINATI (ide), A. BOUREAU (ide référente), T. RODRIGUEZ (ide référente), Dr J.L. AIM, C. BERTIN (cadre de santé)*

**CONDUITE A TENIR :**

**Prise en charge IOA**

*La prise en charge des patients SDF par l'IOA est identique à celle tout patient (Cf. procédure IOA)*

**Prise des paramètres vitaux Systématiques** : FC, SaO2, PA, CGS, HGT

- **éthylotest** si doute sur la présence d'une intoxication alcoolique
- si notion d'exogènose connue -> score de Cushman et délivrance de Valium

**Situations particulières**

- ***Pas de plainte somatique***
  - Normalité des paramètres vitaux
  - Appel du MAO
  - Sortie avec accord médical, notée dans le dossier par le médecin ou l'IOA (nom du médecin),
  - Sortie encadrée : raccompagnement à l'entrée de l'hôpital (si besoin agent de sécurité)

- ***Refus de prise en charge***
  - Normalité des paramètres vitaux
  - Appel du MAO
  - Soit sortie avec accord médical, notée dans le dossier et sortie encadrée
  - Soit décision médicale de contention si nécessité d'une PEC médicale

- ***Patient agressif***
  - Prise des paramètres vitaux si possible
  - Appel du MAO, vérification de l'absence de plaintes somatiques ou de signes de gravité
  - Appel de la sécurité, discuter une contention
  - Contact du commissariat du 14ème
  - Rédaction du CNA par le MAO

- ***Patient avec plaintes somatiques et/ou intoxication alcoolique sévère***
  - Prise en charge classique
  - Patient couché mis en attente zone 2
  - Déshabillage et organisation d'une toilette avec l'aide-soignante de zone 2
  - Surveillance du score de Cushman

  - Confirmation de l'intoxication alcoolique :
    - Patient conscient : éthylotest uniquement si non nécessité d'un bilan sanguin
    - Troubles de la conscience ou autres plaintes somatiques nécessitant un bilan : alcoolémie
  - Admission 3066

- ***Patient sans plaintes somatiques demandant un hébergement :***
  - Normalité paramètres vitaux
  - Appel du MAO

  - Si plan Grand Froid déclenché *cf procédure « grand froid »*
    - Lieu de repos dans le hall de l'hôpital, ouvert sur décision médicale avec le cadre de nuit, à proximité du PC sécurité.
    - Capacité : 5 brancards-lits
    - Indication : hommes adultes, sans domicile fixe

  - Hors plan Grand Froid
    - En journée : appel assistante sociale 7684
    - Week-end/ jours fériés/ garde : Prise en charge par le SAMU social ou retour sur le lieu de vie

**Sortie du patient SDF**

- Dès la décision médicale notée dans le dossier
- Prise des paramètres vitaux par l'IDE
- CRH de sortie remis au patient dans une enveloppe (destiné aux maraudes extérieures)
- Remise des effets personnels (dont bouteilles d'alcool)
- Dès la sortie administrative, raccompagnement jusqu'à l'entrée de l'hôpital par l'agent de sécurité.

- En cas de refus de sortie, d'agressivité ➔ Sortie avec l'agent de sécurité

**Numéros utiles**

SAMU Social : 01 58 46 20 04 (entre 21h-4h)
Commissariat du 14ème : 01 53 74 14 0

# 13. CAT EN CAS DE CONSULTATION ET/OU D'HOSPITALISATION D'UN DETENU

| | | |
|---|---|---|
| Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph | **Conduite à tenir en cas de consultation et/ou d'hospitalisation d'un détenu** | **RP/T/PROC-010/05-12-2014** |
| | **Émetteur : Relation Patients** | Nombre de pages : **5**<br>Date de création : **18/02/2010** |
| | ***Manuel de certification :*** | Chapitre 2 – référence 19 – critère a – E1 |
| | rédigée et validée par MO. Nault (Relations Patients) p.3534 | signature : MON |

## INFORMATIONS GENERALES :

**Manuel de certification** V2010 (Chapitre 2 - référence 19 - critère a - E1)
« Populations nécessitant une prise en charge particulière - E1 : un projet de prise en charge spécifique est formalisé. »

**Objet :** Actions à mener en cas de consultation et/ou d'hospitalisation d'un détenu

**Domaines d'application :** SAU, services de soins, blocs opératoires, consultations et sécurité.


*1. CONSULTATION ..... 2*

*a) Prise de rendez-vous ..... 2*

*b) À l'arrivée du détenu ..... 2*

*c) Escorte ..... 2*

*d) Consultation ..... 2*

*e) Attente après consultation ..... 2*

*f) Facture ..... 2*

*2. HOSPITALISATION ..... 2*

*a) Admission ..... 2*

*b) Séjour ..... 3*

*c) Déplacement dans l'hôpital pour consultations pour avis ou explorations fonctionnelles ..... 4*

*d) Prise en charge au bloc opératoire et en salle de réveil ..... 4*

*e) Sortie du détenu ..... 4*

## 1. CONSULTATION

### *a) Prise de rendez-vous*

- ✓ Lors de la prise d'un rendez-vous de consultation ou d'examen de radiologie, il convient de suivre la procédure spécifique qui permet de préserver dans Axya l'anonymat du détenu. L'identité ne sera entrée sur le logiciel précité que le jour du rendez-vous, en présence du patient.
- ✓ Une circulation de l'information entre l'hôpital et l'établissement pénitentiaire doit être établie pour éviter des annulations tardives de rendez-vous, limiter le temps de présence du détenu à l'hôpital, organiser des conditions d'accueil discrètes et adaptées pour l'escorte pénitentiaire.

### *b) À l'arrivée du détenu*

- ✓ Le service de sécurité (poste 3665) doit être prévenu systématiquement.
- ✓ L'escorte devra garer son véhicule près de la Galerie St Jean, Porte 4, niveau zéro, en face du bâtiment situé face à la porte de communication avec Broussais.
- ✓ Il est nécessaire d'éviter ou de réduire au strict minimum l'attente du détenu qui, si possible, s'effectuera dans une pièce individualisée.

### *c) Escorte*

- ✓ Les mesures de sécurité (surveillance constante du personnel pénitentiaire, port ou non de menottes ou entraves…) à l'hôpital sont décidées, par écrit, par le chef d'établissement de l'administration pénitentiaire ou son représentant.
- ✓ En cas de contestation du médecin consultant, une explication orale pourra être donnée par le chef d'escorte sur les motifs de recours aux mesures de sécurité, ce dernier pouvant également produire un « formulaire type » signé du chef d'établissement de l'administration pénitentiaire. Seul le chef d'établissement de l'administration pénitentiaire où est incarcéré le patient pourra revenir sur les mesures de contrainte.
- ✓ Une nécessaire vigilance de chacun s'impose pour préserver la sécurité des patients et des équipes ; il en est de même du respect de la confidentialité.

### *d) Consultation*

- ✓ Si possible, il convient d'examiner le détenu dans un box isolé voire ne disposant pas de fenêtre ; à défaut la présence du Chef d'escorte sera obligatoire.
- ✓ En cas de présence lors de l'examen par le médecin, le Chef d'escorte est tenu au secret professionnel.

### *e) Attente après consultation*

- ✓ Le retour vers l'établissement pénitentiaire s'effectue dans les suites immédiates de la consultation.
- ✓ Les examens biologiques et radiologiques seront traités selon le circuit d'une urgence et les résultats transmis au service médical de l'établissement pénitentiaire où est incarcéré le patient.
- ✓ Le dossier médical, les courriers, l'ordonnance et les résultats des examens sont à remettre à l'escorte sous pli cacheté.

### *f) Facture*

- ✓ La facture de la consultation et des actes inhérents est à adresser au secrétariat de l'administration pénitentiaire et non au détenu.

## 2. HOSPITALISATION

### *a) Admission*

- ✓ L'admission est effectuée par le service de soins qui reçoit le détenu.
  Il ne doit pas exister de procédure de pré-admission nominative pour les détenus. Dans Axya, le détenu n'est pas hospitalisé sous son nom patronyme mais sous un nom d'emprunt. La présence du détenu ne doit pas être divulguée par le personnel hospitalier, les agents d'accueil et du standard.

- ✓ Le service de soin prévient le service Relations Patients (poste 3257), la Direction générale (poste 3499) et le service de Sécurité (poste 3665) de l'arrivée du détenu : faxer le papier de prise en charge donné par la pénitentiaire.
- ✓ L'information de la famille sur l'admission à l'hôpital revient au personnel de l'établissement pénitentiaire.

### *b) Séjour*

***Le patient détenu bénéficie de l'ensemble des droits des malades précisés par la Charte de la Personne Hospitalisée (circulaire du 2 mars 2006).***

⇨ **Refus de soins du détenu :**

En cas de refus de soins, le patient est informé par les médecins des risques qu'il encourt. Il signe l'attestation de refus de soins et sort « contre-avis médical ». Il est reconduit par une escorte dans son établissement pénitentiaire d'origine.

- ✓ **Droits quotidiens des détenus :** le détenu admis à l'hôpital se voit appliquer les dispositions du régime pénitentiaire.
- ✓ **Missions des gardiens du détenu malade** (qui font partie du corps de la Police Nationale) :
  La surveillance et la garde du détenu leur incombent (porte de chambre ouverte en dehors des soins).
  Ils peuvent être amenés à prendre certaines précautions dans l'aménagement de la chambre du détenu : verrouillage fenêtres, démontage glaces, porte des toilettes, verrous… ; absences de conteneurs, ciseaux, couverts en métal, aiguilles.
- ✓ **L'interdiction de fumer est formelle pour les détenus.**
- ✓ **Affaires personnelles des détenus** :
  Les objets de valeur doivent être déposés au coffre central de l'hôpital.
  Les effets personnels amenés par la famille (revue, livre, paquet) ne doivent pas être remis directement au patient.
- ✓ **Correspondance, colis :**
  La correspondance réceptionnée par l'hôpital et adressée au détenu est remise aux fonctionnaires de police qui assurent la garde du détenu pour être dirigée vers l'Administration pénitentiaire.
  Le personnel hospitalier ne doit en aucun cas donner ou poster le courrier du détenu.
- ✓ **Visites – Information de la famille**
  Le droit de visite (permis de visite) est fixé par le Juge d'Instruction ou le Directeur de l'établissement pénitentiaire et géré au quotidien par la garde statique.
  Les contacts entre le détenu et sa famille ne peuvent avoir lieu par téléphone (le détenu ne dispose pas du téléphone dans sa chambre).
  L'information de la famille, même sans permis de visite, relève exclusivement du médecin.

  *Tout le personnel de l'établissement (médical, paramédical, social) y compris l'équipe d'aumônerie) peut visiter le patient sans autorisation.*
  *Aucun médecin externe à l'hôpital, fût-il le médecin traitant, ne peut avoir directement accès au malade.*
- ✓ **Dossier médical**
  Le dossier médical du patient est constitué et archivé par l'hôpital.
  Il est communiqué au détenu qui en fait la demande par envoi en recommandé accusé réception, à l'adresse de l'établissement pénitentiaire du patient.
- ✓ **Services Sociaux**
  Seule l'assistante sociale du service hospitalier est habilitée à répondre au besoin du détenu sous réserve de connaître les obligations pénitentiaires.

### c) *Déplacement dans l'hôpital pour consultations, pour avis ou explorations fonctionnelles*

- ✓ Le déplacement pour des actes de soins (conduite au bloc, radiologie, en salles de soins ou d'examens) se fait sous escorte.
- ✓ Pour tout rendez-vous de consultation ou radiographie pendant le séjour, il convient de respecter la procédure des prises de rendez-vous en consultation (cf. ci-dessus).
- ✓ La porte de la chambre du détenu est fermée à clef en son absence.

### d) *Prise en charge au bloc opératoire et en salle de réveil*

- ✓ **Au bloc opératoire**, un membre de l'escorte se tiendra hors du bloc ; un second, en tenue de bloc opératoire, accompagnera le patient en salle d'induction et en salle d'opération jusqu'à son endormissement.
  Le membre de l'escorte n'assiste pas à l'intervention.
  Il conviendra si possible de positionner le détenu en premier sur le programme opératoire.
- ✓ **En salle de réveil**, il y aura lieu de trouver un emplacement permettant une visibilité du détenu par l'escorte, située hors de la salle de réveil. En cas d'impossibilité, un membre de l'escorte, en tenue de bloc opératoire, participera à la surveillance du patient en salle de réveil.

### e) *Sortie du détenu*

Les formalités de sortie sont effectuées par l'équipe soignante.
Les sorties ne peuvent avoir lieu après 17h, le week-end et les jours fériés pour des raisons d'organisation pénitentiaire.

- ✓ **Retour d'un détenu vers son établissement d'origine**
  Le service de soins informe la maison d'arrêt qui se charge de mettre en œuvre la procédure ad hoc.
- ✓ **Transfert vers une structure médicalisée**
  Le cadre, l'infirmière référente ou la secrétaire hospitalière informent l'établissement d'origine de la prévision de transfert du patient. Le transfert est organisé conjointement par les équipes de soins et l'établissement pénitentiaire d'origine.
- ✓ **Décès du détenu à l'hôpital**
  - ⇨ Un avis d'aggravation est adressé au Directeur de l'établissement pénitentiaire :
    - o La famille sera avisée par l'Administration Pénitentiaire.
    - o La garde statique prévient sa hiérarchie du décès du détenu.
    - o Pour tout détenu, quelque soit son lieu de détention, il y a lieu d'avertir le commissariat du 14ème arrondissement (lieu de décès du détenu).
  - ⇨ Le constat de décès est réalisé par un médecin du service où le détenu était hospitalisé. La déclaration de décès est faite par l'établissement hospitalier à la mairie du XIVème arrondissement.
  - ⇨ Le corps est laissé dans la chambre avec tous les dispositifs de soins (porte fermée à clef si possible) jusqu'à l'arrivée de la police judiciaire. L'ensemble des dispositifs de soins sera retiré avec le consentement de la police judiciaire.
    La toilette mortuaire est réalisée **après** passage de l'officier de police judiciaire.
  - ⇨ Le corps peut être déposé à la chambre mortuaire de l'établissement puis conduit à l'Institut Médico-Légal, par la Ville de Paris, sous réquisition délivrée par le Parquet, et sans autres formalités. Il peut également être transféré du service d'hospitalisation à l'Institut Médico-Légal par la Police Judiciaire, sous réquisition judiciaire délivrée par le Parquet, sans autres formalités.
- ✓ **Sortie par évasion**
  Il convient immédiatement d'informer l'administrateur de garde et le Directeur de l'établissement pénitentiaire d'origine.

## CAS PARTICULIERS :

Pour connaître le numéro d'écrou d'un détenu ou les coordonnées de l'établissement pénitentiaire d'accueil d'un patient ayant été placé sous mandat de dépôt pendant son hospitalisation, s'adresser à la Compagnie de Surveillance et de Protection *(Brigadier Major DUPUIS : tél 01.55.43.63.70, fax 01.55.43.63.71)*.

# 14. PATIENT PORTEUR D'ARME OU DE DROGUE

| Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph | **Patient porteur d'arme ou de drogue** | RP/T/PROC-001/18-10-2019 |
|---|---|---|
| | Émetteur : **Relations Patients** | Nombre de pages : **2**<br>Date de création : 01/09/2004 |
| | ***Manuel de certification*** | Réf 6a |
| | Rédigée par Davina Sumbal, Relations Patients | signature : DS |
| | Validée par Fabrice Laigle, responsable de la sécurité | Signature : FL |
| | Approuvé par Jean-Patrick Lajonchère, directeur général | Signature : JPL |

**INFORMATIONS GENERALES :**

> ***Manuel de certification V2014*** *ref 6a : « Sécurité des biens et des personnes – E1 : Les situations mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes sont identifiées. ».*

**Objet :** Conduite à tenir face à un patient détenteur de drogue ou d'arme à l'entrée en hospitalisation ou en consultation ou au cours du séjour.

**Vocabulaire :**

***Arme*** : armes à feu, armes blanches, armes de défenses (poing américain, bombes à gaz divers type lacrymogène,...)

***Drogue*** **:** substance détenue ou commercialisée de manière illicite (cannabis, héroïne, cocaïne, LSD, ecstasy...) ; médicaments stupéfiants détenus illégalement (sans ordonnance justificative)

**Domaines d'application :** service d'hospitalisation et de consultation

**Documents de référence :**

***Pour les armes :***

- code de la sécurité intérieur : art. L.311-2 et suivants et R.311-1 et suivants
- code pénal : art. 226-13 et 226-14 (secret professionnel)

***Pour les drogues :***

- code pénal : art. 222-37
- code de la santé publique : art.L.628 et L628-1 (usage et possession illicite de stupéfiants) et L.3421-1
- instruction n°DGOS/DSR/mission des usagers/2011/139 du 13 avril 2011 relative à la conduite à tenir en cas de détention illégale de stupéfiants par un patient accueilli dans un établissement de santé

Un patient ne peut pas garder une arme en sa possession ou détenir de la drogue pendant son séjour à l'hôpital ou lors d'une consultation.

**La détention de drogue ou d'arme est un délit.**

Cependant, aucun texte de loi ne prévoit la levée du secret professionnel en cas de détention illicite de stupéfiant ou d'arme, l'identité du patient ne doit donc pas être divulguée (sauf sur réquisition judiciaire).

## I. Patient détenteur d'arme

1. Le personnel soignant prévient immédiatement son encadrement et le médecin en charge du patient.
2. Le cadre alerte le responsable de la sécurité (7714) et le service des relations patients (3585 du lundi au vendredi, de 9h à 18h) ou l'administrateur de garde.
3. Le responsable de la sécurité récupère l'arme auprès du patient, en se munissant de gants et en la manipulant le moins possible puis la dépose au coffre central du PC sécurité en présence d'une personne des relations patients ou de l'administrateur de garde.
4. Le responsable de la sécurité et le responsable des relations patients ou l'administrateur de garde préviennent le commissariat du 14ème arrondissement sans donner l'identité du patient qui viendra confisquer l'arme. (Le patient pourra réclamer l'arme au commissariat).

**Cas particuliers** : le patient détenteur d'une arme est un membre des forces de l'ordre (militaire, gendarme, police)

- Si le patient est **conscient** : il doit prévenir sa hiérarchie qui viendra récupérer son arme de service.
- Si le patient est **inconscient** : Le responsable de la sécurité récupère l'arme auprès du patient, en se munissant de gants et en la manipulant le moins possible puis la dépose au coffre central du PC sécurité en présence d'une personne des relations patients ou de l'administrateur de garde. L'arme sera rendue au patient lors de sa sortie. Si ce n'est pas possible, le responsable de la sécurité contacte le commissariat du 14ème arrondissement pour venir confisquer l'arme.

## II. Patient détenteur de drogue

1. Le personnel soignant prévient immédiatement son encadrement et le médecin en charge du patient.
2. Le cadre alerte le responsable de la sécurité (7714) et le service des relations patients (3585 du lundi au vendredi, de 9h à 18h) ou l'administrateur de garde.
3. Le responsable de la sécurité récupère la drogue auprès du patient, en se munissant de gants et décide conjointement avec le responsable des relations patients ou l'administrateur de garde :
   - si **la quantité récupérée est à usage personnel :** procéder à la destruction de la drogue.
   - si la quantité récupérée est **supérieure** à un usage personnel : le responsable de la sécurité dépose la drogue au coffre central du PC sécurité en présence d'une personne des relations patients ou de l'administrateur de garde et contacte le commissariat du 14ème arrondissement sans donner l'identité du patient pour venir confisquer la drogue.

**Dans tous les cas une FEI doit être rédigée.**

# 15. CAT EN CAS DE GALE

**Conduite à tenir en cas de gale**

**1CPIN-PRT-026**
**Version : 03**

| **Emetteur : SJ - Cellule de prévention des infections nosocomiales** | **Date d'application : 22/08/2022** |
|---|---|
| rédigée par : Franck Varey – Infirmier hygiéniste - Carine Couzigou – Médecin hygiéniste-infectiologue | Signature : FV - CC |
| validée par Laurence Perniceni - Cadre de santé hygiéniste | Signature : LP |
| approuvée par Yaye Senghor, Biologiste Parasitologue | Signature : YS |

***INFORMATIONS GENERALES*** :

***Manuel d'accréditation*** : *Chapitre 1 – Partie 3 – Management de la qualité et de la sécurité des soins.*

**Objet :** Prévenir la transmission croisée de la gale, transmissible par contact direct de la peau ou indirectement par des objets fortement contaminés (vêtements, linge, literie).

**Domaines d'application :** Les services de soins

**Vocabulaire :** Gale - Contamination

**Documents associés ou de référence :**

- CCLIN Paris Nord Mesures pour la prévention, et la maitrise de la diffusion de la gale dans les établissements de santé et médico sociaux 2013
- HCSP Avis relatif à l'actualisation des recommandations sur la conduite à tenir devant un ou plusieurs cas de gale 2012
- Avis HAS TOPISCAB_21 01 2015_AVIS_CT13688

## 1 - Généralités

La gale est une infection cutanée très contagieuse due à un parasite (*Sarcoptes scabiei hominis)*, creusant des sillons dans la couche cornée de l'épiderme.

## 2 - Modes de transmission

La transmission de la maladie est liée à la contamination par une femelle fécondée de Sarcoptes scabiei hominis.

- Contamination inter humaine, au cours de soins directs : par contact étroit et prolongé en cas de gale commune. Un contact cutané simple suffit en cas de gale hyperkératosique.
- Contamination indirecte par l'intermédiaire de l'environnement (les vêtements, le linge, ou la literie, les serviettes, les fauteuils). Toute surface poreuse peut être parasitée en cas de gale hyperkératosique.

## 3 - Facteurs de risques

La dissémination du parasite est favorisée par la vie en collectivité.

Les facteurs de risques sont :

- les contacts rapprochés et prolongés
- la cohabitation de personnes dans un espace restreint
- pour les soignants, les soins de nursing

## 4 - Incubation

La durée d'incubation moyenne de la gale est de 4 semaines et peut aller jusqu'à 6 semaines.

## 5 - Diagnostic

### 5.1 - Clinique

Association d'un prurit (recrudescence nocturne, parfois à caractère familial) et présence de lésions cutanées.

- **Gale commune** : touche les doigts (espaces interdigitaux), les poignets et les cuisses (faces antérieures), les aisselles, l'aréole mammaire, les organes génitaux mais pas le visage et le dos. Présence de papules inflammatoires prurigineuses, vésicules perlées, sillons et nodules scabieux. Association à des lésions secondaires non spécifiques (lésions de grattage, eczématisation, lichénification, impétigo).

- **Gale hyperkératosique** (ex gale « norvégienne »), **gale profuse** : forme rare, sévère et très contagieuse de gale caractérisée par une infestation massive de parasites. Conséquence d'un déficit immunitaire, parfois d'un diagnostic tardif ou d'un traitement inadapté. Les cas non diagnostiqués peuvent être à l'origine d'épidémies de gale, notamment en institution, en raison d'un risque de contagiosité très élevé, y compris par le biais des surfaces inertes.
  Se présente sous la forme d'une dermatose hyperkératosique « farineuse » sur tout le corps dont visage, dos et cuir chevelu, associée à une éruption erythémato-papuleuse du tronc (dos inclus), du visage, du cou et du cuir chevelu. Attention aux formes localisées au **niveau ongles des mains et des pieds.**

### *5.2 - Parasitologique*

Demander un avis dermatologique et faire réaliser, par le laboratoire de microbiologie, un prélèvement par grattage profond des lésions afin d'identifier dans les sillons et/ou vésicules des adultes, œufs, larves, ou scybales.

## 6 - Traitement

**Traitement individuel**

Il associe le traitement médicamenteux et le traitement du linge.
Traiter le patient et le(s) contact(s) simultanément.

Il n'y a pas de consensus concernant le traitement local et ou oral pour les gales communes. **Cependant, la facilité d'utilisation plaide en faveur du traitement per os d'autant plus que le nombre de personnes à traiter est important.**

**Dans les gales hyperkératosiques : associer le traitement topique et per os en plus du traitement du linge et de l'environnement.**

**Le traitement médicamenteux est appliqué sur prescription médicale**

| | à | Traitement local : Topiscab Perméthrine) | Traitement per os : Stromectol |
|---|---|---|---|
| **MODALITE D'APPLICATION DU TRAITEMENT** | *J 0* | déshabiller le patient en évitant de secouer les vêtements à mettre dans un sac plastique hermétique.<br>Faire prendre une douche chaude avec un savon doux, rincer, sécher modérément.<br>appliquer la crème Topiscab avec une compresse **sur la totalité de la surface corporelle y compris le visage, en insistant sur les lésions**, les plis, les espaces interdigitaux, sous les ongles coupés courts, l'ombilic, la face antérieure des poignets, derrière les oreilles, la plante des pieds, les parties génitales (en dehors des muqueuses) ; frotter en cas de pilosité importante. Eviter les paupières et les muqueuses.<br>Appliquer sur le cuir chevelu si gale hyperkératosique.<br>Laisser sécher puis 2ème application à passer selon le même protocole.<br>**Laisser en contact 24 heures**, y compris sur les mains, renouveler l'application dans la journée si besoin (en cas de lavage des mains).<br>Mettre du linge propre (vêtements et draps).<br>Changer la literie. | Administrer le traitement Stromectol (3mg) en comprimé, prescrit en une seule prise après un jeun strict de deux heures, et ensuite laisser à jeun pendant deux heures.<br>**Posologie : 200 ug / kg**<br>faire prendre une douche au savon doux. Rincer abondamment. Sécher.<br>Mettre du linge propre (vêtement et draps).<br>Changer la literie. |

- Alternatives : Antiscabiosum®,Pyrethrine (Spregal®), Ascabiol 10%

| MODALITE D'APPLICATION DU TRAITEMENT | à | Traitement local : Topiscab® 5 % (Perméthrine) | Traitement per os : Stromectol |
|---|---|---|---|
| | *J 1* | ☐ Douche pour rincer le produit.<br>Utiliser serviette de bain et vêtements propres.<br>☐ Changer la literie une nouvelle fois.<br>☐ **Traiter l'environnement, le linge, literie, vêtements** (cf. « mesures d'isolement » ci-dessous) | ☐ Soins de nursing habituels.<br>☐ **Traiter l'environnement, le linge, literie, vêtements** (cf. « mesures d'isolement » ci-dessous).<br>☐ Changer la literie une nouvelle fois. |
| | *J2* | -- | ☐ **Levée de l'isolement sur prescription.**<br>Maintien de l'isolement jusqu'à 48 heures après la prise du traitement, **sauf pour les gales hyperkératosiques (levée seulement après contrôle des prélèvements qui doivent êtres négatifs).** |
| | **J 8** | ☐ Veiller à un suivi régulier des soins d'hygiène corporelle et à l'évolution des lésions | ☐ Une 2e dose est recommandée dans les gales communes (activité sur les formes larvaires) à J8 **Cette 2e dose** est indispensable pour les gales hyperkératosiques. |
| | **J9** | **Traitement du linge, literie et environnement selon les mêmes modalités qu'à J1.** | **Traitement du linge, literie et environnement selon les mêmes modalités qu'à J1.** |
| | **J 10** | ☐ **Levée de l'isolement sur prescription.**<br>Maintien de l'isolement jusqu'à 48 heures après la 2e application du traitement<br>***Pour les gales hyperkératosiques : la levée de l'isolement ne se fait qu'après contrôle de la négativité des prélèvements.*** | ***Pour les gales hyperkératosiques : la levée de l'isolement ne se fait qu'après contrôle de la négativité des prélèvements.*** |

**Traitement des sujets contact**

Les sujets contact doivent être dépistés et traités, qu'ils soient asymptomatiques ou non. Le traitement doit être fait en même temps que le cas.

**Pour la gale commune** :
Le traitement (par **Stromectol®** à J0 et entre J7 et J10) concerne tous les sujets contact du 1er cercle : personnes ayant un contact cutané, direct, prolongé avec le cas (ex : entourage familial proche, soins de nursing…). En pratique, le patient ainsi que tous les sujets contacts ou du cercle familial (membre du foyer ou partenaire sexuels), même asymptomatiques doivent être traités en même temps.

**Pour la gale hyperkératosique** :
Le traitement concerne les contacts du 1er cercle et du 2e cercle (personnes travaillant ou vivant dans la même collectivité) et, le cas échéant, ceux du 3e cercle (personnes visitant occasionnellement la collectivité, et l'entourage familial des personnes fréquentant régulièrement la collectivité). Le nombre de cas secondaires dans les 2 premiers cercles pourra également orienter la décision. **A l'hôpital, le traitement de tous les personnels et intervenants au sein de l'unité où le patient atteint est hospitalisé est recommandé.**

## 7 – Isolement : Précautions contact

| ISOLEMENT CONTACT<br>Chambre individuelle OU<br>Regroupement de patients porteurs de GALE | |
|---|---|
| **SIGNALISATION** | • **Interne ⇨ CPIN ⟷ Equipe soignante**<br>• **Externe ⇨ ARS et CPIAS dans le cadre d'épidémie**<br>• **Porte de chambre : fiche n° 2**  |
| **Les solutions hydro-alcooliques ne sont pas efficaces sur la gale** | |
| **PERSONNEL**<br>+<br>**VISITEURS** | **Avant d'entrer dans la chambre :**<br>• Lavage des mains au savon doux<br>• Surblouse  <br>• Port de gants systématique  <br>**A changer entre chaque geste après s'être lav les mains au savon doux**<br>**avant de sortir de la chambre**<br>• Eliminer dans l'ordre : les gants puis la surblouse ;<br>• Se laver les mains au savon doux ;<br>•Puis friction avec produit hydro-alcoolique. |
| **DEPLACEMENT DU PATIENT** | **Précautions à prendre durant la durée du traitement :**<br>- Eviter le transfert et les déplacements avant prescription de l'arrêt de l'isolement.<br>- Ne le faire sortir de la chambre qu'en cas de stricte nécessité.<br>**- Prendre rendez vous en dernière position pour les examens complémentaires indispensables.** |
| **ORGANISATION DES SOINS** | • Individualiser le matériel dans la chambre (boîte à aiguilles, garrot, stéthoscope, thermomètre…)<br>• Ne pas entrer les dossiers dans la chambre<br>• Regrouper les soins, effectuer les soins à ce patient en dernier. |
| **LINGE** | • **Linge hospitalier** : évacuation par le circuit habituel.<br>• **Linge du patient** :<br>- Le lavage du linge en machine à 60° C permet de décontaminer efficacement le linge.<br>- si le linge ne peut être lavé à 60° C: le mettre dans un sac en plastique le vaporiser avec ENVIROSCAB®, fermer le sac, le laisser en contact selon les recommandations du fabricant puis entretien habituel en machine par la famille.<br>- en l'absence de traitement par un acaricide, maintenir le linge dans un sac hermétique pendant 72h avant lavage à 60°C. |
| **DECHETS** | • Tri habituel : recueil des déchets dans la chambre, fermer les sacs avant de les sortir et les évacuer immédiatement. |
| **ENVIRONNEMENT** | • Entretien à fond de la chambre à J1 (avec la prise du traitement individuel au coucher, la désinfection de l'environnement doit être faite le lendemain matin) avec les produits habituels.<br>• Traiter le matériel réutilisable avec tissu (brassard, sangle) avec un produit acaricide (ex : **ENVIROSCAB**) dans un sac plastique étanche pendant le temps recommandé par le fabricant avant traitement habituel.<br>• **Porter un masque chirurgical durant l'utilisation du scabicide.**<br>En cas de gale hyperkératosique ; renforcer le traitement de l'environnement - Désinfection de l'environnement (mobilier, literie…) avec un produit scabicide (type **APAR ENVIROSCAB**)). **Il est recommandé d'attendre 3 h avant de réoccuper la chambre.**<br>Literie : il est nécessaire de respecter un délai de 12 heures avant de pouvoir réutiliser la literie désinfectée par un scabicide. |

# 16. PEC D'UN PATIENT SUSPECT OU ATTEINT D'INFECTION DUE AU MONKEYPOX VIRUS

**PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SUSPECT OU ATTEINT D'INFECTION DUE AU MONKEYPOX VIRUS**

**1CPIN-PRC-017**
**Version : 05**

| **Emetteur : Cellule de Prévention des Infections Nosocomiales** | **Date d'application : 11/07/2022**<br>**Mise à Jour : 28/07/2022** |
|---|---|
| rédigée par : C. Couzigou Médecin hygiéniste-infectiologue - Laurence Perniceni cadre de santé hygiéniste – Elise Poulain, Infirmière Hygiéniste | signature : CC , LP, EP |
| Validée et approuvée par : B. Vidal Médecin hygiéniste-infectiologue- | signature : BV |
| Date : 11/7/2022 (réactualisation) | |
| ***Manuel d'accréditation*** : Gestion du risque infectieux<br><br>**Objet :** Cette procédure détaille la conduite à tenir face à tout patient suspect d'infection à Monkeypox virus.<br><br>**Domaines d'application :** Cette procédure s'applique à tous les services d'hospitalisation sur le site de l'hôpital Paris Saint-Joseph.<br><br>**Documents associés ou de référence :**<br><br>- Site du Ministère des Solidarités et de la Santé : https://solidarites-sante.gouv.fr/coronavirus<br>- Recommandations du COREB<br><br>- Recommandations de la Société française de microbiologie :<br><br>https://www.sfm-microbiologie.org/actualites/monkeypox/<br><br>→ Définition de cas et suivi des contacts :<br>Site de Santé publique France : https://www.santepubliquefrance.fr/<br>- Recommandations de l'HAS<br>Haute Autorité de Santé - Monkeypox : une vaccination préventive proposée aux personnes les plus à risque d'exposition (has-sante.fr)<br><br>- Recommandations du HCSP | |

## 1 – Rappel

La variole simienne (du singe) « monkeypox » ou « MKP » (orthopoxvirose/ poxviridae) est apparentée au virus de la variole.

Dans sa forme Africaine, l'infection est une zoonose ; la majorité des patients a été contaminée au contact d'animaux infectés (singe et rongeurs principalement).
Dans l'épidémie qui sévit depuis avril 2022 hors d'Afrique, tous les cas résultent d'une transmission interhumaine.
Les cas identifiés à ce jour en Europe sont bénins. Les populations potentiellement plus à risque de formes graves (éruption majeure, surinfection, pneumopathie, atteinte cornéenne, signes encéphaliques) sont les immunodéprimés, la grossesse car transmission materno-fœtale / périnatale possible avec formes graves du nouveau-né, les enfants (forme plus sévère).

**Sa transmission peut se faire par différentes voies :**
- principalement par contact direct avec des lésions cutanées, des croutes ou des liquides biologiques

- par exposition à des sécrétions respiratoires échangées lors de présence prolongée en face à face ou lors de contact plus intimes (baisers, caresses, relations sexuelles oro-génitales)
- par transmission indirecte par des objets (linge, vêtements, objets de toilette ou de cuisine…)
- par transmission transplacentaire de la mère à l'enfant.

# 2 – Définitions

Ces définitions et conduites à tenir sont susceptibles d'évoluer selon l'évolution de la situation nationale et internationale, en particulier en fonction du nombre et des caractéristiques des cas.

## 2.1 Définitions de cas

**Patient suspect = signes cliniques évocateurs uniquement.**
Un patient suspect d'infection par le virus MKP est une personne présentant une éruption cutanée ou muqueuse génitale, anale ou buccale, évocatrice de MKP, isolée (sans autre signes simultanés), précédée ou accompagnée d'une fièvre ressentie ou mesurée (>38°C), d'adénopathies ou d'une odynophagie.

**Cas possible = signes cliniques évocateurs + exposition à risque d'infection.**
Un cas possible d'infection par le virus MKP est une personne présentant une éruption cutanée ou muqueuse génitale, anale ou buccale, évocatrice de MKP, isolée (sans autre signes simultanés), précédée ou accompagnée d'une fièvre ressentie ou mesurée (>38°C), d'adénopathies ou d'une odynophagie, avec au moins l'une des expositions suivantes dans les 3 semaines précédant le début des signes :
- o Retour d'un voyage dans un pays d'Afrique où le virus circule habituellement ; ou
- o Partenaires sexuels multiples, quelle que soit l'orientation sexuelle ; ou
- o Homme ayant des rapports sexuels avec des hommes.

**Cas probable = signes cliniques évocateurs + contact à risque d'un cas confirmé.**
Un cas probable d'infection par le virus MKP est une personne présentant une éruption cutanée ou muqueuse génitale, anale ou buccale, évocatrice de MKP, isolée (sans autre signes simultanés), précédée ou accompagnée d'une fièvre ressentie ou mesurée (>38°C), d'adénopathies ou d'une odynophagie, ET un contact à risque (définition infra) avec un cas confirmé en France, ou dans un autre pays.

**Cas confirmé = qPCR ou RT-PCR spécifique Monkeypox ou générique Orthopoxvirus.**
Un cas confirmé d'infection par le virus MKP est une personne avec : - un résultat positif de qPCR ou RT-PCR spécifique du virus MKP, ou - un résultat positif en qPCR générique du genre Orthopoxvirus, associée ou non à un résultat de séquençage partiel spécifique du virus MKP

## 2.2 Définitions des personnes-contact

**Personne-contact à risque :**
Toute personne ayant eu un **contact physique direct non protégé sans notion de durée** (Cf. infra mesures de protection efficaces) avec la peau lésée ou les fluides biologiques d'un cas probable ou confirmé symptomatique, quelles que soient les circonstances y compris rapport sexuel, actes de soin médical ou paramédical, ou un contact physique indirect par le partage d'ustensiles de toilette, ou le contact avec des textiles (vêtements, linge de bain, literie) ou de la vaisselle sale utilisés par le cas probable ou confirmé symptomatique.

Toute personne ayant eu un **contact non protégé** (Cf. infra mesures de protection efficaces) **à moins de 2 mètres pendant 3 heures** avec un cas probable ou confirmé symptomatique (ex. ami proche ou

intime, partenaire sexuel habituel même en l'absence de rapports sexuels, personnes partageant le même lieu de vie sans lien intime, voisin pour un transport de longue durée, personnes partageant le même bureau, acte de soin ou d'hygiène, même classe scolaire, salle de TD universitaire, club de sport pour les sports de contacts, salles de sports, …).

**Personne-contact à risque négligeable :**

- Toute personne ayant eu un contact à risque tel que décrit ci-dessus en présence de mesures de protection efficaces respiratoires portées par le cas ou le contact, et de mesures de protection efficaces contact portées par la personne-contact. Les mesures de protection efficaces vis-à-vis du contact physique direct sont le port de gants étanches (latex, nitrile, caoutchouc), et vis-à-vis du contact respiratoire sont les masques chirurgicaux et FFP2, et les hygiaphones.
- Toute autre situation.

# 3. Conduite à tenir

**Les patients notamment avec des formes graves seront adressés en première intention dans les établissements de santé de référence (ESR) REB.**

## 3.1 Conduite à tenir en fonction du type de définition de cas

### 3.1.1 Patients suspects (cf. Annexe 1)

Tout patient suspect doit bénéficier d'une consultation médicale et d'un test diagnostique réalisé par qPCR ou RT-PCR Monkeypox ou Orthopoxvirus, en particulier pour le choix du ou des prélèvements (lésions cutanées, lésions muqueuses, écouvillon rectal ou pharyngé, etc.).

En cas de cluster, seuls les 3 cas les plus récents doivent être testés.

Il est recommandé que les cas suspects présentant une forme clinique grave soient hospitalisés avec mise en place de mesures de protection contact + air jusqu'à l'obtention du résultat du test (cf. paragraphe 3.2).

Les cas suspects présentant des formes cliniques non graves doivent rester isolés à leur domicile dans l'attente du résultat. Le médecin prenant en charge le patient peut lui prescrire un arrêt de travail s'il ne peut pas télétravailler.

La recherche des personnes-contact à risque ne doit pas être mise en œuvre à ce stade et la DO ne doit pas être réalisée. Il n'est pas nécessaire d'informer l'ARS des patients suspects.

- En cas de test positif, le cas suspect devient un cas confirmé (Cf. ci-dessous).
- En cas de test négatif, le cas est exclu.

Chez des cas suspects avec une date de début des signes ancienne (plus de 3 semaines), la PCR peut être négative, en particulier si la cicatrisation des lésions est très avancée. Pour certains d'entre eux, il y a un intérêt à documenter l'infection pour des raisons épidémiologiques (clusters particuliers, cas pédiatriques, cas féminins, …). Il peut être décidé au cas par cas de réaliser une analyse sérologique au CNR pour documenter l'infection. Ces cas devront être discutés et validés avec le CNR, la DGS et Santé Publique France en amont de tout envoi de prélèvement au CNR.

### 3.1.2 Cas possibles

Tout cas possible doit bénéficier d'une consultation médicale et d'un test diagnostique réalisé par qPCR ou RT-PCR Monkeypox ou Orthopoxvirus, en particulier pour le choix du ou des prélèvements (lésions cutanées, lésions muqueuses, écouvillon rectal ou pharyngé, etc.).
Par exception, le test peut ne pas être réalisé si les symptômes cliniques sont suffisamment évocateurs et que les diagnostics différentiels ont été écartés.
Pour les cas possibles non testés au regard des critères ci-dessus, la conduite à tenir est identique à celle des cas probables.

Les cas possibles non testés doivent être signalés à l'ARS en utilisant la fiche de DO, sans confirmation biologique du diagnostic mais en complétant tous les autres items de la fiche de DO.

En cas de cluster, seuls les 3 cas les plus récents doivent être testés.

Il est recommandé que les cas possibles présentant une forme clinique grave soient hospitalisés avec mise en place de mesures de protection contact + air jusqu'à l'obtention du résultat du test (cf. paragraphe 3.2).

Les cas possibles présentant des formes cliniques non graves doivent rester isolés à leur domicile dans l'attente du résultat.

En cas de test positif, le cas possible devient un cas confirmé (Cf. ci-dessous). Une DO doit alors être envoyée à l'ARS.

En cas de test négatif, le cas est exclu. En l'absence de test, le cas reste possible.

Chez des cas possibles avec une date de début des signes ancienne (plus de 3 semaines), la PCR peut être négative, en particulier si la cicatrisation des lésions est très avancée. Pour certains d'entre eux, il y a un intérêt à documenter l'infection pour des raisons épidémiologiques (clusters particuliers, cas pédiatriques, cas féminins, …).

Il peut être décidé au cas par cas de réaliser une analyse sérologique au CNR pour documenter l'infection. Ces cas devront être discutés et validés avec le CNR, la DGS et Santé Publique France en amont de toute envoi au CNR.

### 3.1.3 Cas probables

Il n'est pas nécessaire de tester les cas probables (forte valeur prédictive positive de la définition à ce stade de l'épidémie) et de les confirmer biologiquement mais le contact tracing doit être réalisé et une fiche de DO doit être adressée à l'ARS.

Cependant, si le cas probable est testé, en cas de test négatif, il est exclu[1].

Les cas probables doivent faire l'objet d'une investigation destinée à déterminer les circonstances les plus probables de leur contamination.

Le contact tracing est assuré par l'ARS (liste les personnes-contacts à risque d'infection et les contacte).

---

[1] Si un cas probable est testé à distance de la date de début des signes (plus de 3 semaines), la PCR peut être négative. S'il y a un intérêt à documenter l'infection pour des raisons épidémiologiques (clusters particuliers, cas pédiatriques, cas féminins, …), il peut être décidé au cas par cas de réaliser une analyse sérologique au CNR pour documenter l'infection. Ces cas devront être discutés et validés avec le CNR, la DGS et SpF en amont de toute envoi de prélèvement au CNR.

Seront investigués de manière complète tous les cas confirmés et probables pédiatriques ou adultes féminins, ou un éventuel cas confirmé ou probable grave.
Pour les cas probables et confirmés adultes masculins non graves, seul un cas sur 5, choisi aléatoirement, sera investigué complètement.
Les autres cas adultes masculins seront joints pour recueillir des données minimales essentielles au suivi de l'épidémie (âge, date de début des signes, orientation sexuelle, nombre de partenaires).

Il est recommandé aux cas probables de s'isoler à domicile pendant 21 jours, ou jusqu'à la guérison complète des lésions cutanées et muqueuses (**cf annexe 4 à expliquer et remettre au patient).**

Les cas probables sont suivis par leur médecin. Il pourra être proposé en outre de réaliser pour ces cas une téléconsultation avec un infectiologue à J14 du début des signes, et en cas de guérison (cicatrisation complète de toutes les lésions) de les libérer de toute restriction.

### 3.1.4 Cas confirmés

Il n'est pas nécessaire de faire confirmer le cas par le CNR, toutefois, il est recommandé alors d'envoyer l'ADN viral au CNR pour enrichir la collection biologique nationale, et déterminer le clade viral.

En particulier, il est recommandé de réaliser le séquençage du génome viral dans les situations suivantes :

-cas confirmé ne présentant pas d'exposition à risque ou appartenant à un groupe populationnel jusqu'alors non touché par l'épidémie ;

-cas confirmé avec une présentation clinique inhabituelle.

Pour chaque cas confirmé, le signalement doit être fait sans délai à l'ARS et une fiche de DO doit être adressée en complément.

Les cas confirmés feront l'objet d'une investigation épidémiologique. Le contact tracing est assuré par l'ARS qui liste les personnes-contacts à risque d'infection et les contacte pour les informer et leur dispenser des recommandations.

Seront investigués de manière complète tous les cas confirmés et probables pédiatriques ou adultes féminins, ou un éventuel cas confirmé ou probable grave.

Pour les cas probables et confirmés adultes masculins non graves, seul un cas sur 5, choisi aléatoirement, sera investigué complètement. Les autres cas adultes masculins seront joints pour recueillir des données minimales essentielles au suivi de l'épidémie. Le contact tracing sera réalisé par l'ARS pour les cas dont l'investigation est complète, et sera remplacé par un contact warning réalisé par le cas auprès de ses personnes-contacts pour les cas non complètement investigués.

Il est recommandé aux cas confirmés de s'isoler à domicile pendant 21 jours, ou jusqu'à la guérison complète des lésions cutanées et muqueuses (**cf. annexe 4 à expliquer et remettre au patient).**

### 3.1.5 Personnes-contacts à risque

La recherche des personnes-contacts à risque est à effectuer par l'ARS et le patient pour les cas probables et confirmés, et pour les cas possibles qui ne sont pas testés en raison d'un diagnostic clinique certain et de l'exclusion des diagnostics alternatifs, à partir de la date de début des signes du cas index.

Une vaccination post-exposition avec un vaccin de 3e génération doit être proposée aux personnes adultes contacts à risque d'un cas confirmé ou probable (cf. paragraphe 3.4).

Cependant, si le premier contact à risque remonte à plus de 14 jours et qu'il existe des dates ultérieures de contact à risque rapportées, la vaccination peut être proposée dans les délais impartis à partir de la date de dernier contact.

Il est recommandé aux personnes contacts à risque de surveiller deux fois par jour leur température pendant 3 semaines après le dernier contact à risque avec le cas probable ou confirmé, la fièvre ou l'éruption signant le début de la contagiosité et étant souvent plus précoce que l'éruption.

En cas de fièvre ou d'éruption, les personnes-contacts à risque sont invitées à appeler leur médecin, un centre de santé ou le SAMU centre 15. Les bénéfices de cette surveillance sont de pouvoir mettre en place des mesures barrières dès le début des symptômes (isolement, masque) mais aussi de pouvoir bénéficier plus vite d'un test diagnostique si cela s'avère nécessaire et d'une prise en charge en cas de positivité.

L'ARS réalisera un suivi téléphonique en début de période d'auto-surveillance et à la fin afin de vérifier l'absence de symptômes, et de collecter les informations relatives à la vaccination des personnes contacts à risque et leur évolution (devenues des cas ou non).

**En établissement de santé, le contact tracing, la sensibilisation et les informations sur la vaccination post-exposition des personnes-contacts à risque sont assurés par l'établissement qui informe l'ARS en retour.**

## Dépistage microbiologique :

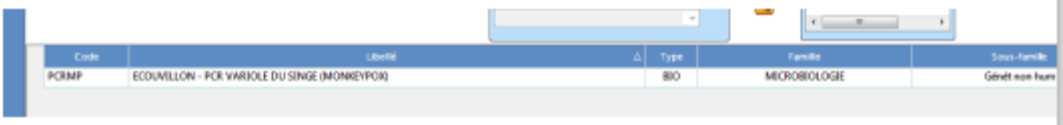
**Tester les cas suspects et possibles. Par exception, pour ces cas, le test peut ne pas être réalisé si les symptômes cliniques sont suffisamment évocateurs et que les diagnostics différentiels ont été écartés.**

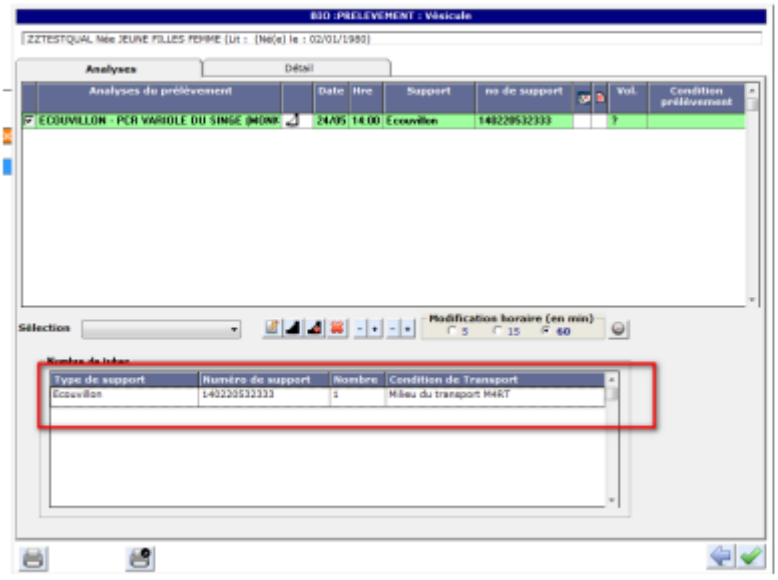
**Il est inutile à ce stade de l'épidémie, de tester les cas probables.**

Par PCR => Prélèvement de préférence cutané (biopsie, ou écouvillon en frottant plusieurs vésicules), ou bien naso-pharyngé si poussée éruptive dans la bouche ou la gorge.

| Nature du prélèvement | Description |
|---|---|
| Prélèvements muqueux | Écouvillonnages de lésions muqueuses hors sphère oropharyngée (génitaux et anaux) |
| Prélèvements cutanés | Écouvillonnages et/ou biopsies de lésions cutanées |
| Prélèvements de la sphère oropharyngée | Écouvillonnages oropharyngés (nasopharyngés possibles) |

Privilégier la prescription connectée PCBM :



## Réalisation et envoi des prélèvements par les soignants :

**HABILLAGE (cf. annexe 2a)**

**PREPARER** les étiquettes et le Bon de demande avant de prélever : identification du patient, localisation exacte du site de prélèvement, et mention explicite de « recherche de MonkeyPox virus» ;

**PRELEVER**
Ecouvillonner la lésion, à l'aide d'un 1 écouvillon sécable dans un tube de transport viral (type Virocult, M4RT), puis retirer l'écouvillon et l'introduire directement dans le tube contenant du milieu de transport viral ;

**DECONTAMINER** les tubes de prélèvement à l'intérieur de la chambre/box avant leur mise en triple emballage. –
- Désinfecter la surface des tubes de prélèvement à l'aide d'une lingette désinfectante
- Retirer la paire de gants
- Réaliser une friction des mains avec SHA.

**EMBALLAGE :**
**Le 1er CONDITIONNEMENT EST REALISE A L'INTERIEUR DE LA CHAMBRE/BOX**
- Etiqueter le tube avec les étiquettes issues de la PCBM,
- S'assurer que le tube de transport viral qu'il est bien refermé hermétiquement
- Mettre le tube dans le premier SACHET PLASTIQUE (risque Biohazard),
- Retirer la surblouse et le tablier,
- Réaliser une friction hydro-alcoolique des mains avec SHA, - Sortir de la chambre/box avec le prélèvement.

**Le reste du CONDITIONNEMENT est fait A L'EXTERIEUR DE LA CHAMBRE/BOX**
- Mettre le sachet dans le sac kangourou, avec le bon de demande dans la pochette Kangourou
- Le tout doit être positionné dans un contenant rigide (Boite de transport) qui aura été préalablement récupéré à l'accueil du laboratoire par le coursier et sur lequel il sera explicitement mentionné la « recherche de MonkeyPox virus »

**ACHEMINEMENT** Les échantillons sont transportés par coursier à l'accueil central des laboratoires : ne pas utiliser le pneumatique pour l'acheminement des échantillons ;

**INFORMER** l'équipe de microbiologie de l'envoi de l'échantillon aux postes 8123 (accueil microbiologie) ou 8197 (internes microbiologie) ou 7070 (sénior microbiologie). ou par mail à labomicrobio@ghpsj.fr ou infectieux@ghpsj.fr

## Checklist Monkeypox (cf. annexe 3 à 5) :

□ **Donner l'ordonnance type, arrêt de travail (21 jours si forte suspicion et lettre d'information)**

□ **Pour les cas possibles, probables et confirmés : Faire la DO à l'ARS et la faxer au 01 44 02 06 76. Pas de DO pour les cas suspects.**
=> Identification précoce des personnes contact à risque avec l'ARS (patients et personnels).
=> Il est recommandé aux personnes contacts à risque élevé ou modéré de surveiller deux fois par jour leur température pendant 3 semaines après le dernier contact à risque avec le cas probable ou confirmé, la fièvre signant le début de la contagiosité et étant plus précoce que l'éruption.
Prévenir le patient qu'il sera contacté par l'ARS et Santé publique France

□ **Prévenir Santé Publique France au 07 64 55 93 28**

□ **Prévoir bilan IST systématique à J30 si FR d'IST**

□ **Déclarer le cas à la CPIN**

**Numéros utiles :**

**Etablissements référents :**
Bichat 01 40 25 80 80
□ ESR Bichat (Tél : 01 40 25 78 04)
Standard (nuit, we et jours fériés) : 01 40 25 80 80 demander l'infectiologue de garde

Pitié Salpêtrière 01 42 16 00 00
□ ESR Pitié-Salpêtrière (Tél : 01 42 16 01 07)

**CNR** : Laboratoire Expert des Orthopoxvirus, tél : 06 03 87 58 59

**ARS :**
E-mail : ars75-alerte@ars.sante.fr
Tél : 0 800 811 411
Fax : 01 44 02 06 76

## 3.2. Mesures en hospitalisation

### 3.2.1 Précautions air et complémentaires contact et port de gants systématique

Patient contagieux du début des symptômes jusqu'à guérison complète des lésions cutanées.

- ***Pour le patient*** **:**

  - Patient en chambre seule.
  - Mettre en place les mesures d'isolement air et contact et port de gants
  - Matériel dédié au patient (stéthoscope, thermomètre, brassard…)
  - Maintien du patient dans sa chambre

  - Faire porter au patient un masque chirurgical en présence d'une autre personne dans la chambre

En cas de nécessité de sortir de la chambre, lui demander de mettre son masque chirurgical et de pratiquer une friction des mains au SHA + couvrir les lésions cutanées

Maintenir la porte de la chambre fermée. **Aération de la chambre au moins de 10 minutes par heure en l'absence de possibilité d'arrêt du traitement d'air.** Demander au patient d'ouvrir sa fenêtre régulièrement s'il est autonome.

- Circuit de la vaisselle :

  - Si présence d'un lave-vaisselle dans le service : circuit habituel (cycle à 60°C)
  - Si absence de lave-vaisselle dans le service :
    - Couverts et vaisselle jetables pour le petit déjeuner
    - Les plateaux suivent le circuit habituel.

- ***Pour le personnel :***

- Renforcement de l'utilisation des SHA
- Matériel nécessaire :
  - Masque FFP2 avec Fit check,
    Protection de sa tenue : surblouse en tissu. Tablier plastique à mettre par-dessus la surblouse si soins mouillants/souillants.
  - Port de gants
  - Lunettes de protection ou visière
    Une paire de gants non stériles uniquement pour les soins avec contact avec un liquide biologique les muqueuses ou une peau lésée.
  - Lingettes désinfectantes
  - Précautions lors de la manipulation du linge souillé (literie, serviettes, vêtements personnels) pour éviter tout contact. Le linge souillé ne doit jamais être secoué ou manipulé d'une manière susceptible de disperser des particules infectieuses.

► ***Gestion des déchets de soins et effluents : filière DASRI***

► ***Bionettoyage à ANIOS OXY'FLOOR selon annexe 2-.*** Porter l'EPI approprié (cf ci-dessus).

► ***Linge : ne pas le secouer -*** Pour éviter tout risque d'aérosolisation, **le linge** doit être manipulé avec précaution. À la sortie de la chambre : mettre le linge dans le sac à linge, disposé au plus près de la porte de la chambre, sur le charriot de linge sale.

### 3.2.2 Prise en charge d'un patient en imagerie ou au bloc opératoire

Si un examen d'imagerie ou une prise en charge au bloc est indispensable, un patient suspect d'être infecté par le Monkeypox virus devra être programmé en fin de programme (soit en fin de matinée, soit en fin d'après-midi).

**Les précautions complémentaires contact et air doivent être appliquées. Port de gants systématique**

Lors du transfert du patient, le patient doit porter un masque chirurgical.

**En imagerie :**

- Port d'un masque FFP2 par personnel avec Fit check

- Habillage du personnel prenant en charge le patient :
  - Protection de sa tenue : surblouse en tissu. Tablier plastique à mettre par-dessus la surblouse si soins mouillants/souillants.
  - Lunettes de protection ou visière
    Une paire de gants non stériles uniquement pour les soins avec contact avec un liquide biologique les muqueuses ou une peau lésée.
  - Lingettes désinfectantes
  - Précautions lors de la manipulation du linge souillé (literie, serviettes, vêtements personnels) pour éviter tout contact. Le linge souillé ne doit jamais être secoué ou manipulé d'une manière susceptible de disperser des particules infectieuses.

- Gestion des déchets de soins et effluents : filière DASRI
- Bionettoyage à ANIOS OXY'FLOOR selon annexe 2.

**Au bloc opératoire :**

- Dans le cadre d'une chirurgie non différable, **prendre en charge le patient en dernier au bloc opératoire.**

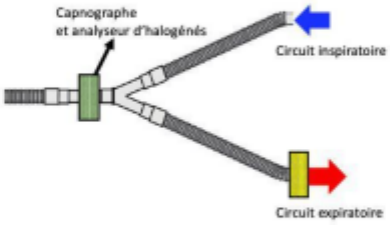
- Les personnels chargés de prendre en charge le patient dans la salle d'intervention doivent porter un masque FFP2.

- Limiter le nombre de personnes impliquées dans la prise en charge et sans sortie de salle ni échange de personnel durant toute la procédure.

- Protection de sa tenue (pour le personnel non opérateur) :
  - Surblouse en tissu. Tablier plastique à mettre par-dessus la surblouse si soins mouillants/souillants.
  - Lunettes de protection ou visière
  - Une paire de gants non stériles

- **Pour le respirateur, mettre deux filtres (cf. schéma ci-après)** :

  - ❖ Un filtre HEPA entre le masque facial et le circuit ventilatoire et/ou entre le tube trachéal et la pièce Y du circuit respiratoire ;
  - ❖ Un deuxième filtre HEPA doit être mis au niveau de la valve expiratoire.
  -




- Utiliser un système d'aspiration endotrachéal clos équipé d'un système d'un filtre jetable.
- En cas de ventilation manuelle, le masque doit être ajusté à deux mains afin de minimiser les fuites.
- En cas de prise en charge d'un patient transféré de réanimation déjà intubé et ventilé, le circuit de ventilation de transport ne doit pas être déconnecté pour éviter toute contamination. Si une déconnection est nécessaire, le filtre patient est laissé sur la sonde. Une pause expiratoire de la ventilation associée à un clampage de la sonde d'intubation est recommandée.

- **A la fin de la procédure** : réaliser une friction hydro-alcoolique avant le déshabillage.
- Le matériel anesthésique est nettoyé avec des détergents désinfectants habituels.
- Tout le matériel non protégé par filtre hydrophobe utilisé pour la ventilation et le matériel pour l'intubation est jeté ou désinfecté par un détergent désinfectant standard (Surfanios, …) (manche laryngoscope).
- **Réveil et extubation en salle d'intervention puis transfert dans sa chambre.**
- Réaliser le bionettoyage selon annexe 2.

### 3.2.3 – Conduite à tenir aux endoscopies

- Si un examen est indispensable il est réalisé **en fin de programme**. Un bionettoyage de fin de programme opératoire sera réalisé selon l'annexe 2. L'endoscope suit le cycle de désinfection habituelle.

- Pour les patients hospitalisés en réanimation, les examens doivent être réalisés dans le service de réanimation. En l'absence de bronchoscope à usage unique, l'endoscope utilisé sera mis dans un double sac fermé avant d'être transporté dans le service d'endoscopie ou il suivra une désinfection classique. La console sera nettoyée avec le matériel et les produits disponibles dans le service de réanimation.

- En salle d'endoscopie, l'ensemble des personnels médicaux et non-médicaux au contact du patient doit porter un FFP2, un tablier, des lunettes de protection et une paire de gants non-stériles.

- La désinfection des mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique doit être renforcée avant et après contact avec les patients.

## 3.3 Mesures si retour à domicile du patient (cf. checklist et annexe 3 à 5)

-Déclaration obligatoire à l'ARS pour cas possible, probable et confirmé
-Isolement respiratoire et cutané à domicile : port de masque chirurgical (si impossible, port de masque par les autres membres du foyer), éviter si possible les contacts physiques, et le partage du linge de maison, de la literie et de la vaisselle avec d'autres personnes, nettoyage soigneux du domicile (sol, surfaces) avec un détergent-désinfectant du commerce, lavage du linge en machine (30 min à 60°C).
-Arrêt de travail pour 3 semaines, renouvelable jusqu'à guérison complète
-Pas de vaccination en cas de maladie prouvée (mais intérêt en prophylaxie post-exposition pour les contacts)
-Bilan à faire en ville à 1 mois
-Consultation de suivi entre J14 et J21

## 3.4 Vaccination (cf. recommandations de l'HAS)

### 3.4.1 Indication de la vaccination préventive

**Elle est indiquée pour les groupes les plus exposés au virus :**
-Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) et les personnes trans rapportant des partenaires sexuels multiples ;
-Les personnes en situation de prostitution ;
-Les professionnels des lieux de consommation sexuelle, quel que soit le statut de ces lieux.
Elle peut être envisagée au cas par cas pour les professionnels amenés à prendre en charge les personnes malades.

La HAS ne recommande pas, à ce stade, la vaccination en préexposition des professionnels de santé prenant en charge les personnes malades, les mesures d'hygiène habituelles et le port d'équipement de protection individuelle rendant le risque de contamination très faible en pratique.
Néanmoins, la HAS recommande que cette vaccination puisse être envisagée au cas par cas, selon l'exposition, l'existence de facteurs de risque individuels ou à leur demande.

Le schéma vaccinal est constitué de deux doses (ou trois doses chez les sujets immunodéprimés), espacées de 28 jours. Ce schéma est réduit à une dose pour les personnes ayant déjà été vaccinées contre la variole. Les caractéristiques des deux vaccins disponibles (Imvanex® ou Jynneos®) permettent leur interchangeabilité : la seconde dose peut ainsi se faire avec un vaccin différent de la première. Un espacement des doses de plusieurs semaines pourra être envisagé en cas de tension d'approvisionnement des vaccins.

### 3.4.2 Vaccination post-exposition

Cette vaccination est indiquée pour les personnes adultes contacts à risque élevé de variole du singe tels que définis par Santé publique France (cf. définitions chapitre 2), incluant les professionnels de santé exposés sans mesure de protection individuelle.

Cette vaccination est faite en post-exposition avec le vaccin Imvanex® ou Jynneos®, dit de troisième génération administré idéalement dans les 4 jours après le contact à risque et au maximum 14 jours plus tard avec un schéma à deux doses (ou trois doses chez les sujets immunodéprimés), espacées de minimum 28 jours.

# Annexe 1 : Monkeypox : Exposition et Clinique pour les soignants de 1ère ligne

Les patients avec des formes graves seront adressés en première intention dans les établissements de santé de référence (ESR) REB.

## Patient suspect= Tableau clinique ET exposition compatible
## Incubation habituelle de 7 à 14 jours (min 5j- max 21 jours)

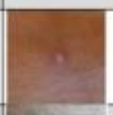
### Clinique :

**Tableau clinique, 2 phases de l'infection :**

• Phase initiale, prodromique non spécifique : fièvre >38°C, frissons, polyadénopathies cervicales et inguinales en particulier, myalgies, asthénie.

• Phase d'éruption, 1 à 3 jours après début de la fièvre, en une seule poussée : macules, puis papules, vésicules, pustules, croûtes, sur le visage puis sur l'ensemble du corps incluant paumes et plantes.

• Recherche de signes de gravité : létalité peu documentée (jusqu'à 10% des cas). Les complications peuvent être : éruption majeure (plus de 100 vésicules), formes digestives, ORL avec compressions locales, atteinte cornéenne, signes encéphalitiques, sepsis, surinfection, pneumopathie. Ces formes-là nécessitent une hospitalisation en ESR, voire en CHU si conditions requises (cf. avis HCSP).

| LE PATIENT EST CONTAGIEUX PENDANT TOUTES LES PHASES CLINIQUES | | |
|---|---|---|
| Délai approximatif | Phase clinique (source CDC) | Illustration (source gov.uk) |
| J0 | Phase prodromique non spécifique : fièvre >38°C, poly adénopathie, myalgies, asthénie | |
| J1-2 | Enanthème 1ères lésions = bouche / langue | |
| J2-3 | Macules<br>Rash centrifuge débutant sur la face et se répandant vers les membres en 24h, puis les paumes des mains et plantes des pieds | |
| J3 | Papules | |
| J4-5 | Vésicules (liquide clair)<br>∅ = 3mm |  |
| J6-7 | Pustules (liquide opaque) pointues, fermes<br>∅ = 2mm |   |
| | Pustules ombiliqués<br>∅ = 3-4mm |  |
| | Pustules ulcérés<br>∅ = 5mm |  |
| J12 | Formation de croûte sur lésion mature |  |
| A partir de J14 | Croûte en cours de cicatrisation<br>*A noter : le patient reste contagieux jusqu'à la cicatrisation complète après chute des croûtes* |  |

**Diagnostic différentiel : varicelle (mais lésions d'âges différents épargnant paumes et plantes), rougeole, variole (pas d'adénopathies), infections bactériennes cutanées, syphilis, gale, allergies**

## Annexe 2 a : CONSIGNES D'HABILLAGE/ DESHABILLAGE FACE A UN PATIENT PRESENTANT DES SIGNES D'INFECTION A MONKEY POX VIRUS.

### HABILLAGE :

AVANT D'ENTRER DANS LA CHAMBRE / BOX : en respectant l'ordre d'habillage

| | |
|---|---|
| **Mettre un masque FFP2 (après FHA).**<br>Ajuster la barrette nasale (doigts à plat)<br>En cas de port de lunette de vue garder les lunettes lors de l'ajustement du masque.<br>1 **Repérer le haut (barrette nasale).**<br>2 **Passer les élastiques derrière la tête, de part et d'autre des oreilles.**<br>3 **Vérifier que le masque couvre bien le menton** |  <br>1 2 3 |
| Réaliser un Fit-check:<br>Vérifier l'absence de fuite sur les bords en réaliser une forte expiration.<br>Vérifier que le masque se creuse en réalisant une forte inspiration. (le masque doit se creuser) Buée sur lunettes = non protégé<br>4 **Ajuster le masque en pinçant la barrette**<br>5 **Tester l'étanchéité : placer les mains sur le masque et inspirer ; le masque doit se plaquer sur le visage.**<br>6 **Après usage, retirer le masque par les élastiques.** |  <br>4 5 6 |
| |   |

**ORDRE D'HABILLAGE :**

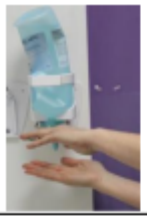
| | |
|---|---|
| 1. Hygiène des mains |  |
| 2. Pose du masque FFP2 selon explications précédentes |  |
| 3. Enfilage de la surblouse et du tablier éventuel |  |

| | |
|---|---|
| 4. Pose des lunettes de protection ou visière |  |
| 5. Hygiène des mains |  |
| 6. Enfilage des gants |  |

NE PAS SE TOUCHER LE VISAGE PENDANT UN SOIN. RENFORCER L'HYGIENE DES MAINS PAR FRICTION HYDRO-ALCOOLIQUE +++

## DESHABILLAGE

**DANS LA CHAMBRE / BOX : en respectant l'ordre de déshabillage**

| | |
|---|---|
| **Eliminer le tablier, les gants et la surblouse dans la filière DASRI (Si surblouse en tissu, dans le circuit du linge).** | |
| **Se frictionner les mains et les avants bras avec une solution hydroalcoolique (SHA).** |  |

**APRES ETRE SORTI DE LA CHAMBRE / BOX DU PATIENT**

| | |
|---|---|
| **Nettoyer les lunettes ou la visière avec une lingette désinfectante.** |   |
| **Garder le masque FFP2** |  |
| **Se frictionner les mains et les avants bras avec une solution hydro-alcoolique (SHA)** |  |

## Annexe 2b :

## BIONETTOYAGE D'UNE SALLE APRES UN PATIENT SUSPECT D'INFECTION A MONKEYPOX VIRUS avec un matériel DEDIE

**EPI : surblouse à usage unique à manches longues, tablier plastique, masque FFP2, lunettes de protection, gants.**

| | | |
|---|---|---|
| **Produit** | Anios OXY'FLOOR  | Un bandeau (pour le sol) et des chiffonnettes (pour les surfaces) |
| **Dilution** | 1 sachet / 5L d'eau froide ou tiède | **NE PAS RINCER** |
| **Temps de contact produit** | 5 minutes **jusqu'à séchage complet** | |

**OU PAR DEFAUT, SI ABSENCE D'ANIOS OXY'FLOOR :**

| **BIONETTOYAGE** | | |
|---|---|---|
| **Produit** | Détergent : GREEN'R FLOOR ou DETERGANIOS ou équivalent | Un bandeau (pour le sol) et des chiffonnettes (pour les surfaces) |
| **Dilution** | 1 sachet 20 ml / 8L<br>(OU)<br>1 dose de 5 ml / 2L | |
| **RINCER AVEC UN NOUVEAU BANDEAU, LAISSER SECHER** | | |
| **Produit** | Eau de javel diluée à 0.5 % | Un bandeau (pour le sol) et des chiffonnettes (pour les surfaces)<br>**NE PAS RINCER** |
| **Dilution** | 250 ml d'eau de Javel à 2.6 % + 1L d'eau froide | |

# Annexe 3 : fiche de déclaration obligatoire

**République française**

| **Médecin ou biologiste déclarant (tampon)** | **Si notification par un biologiste** |
|---|---|
| Nom : | **Nom du clinicien :** |
| Hôpital/service : | |
| Adresse : | Hôpital/service : |
| Téléphone : | Adresse : |
| Télécopie : | Téléphone : |
| **Signature :** | Télécopie : |

Maladie à déclaration obligatoire — cerfa

**Orthopoxviroses dont la variole**

**Important : tous les cas suspects de variole sont à signaler immédiatement par tout moyen approprié (téléphone, télécopie…) au médecin de l'ARS avant même confirmation ou envoi de cette fiche. Pour les autres orthopoxviroses, seuls les cas confirmés ou probables (voir définitions dans l'encadré) sont à signaler.**

Initiale du nom : ☐ Prénom : ..... Sexe : ☐ M ☐ F Date de naissance : ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

**Code d'anonymat :** ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ *(A établir par l'ARS)* **Date de la notification :** ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

✂ ----------

**Code d'anonymat :** ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ *(A établir par l'ARS)* **Date de la notification :** ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

Sexe : ☐ M ☐ F Date de naissance : ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ Code postal du domicile du patient : ☐☐☐☐☐

**Confirmation biologique du diagnostic :** ☐ oui ☐ non

– Technique utilisée : ☐ PCR ☐ microscopie électronique

– Diagnostic d'espèce : ☐ variole ☐ cowpox ☐ monkeypox ☐ autre orthopoxvirose, préciser : .....
☐ diagnostic d'espèce non réalisé

– Site du prélèvement : ☐ lésion cutanée ☐ énanthème buccal
☐ prélèvement sanguin ☐ examen post-mortem ☐ autre, préciser : .....

La souche a-t-elle été envoyée à un laboratoire d'expertise des Orthopoxvirus : ☐ oui ☐ non Nom du laboratoire : .....

**Date début des premiers signes cliniques :** ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

Hospitalisation : ☐ oui ☐ non Si oui, date d'hospitalisation : ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

Lieu d'hospitalisation : .....

Evolution : ☐ guérison ☐ en cours ☐ décès ☐ séquelles, préciser : .....

**Orthopoxviroses autres que la variole**

- **Cas confirmé** : signes cliniques évocateurs et confirmation biologique ou histopathologique.
- **Cas probable** : signes cliniques évocateurs et lien épidémiologique avec un cas confirmé.

**Origine possible de la contamination :**

☐ contact avec au moins un cas humain d'orthopoxvirose : ☐ oui, cas confirmé(s) ☐ oui, cas suspecté(s) ☐ non ☐ ne sait pas

Si contact avec au moins 1 cas d'orthopoxvirose confirmé biologiquement, nature de l'orthopoxvirose :

☐ variole ☐ autre orthopoxvirose, préciser : .....

Si oui, date ou période de contact dans les trois semaines précédant les premiers signes : ☐☐/☐☐/☐☐☐☐ à ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

☐ laboratoire biologie/recherche

☐ séjour à l'étranger dans les trois dernières semaines Si oui, pays : ..... Date de retour : ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

☐ contact avec un animal infecté Si oui, espèce animale concernée : .....

L'orthopoxvirose animale était-elle : ☐ suspectée ☐ confirmée

Le patient exerce-t-il une profession médicale ou paramédicale : ☐ oui ☐ non Si oui, laquelle : .....

**Vaccination antivariolique du patient :**

Avant 1984 : ☐ oui ☐ non ☐ ne sait pas Si oui, nombre de doses : ☐ ☐ ne sait pas Année dernière dose : ☐☐☐☐ ☐ ne sait pas

Après 2002 : ☐ oui ☐ non Date : ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

Contexte de la vaccination : ☐ contact d'un cas ☐ contact d'un contact ☐ autre, préciser : .....

Si contact d'un cas, délai en jours entre premier contact avec le cas index en phase symptomatique et vaccination : ☐☐

**Mesures de contrôle (variole) :**

Isolement du malade : ☐ oui ☐ non Si oui, date du début d'isolement : ☐☐/☐☐/☐☐☐☐

Nombre de sujets contacts identifiés : ☐☐ Nombre de sujets contacts vaccinés : ☐☐ ☐ ne sait pas

Nombre de sujets contacts vaccinés dans les 4 jours suivant le premier contact avec le cas index en phase symptomatique : ☐☐ ☐ ne sait pas

**Autres cas dans l'entourage (suspectés ou confirmés) :** ☐ oui* ☐ non ☐ ne sait pas Si oui, nombre (si moins de 10) : ☐☐ 10 ou plus ☐

* Remplir une fiche pour chaque cas suspecté ou confirmé.

✂ ----------

| **Médecin ou biologiste déclarant (tampon)** | **Si notification par un biologiste** | **ARS (signature et tampon)** |
|---|---|---|
| Nom : | **Nom du clinicien :** | |
| Hôpital/service : | | |
| Adresse : | Hôpital/service : | |
| Téléphone : | Adresse : | |
| Télécopie : | Téléphone : | |
| **Signature :** | Télécopie : | |

*Maladie à déclaration obligatoire (Art L 3113-1, R 3113-1, R 3113-2, R 3113-5, D 3113-7 du Code de la santé publique)*

*Information individuelle des personnes - Droit d'accès et de rectification pendant 6 mois par le médecin déclarant (loi du 6 janvier 1978) - Centralisation des informations à l'Institut de veille sanitaire*

## Annexe 4 : fiche d'information au patient

COREB mission nationale

Mission COREB Nationale
*Etat des connaissances au 3 juin 2022*

### Monkeypox virus (variole du singe)

#### Fiche d'information au patient, après le diagnostic

**Qu'est-ce que le Monkeypox ? Comment se transmet-il ?**

Le Monkeypox est une maladie due à un virus qui circule habituellement en Afrique centrale et de l'Ouest et, depuis mai 2022, dans différents pays du monde. Elle peut être transmise par des rongeurs ou des primates (d'où son nom). Elle se transmet aussi entre personnes, en particulier la famille et les proches. Le virus est apparenté à la variole mais le Monkeypox est moins grave.

Dans la majorité des cas, les malades ont des symptômes légers qui peuvent être traités à domicile, et vont disparaître en 2 à 4 semaines : d'abord fièvre, maux de tête, courbatures notamment dans le dos, et ganglions dans le cou ou à l'aine ; après 1 à 3 jours, apparition de boutons sur le visage, puis très rapidement sur tout le corps, jusqu'aux paumes des mains et plantes de pieds, et qui se transforment en croûtes puis tombent. La guérison est sans séquelles avec des soins appropriés. **Les personnes immuno-déprimées, les femmes enceintes et les jeunes enfants seraient plus à risque de développer une forme grave de la maladie**.

**Depuis les premiers signes, jusqu'à la cicatrisation complète de la peau**, la personne malade est contagieuse. Le virus se transmet par contact direct avec la peau ou les muqueuses (bouche, rapports sexuels), ainsi que par les gouttelettes (salive, éternuements, postillons...). On peut également se contaminer au contact des croûtes tombées et de l'environnement du malade (literie, vêtements, vaisselle, linge de bain...). Il est donc important que les personnes malades respectent un isolement pendant toute la durée de la maladie.

**Que faire au domicile pour se soigner et protéger mes proches ?**

→ **Bien respecter le traitement donné par le médecin, car certains médicaments sont à éviter (ne pas prendre d'anti-inflammatoires notamment)**

→ **Quelques conseils d'hygiène** :

- Mains propres, ongles courts, ne pas se gratter, ne pas toucher les boutons
- Se laver les mains avant tout contact et régulièrement en utilisant de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique
- Eviter de prendre des bains, privilégier les douches et se sécher en tamponnant (sans frotter)
- Laver ses affaires personnelles séparément (vaisselle, linge à 60° si possible)
- Nettoyer/désinfecter régulièrement les surfaces touchées, surtout sanitaires (1 fois par jour), avec les produits habituels
- Si des croûtes tombent, elles peuvent être contagieuses, de même que les pansements et bandages souillés : les mettre dans un sac-poubelle spécifique à fermer, puis mettre dans un autre sac poubelle à fermer avant de le jeter avec les déchets ménagers

→ **Il vous est recommandé de vous ISOLER chez vous, durant le temps défini par le médecin** :

- Si possible dans une pièce séparée, pas de sortie ni de visite, sauf indispensable (médicale par exemple)
- Éviter tout contact physique (pas d'embrassade, contact peau à peau...)
- Porter un masque chirurgical en présence d'autres personnes
- Couvrir au mieux les éruptions ou boutons (vêtements, pansements)
- Ne pas partager ses effets personnels (objets, vaisselle, vêtements, linge de maison)
- Éviter tout contact avec les animaux domestiques (possibilité de transmission)

→ **Conseils aux proches** : se laver les mains régulièrement, éviter tout contact direct (peau à peau) avec la personne infectée ou ses effets personnels (vaisselle, linge, ...) et porter un masque chirurgical à sa proximité.

**Un avis médical est nécessaire, si...**

De nouveaux signes apparaissent : sur la peau => rougeur, douleur, chaleur et gonflement, fièvre supérieure à 38° pendant plus de 5 jours, toux / crachats, difficulté à respirer, mal de tête, désorientation, difficulté à vous déplacer, baisse de la vision

=> médecin responsable du suivi - **numéro à appeler** : .....ou **Centre 15**

## Annexe 5 : Modèle d'ordonnance à donner au patient

Ordonnance

Faire pratiquer dans un laboratoire de ville dans 1 mois

- Sérologie VIH
- Sérologie VHB
- Sérologie VHC
- Sérologie syphilis
- PCR gonocoque chlamydia 1er jet d'urine, anus, gorge

# 17. PEC D'UN PATIENT SUSPECT D'INFECTION DUE AU CORONAVIRUS DU MOYEN ORIENT (MERS-COV)



| Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph | **Prise en charge d'un patient suspect d'infection due au Coronavirus du Moyen Orient (MERS-CoV)** | **CPIN/T/PROT-108/19-11-2019** |
|---|---|---|
| | **Emetteur : Equipe Opérationnelle d'Hygiène (EOH)** | **Date de création : 06-10-2015**<br>**Nombre de pages : 4** |
| | rédigée par Carine Couzigou – Médecin hygiéniste-infectiologue | signature : CC |
| | Validée par C Gillard, infirmière hygiéniste-L Perniceni, Cadre infirmier hygiéniste - B Vidal, Médecin hygiéniste-infectiologue | Signature / CG – LP - BV |
| | Approuvée par O Ganansia - Médecin, Chef de service des Urgences | signature : OG |

**INFORMATIONS GENERALES :**

***Manuel de certification : 8g « Maitrise du risque infectieux »-***

**Objet :**
Cette procédure détaille la conduite à tenir face à tout patient présentant des signes amenant à le considérer comme un cas suspect d'infection due au Coronavirus du Moyen Orient (MERS-CoV)

**Domaines d'application** : les services de l'hôpital

**Documents associés ou de référence :**

- Avis du HCSP relatif à la définition et au classement des cas possibles et confirmés d'infection à MERS-CoV ainsi qu'aux précautions à mettre en œuvre lors de la prise en charge de ces patients -24 avril 2015

- Surveillance des infections liées au MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus)

- Définition de cas et signalement -Document mis à jour le 11 juin 2015.

- Actualisation de la procédure SPILF/COREB 24 juillet 2015 : Comment prendre en charge un patient suspect d'infection due au Coronavirus du Moyen Orient (MERS-CoV)

**1 - Rappel**

La grande majorité des cas identifiés à ce jour (plus de 1000 cas) ont été identifiés dans la péninsule Arabique. La contamination est interhumaine par voie respiratoire. Le délai d'incubation moyen est de 5,5 jours ; au delà de 14 jours après un dernier contact avec un sujet contagieux, le risque de déclarer la maladie est considéré comme nul.

## 2 – Définition

**La dernière version de la définition de cas est disponible sur le site de l'InVS.**

### 2.1 – Cas possible

**2.1.1 - Toute personne ayant voyagé ou séjourné dans les pays listés** -en pratique la Péninsule Arabique et pays limitrophes (Cf. site InVS : http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Maladies-infectieuses/Infections-respiratoires/Infection-a-coronavirus/Infection-a-nouveau-coronavirus-MERS-CoV) **qui, au cours des 14 jours après son retour, a présenté :** des signes cliniques de détresse respiratoire aiguë (SDRA) ou des signes d'infection du parenchyme pulmonaire confirmés par des anomalies sur la radiographie du thorax avec une fièvre $\geq 38°C$ et de la toux.

**2.1.2 - Tout contact** (ex : famille, soignants) d'un cas possible ou confirmé, ayant présenté une infection respiratoire aiguë quelle que soit sa gravité, dans les 14 jours suivant le dernier contact.

NB : Pour les contacts immunodéprimés ou présentant une pathologie chronique, il faut considérer également la survenue d'un syndrome fébrile, avec diarrhée et/ou tableau clinique sévère.

**2.1.3** - Toute personne ayant travaillé ou ayant été hospitalisée dans un établissement hospitalier dans un des pays listés et ayant présenté une infection respiratoire aiguë quelle que soit sa gravité, dans les 14 jours suivant le dernier contact avec cet établissement.

**2.1.4** - Toute personne ayant eu un contact proche avec un dromadaire ou un produit issu de l'animal (lait non pasteurisé, viande crue, urine) dans un des pays listés et ayant présenté quelle que soit sa gravité, dans les 14 jours suivant ce contact un syndrome respiratoire aigu.

Pour les personnes immunodéprimées ou présentant une pathologie chronique, il faut considérer également la survenue d'un syndrome fébrile avec diarrhée et/ou tableau clinique sévère.

### 2.2 - Cas confirmé :

Cas possible avec prélèvements indiquant la présence du nouveau coronavirus MERSCoV.

### 2.3 - Diagnostics alternatifs

Principaux autres diagnostics à envisager:

- la fièvre : autre virose banale/grippe, infection urinaire haute, typhoïde, arbovirose (fièvre de la vallée du rift, fièvre West Nile, fièvre à Phlébotomes), brucellose aiguë (endémique dans cette zone), paludisme (très peu probable mais quelques pays de la liste sont endémiques notamment pour Plasmodium vivax)

- le syndrome respiratoire : pneumopathie bactérienne (dont légionellose) ou virale autre

- la diarrhée fébrile : salmonellose mineure et autres diarrhées du voyageur

## 3 - Conduite à tenir devant tout cas suspect

### 3.1 - Mesures d'isolement

#### *3.1.1 - Aux urgences :*

**Devant tout patient consultant pour fièvre et syndrome respiratoire aigu dans les 14 jours suivant le retour d'une zone à risque d'infection au virus MERS-Cov) (péninsule arabique), l'agent administratif à l'accueil doit :**

- Prévenir l'IOA (6190) et le médecin sénior régulateur (7790)

• ***Pour le patient :***

- Demander au patient (et aux accompagnants) de porter un masque chirurgical (masque chirurgical et SHA à disposition sur le comptoir de l'accueil des urgences) et de faire une friction de mains avec le SHA (flacon à conserver par le patient)

- Installer immédiatement le patient dans le box 7 ou 8

- En cas de SDRA : réalisation des gestes médicaux nécessaires (réanimation si besoin) sans réalisation de bilan ou d'imagerie, l'urgence étant le transfert

- en cas d'absence de SDRA : réalisation d'une radiographie au lit du patient, la plaque doit être emballée. Cette radiographie est nécessaire au classement du cas. Possibilité de prélever un bilan biologique y compris des GDS en revanche pas de prélèvements microbiologiques respiratoires (ECBC, aspiration nasopharyngée…)
Si besoin des antibiotiques pourront être débutés avant le transfert.

• ***Le personnel y compris le manipulateur radio :***

**Mise en place de précautions complémentaire « air » et précautions complémentaires contact :**
- masque FFP2 à porter avant d'entrer dans le box, vérifier étanchéité (fit test)

- mettre la surblouse à usage unique dans le box

- port d'un tablier plastique si soins mouillant

- lunettes de protection si soins à risque de projection

- gants non stériles en systématique

- renforcement de l'utilisation des SHA

- les déchets seront éliminés selon la filière DASRI

***3.1.2 - En hospitalisation (si apparition de signes respiratoires pendant son séjour)***

**Patient en chambre seule :**

Maintien du patient dans sa chambre.

***Le personnel : mise*** en place de précautions complémentaire « air » et précautions complémentaires contact (cf. ci-dessus)

## 4 - Classement du cas

Le médecin sénior du service contacte le médecin régulateur du SAMU 75 (15)
Le médecin régulateur, en lien avec l'ARS (tel : 0825 81 14 11) classe le patient en cas possible ou cas exclu.

### 4.1 – Le patient est un cas possible

Le patient est transféré à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière (les enfants sont pris en charge à Necker) par le SAMU

- Avertir la direction : direction@hpsj.fr

- Avertir l'EOH

- Signaler à l'INVs. alerte@invs.sante.fr tel : 08 20 42 67 15

***4.1.1 Après transfert, bionettoyage de la chambre ou du box avant toute nouvelle utilisation :***

- Matériels à prévoir

  - Détergent : Déterg'anios® : Dilution : 10 ml pour 4 litres d'eau.

  - Eau de Javel diluée à 0,5% : 2 litres d'eau de Javel à 2,6% + 8 litres d'eau

  - Bandeaux

  - Chiffonnettes

  - Seaux

Le personnel en charge du patient doit effectuer le bionettoyage. Le personnel a une casaque imperméable à usage unique à manches longues, un tablier plastique, un masque FFP2 des lunettes de protections et une paire de gants en nitrile à longues manchettes ;

**- Si présence d'autres déchets liquides non recueillis dans le bassin : les recouvrir par de l'eau de Javel diluée.**

- Bionettoyage en 3 étapes :

- Nettoyage avec un détergent Déterg'anios®

- Rinçage à l'eau.

- Désinfection des sols et des surfaces avec la solution d'eau de Javel à 0,5%

- Laisser agir 30 minutes.

- Elimination des déchets dans un fut DASRI

### 4.2 - Le patient est un cas exclu

- Poursuite de la prise en charge classique

# 18. PEC D'UN PATIENT SUSPECT OU ATTEINT DE ROUGEOLE

HÔPITAUX Paris Saint-Joseph Marie-Lannelongue

**PRISE EN CHARGE D'UN PATIENT SUSPECT OU ATTEINT DE ROUGEOLE**

**[ne pas supprimer ce texte]**
**Version : [ne pas supprimer ce texte]**

| | |
|---|---|
| **Emetteur : [Ne pas supprimer ce texte]** | **Date de modification : [ne pas supprimer ce texte]**<br>**Date de modification :**<br>**Date de création :** |
| **Rédigée par :**<br>Carine COUZIGOU – Médecin Infectiologue Hygiéniste<br>Assaf MIZRAHI - Microbiologiste | **Signature :** |
| **Validée par :**<br>Nathalie CASTREAU-Anne FLORIN –Médecins du travail | **Signature :** |
| **Approuvée par :**<br>Olivier GANANSIA | **Signature :**<br>C |

**Objet :** Cette procédure détaille la conduite à tenir face à tout patient suspect de rougeole

**Domaines d'application :** Cette procédure s'applique à tous les services d'hospitalisation sur les Hôpitaux Paris Saint Joseph et Marie Lannelongue.

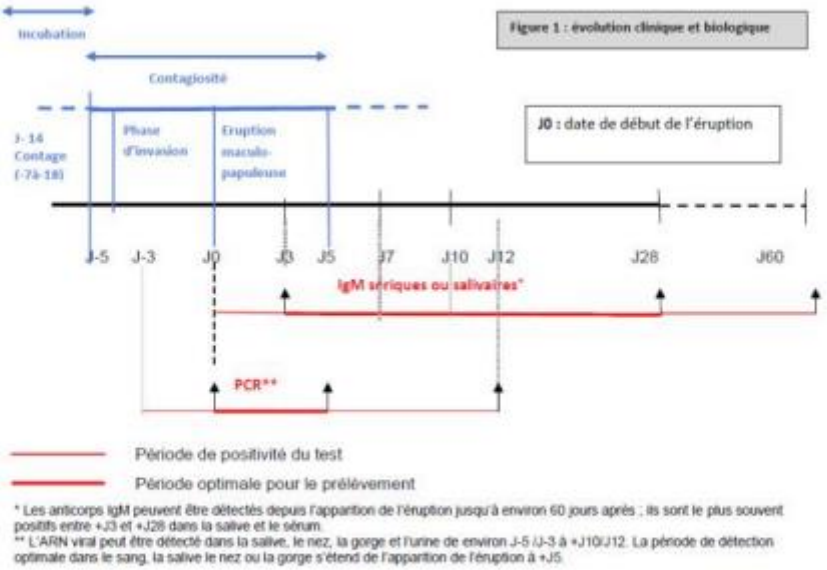
**Documents associés ou de référence :**

- MARS du 3 avril 2024- Vigilance renforcée dans le cadre de la recrudescence de la rougeole en Europe et en France
- Recommandations de la SF2H
- Santé Publique France
- Recommandations du calendrier vaccinal

## 1. Situation épidémique, contagiosité

On observe une recrudescence importante de la rougeole en Europe et dans le monde. En France l'incidence augmente depuis 2023 avec de nombreux foyers épidémiques.
La contagiosité est très importante ; la transmission du virus est directe par voie aérienne à partir des sécrétions nasopharyngées et, plus rarement, par des objets contaminés. La période d'incubation dure une dizaine de jours. La phase de contagiosité commence la veille de l'apparition des premiers symptômes, soit cinq jours avant le début de l'éruption, et s'étend jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption. Dans une population non immunisée, une personne contagieuse peut contaminer 15 à 20 personnes.

**Figure : Evolution clinique de la rougeole**




*Source : INSTRUCTION N° DGS/SP/SP1/2018/205 du 28 septembre 2018 relative à la conduite à tenir autour d'un ou plusieurs cas de rougeole*

## 2. Vaccination

Un sujet est immunisé contre la rougeole s'il a fait la maladie ou sa vaccination est à jour.
Vérifier son statut vaccinal contre la rougeole et le cas échéant à la mise à jour des vaccinations des patients selon les recommandations en vigueur du calendrier vaccinal dans le respect des contre-indications habituelles du vaccin trivalent ROR ;

– Toute personne née depuis 1980 doit avoir reçu deux doses de vaccins contre le ROR avec un délai d'au moins un mois entre les deux doses quels que soient les antécédents vis-à-vis des trois maladies ;
– Pour toute personne née avant 1980, non vaccinées et sans antécédent connu de rougeole, la vaccination avec une dose de vaccin trivalent ROR est fortement recommandée, sans contrôle sérologique préalable, pour les professions de santé ou toute personne exerçant dans les services accueillant des patients à risque de rougeole grave (immunodéprimés), au contact des enfants ou exposées au contact d'un cas de rougeole ;

La vaccination contre la rougeole peut être prescrite et administrée à tout public par un médecin ou une sage-femme ; Elle peut aussi être prescrite aux personnes de plus de 11 ans, sauf aux personnes immunodéprimées, par un pharmacien ou un infirmier ;

## 3. Signes cliniques

Le diagnostic est à évoquer devant tout patient, quel que soit son statut vaccinal, en présence :
**d'une fièvre ≥ 38,5°C associée à une éruption maculo-papuleuse et d'au moins un des signes suivants** :
conjonctivite, rhinite, toux, signe de Köplik.

La phase éruptive est une éruption maculopapuleuse qui persiste cinq à six jours et qui survient en moyenne quatorze jours après le contage. Elle débute au niveau du visage et derrière les oreilles et s'étend progressivement de haut en bas et vers les extrémités.

Otites et diarrhées sont les complications les plus fréquentes. Les complications sévères surviennent notamment chez les patients âgés de moins d'1 an et de plus de 20 ans : pneumonie, surtout chez l'enfant (2 à 7 %) et encéphalite aiguë, surtout chez l'adulte (0,5 à 1/1 000). La panencéphalite sclérosante subaiguë est une complication rare (estimée à 1 pour 100 000 patients infectés), tardive (en moyenne sept ans après la rougeole) et constamment létale. Les personnes immunodéprimées peuvent présenter des complications (pneumopathie interstitielle à cellules géantes ou encéphalite à inclusions) habituellement mortelles.

Une confirmation biologique est indispensable préférentiellement par prélèvement oropharyngé et amplification génique par RT-PCR (cf. ci-dessous).

## 4. Conduite à tenir

### 4.1 Signalement précoce

Maladie à déclaration obligatoire.
Tout cas cliniquement évocateur (y compris avant résultats biologiques) doit faire l'objet d'un signalement sans délai au point focal régional de l'Agence Régionale de Santé (ARS) par tout moyen approprié (téléphone, mail) ou à l'aide de la fiche déclaration obligatoire même si tous les items n'ont pu être renseignés, ils pourront être complétés par la suite.

**ARS** :
E-mail : ars75-alerte@ars.sante.fr
Tél : 0 800 811 411
Fax : 01 44 02 06 76

### 4.2 Précautions complémentaires air

Chambre individuelle, porte fermée. Aération régulière de la chambre
Mise en place des PC air (masque FFP2 pour les soignants et les visiteurs) ; chambre individuelle
Limiter les déplacements du patient au strict nécessaire ; masque chirurgical pour le patient.
Limiter les visites
Mesures d'éviction recommandées pendant toute la période de contagiosité du cas à savoir dès les premiers symptômes jusqu'à 5 jours après le début de l'éruption.
Désinfection des mains (précautions standard), bionettoyage, circuit du linge et des déchets habituels.

### 4.3 Prélèvement diagnostique oropharyngé pour PCR

L'ARN viral est détectable de quelques jours avant le début de l'éruption jusqu'à environ 10 jours après.
Faire un écouvillonnage nasopharyngé (idem que le tube pour PCRCOVID) pour réalisation d'une RT-PCR idéalement dans les cinq premiers jours suivant le début de l'éruption maculo-papuleuse le cas échéant.

La prescription doit se faire en prescription connectée *via* DxCare

| Code | Libellé | Δ | Type | Famille | Sous-famille |
|---|---|---|---|---|---|
| PCRROUG | ECOUVILLON NASO PHARYNGÉ - PCR ROUGEOLE | | BIO | MICROBIOLOGIE | Virologie |



Dans tous les cas, ces prélèvements ne doivent pas retarder le signalement précoce à l'ARS ni la mise en œuvre des premières mesures urgentes.

### 4.4 Prévention des cas secondaires si le patient n'a pas été isolé dès son arrivée à l'hôpital

***-Recenser les contacts parmi les personnels, les patients et leurs accompagnants pour :***

- Les informer et vérifier leur statut vaccinal
- Vacciner avec le ROR, si possible immédiatement, ou dans les 72h :
  - les nourrissons de 6 à 11 mois révolus
  - les personnes sans schéma vaccinal complet (cf. ci-dessus). NB : la vaccination reste recommandée si le délai de 72h est dépassé
- Si la vaccination est contre indiquée, organiser l'administration d'immunoglobulines polyvalentes dans les 6 jours pour les personnes à risque :
  - les nourrissons de moins de 6 mois dont la mère n'a pas d'ATCD de rougeole et n'a pas été vaccinée
  - les nourrissons de 6 à 11 mois n'ayant pu être vaccinés dans les 72 h suivant le contact
  - les patients ou personnels immunodéprimés
  - les femmes enceintes non vaccinées et sans antécédent de rougeole.

NB : Des cas de rougeole ont été décrits chez des personnes vaccinées. Aussi, en cas d'apparition de symptômes évocateurs, tout personnel doit :
-porter un masque chirurgical
-consulter un médecin, réaliser un prélèvement diagnostique
- ne pas se rendre sur le lieu de travail, informer l'encadrement du service

HÔPITAUX Paris

Saint Joseph — Marie Lannelongue

# PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES

## AIR

**A**

*Tuberculose, varicelle, rougeole*

## PROFESSIONNEL



Désinfection des mains avec PHA* **entrée/sortie** de chambre



Masque FFP2 **avant** de rentrer dans la chambre
Même en l'absence du patient



*Bionettoyage : Procédure habituelle*



*Circuit déchet : DASND (Déchets D'Activités de Soins Non Dangereux)*
*À jeter dans la chambre*



*Circuit linge : Normal*

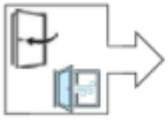


Gants seulement si contact avec liquides biologiques

## CHAMBRE



Chambre individuelle



**Porte fermée** et **aération régulière** de la chambre

## PATIENT



Masque chirurgical en sortant de la chambre



Désinfection des mains avec PHA* en sortie de chambre

## VISITEUR — Visites à limiter



Masque FFP2 avant d'entrer dans la chambre



Désinfection des mains avec PHA* **entrée/sortie** de chambre

** PHA : Produit Hydro-Alcoolique*

# 19. URGENCES PSYCHIATRIQUE HORS PRESENCE MEDECIN PSYCHIATRE AU SAU

Groupe hospitalier
Paris Saint-Joseph

## HORAIRES DE PRESENCE DU PSYCHIATRE DES URGENCES
## TOUS LES JOURS DE 9H00 Á 24H00

- **A partir de 23h00 : contre-visite du psychiatre de garde des demandes d'avis psychiatrique en attente.** Pour cela, une évaluation somatique des patients concernés est nécessaire avant 23h00, comprenant une alcoolémie en cas d'alcoolisation suspectée ou manifeste.

## ACCUEIL DES PATIENTS RELEVANT D'UN AVIS PSYCHIATRIQUE
## HORS DES HORAIRES DE PRESENCE DU PSYCHIATRE DES URGENCES

### 1. Indication d'une prise en charge SOMATIQUE AVANT un avis psychiatrique

En particulier :
- Intoxications aigues
- Confusion mentale
- Signe d'appel somatique

- Si :
1. ***Idée suicidaire (ou tentative de suicide)***
2. ***Agitation***
3. ***Trouble du comportement hétéro-agressif***

→

***Prévention des risques auto hétéro-agressif et de fugue :***
- Mise en Condition : pyjama, affaires personnelles retirées et notamment objets dangereux (objets tranchants, briquets, liquides, médicaments, ceinture, ...)
- Traitement symptomatique Agitation et/ou Anxiété.

- **Evaluation par le psychiatre des urgences le lendemain à 9h00** dès que l'état somatique le permet

### 2. Indication d'un AVIS PSYCHIATRIQUE SANS nécessité de surveillance médicale

- APRES examen somatique : **Appel CPOA au 01.45.65.81.09 ou 01.45.65.81.10** (Service d'Urgence Psychiatrique du Centre Hospitalier Sainte-Anne) pour avis spécialisé et transfert.

# 20. CONTENTION PHYSIQUE AU SAU

| Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph | **Contention physique aux Urgences** | **Indexation : Urgences/I/PROT-010/13-09-2016** |
|---|---|---|
| | **Emetteur : Service des Urgences** | **Date de mise à jour : 18/04/2016**<br>**Nombre de pages : 2**<br>**Date de création : 16/02/2010** |
| | ***Certification V 2014 Critère 10 e*** | |
| | rédigée par : Dr J. L. AIM | signature : JLA |
| | validée par : Dr O. GANANSIA | signature : OG |
| | approuvée par : C. GIRARD | signature : CG |

## ▶ INFORMATIONS GENERALES :

**Références :**

**Certification V 2014** : Gestion des mesures de restriction de liberté - Chapitre 2 *"Prise en charge du patient"*

- Rapport de l'ANAES d'octobre 2000 sur « L'évaluation des pratiques professionnelles dans les établissements de santé ; limiter les risques de la contention physique de la personne hospitalisée ».
- Recommandations de l'AFSSAPS du 28/02/2011 : **SENSIBILISATION SUR LE RISQUE D'ETOUFFEMENT LORS DE LA SECURISATION D'UN PATIENT A L'AIDE D'UN DISPOSITIF DE CONTENTION PHYSIQUE**

**Objet** : Protocole de prise en charge du patient agité et contention physique

**Domaines d'application** : Service des Urgences

**Mots clés : patient, contention, surveillance, risque**

## Règles

Réalisation

- 5 soignants minimum
- 1 seul interlocuteur pour le patient
- 1 soignant par membre + 1 tête + coordination
- 5 ou 3 points : Ventrale + 4 membres ou 2 membres
- Jamais de contention à 1 point (ventrale seule)

Mise en condition

- Déshabillage
- Surélever la tête
- Vérifier qu'aucun point ne soit douloureux ou compressif
- Recouvrir le patient d'un drap
- Chambre seule / porte entrouverte

**Prescription médicamenteuse obligatoire**

- Réaliser un ECG (si possible) avec analyse du QT
- Loxapac 100mg Per Os ou Im si refus de la voie orale
  ⇨ refaire une injection au bout de 45 min si pas d'efficacité
- Valium 10 mg en cas d'agitation due à l'alcool (sevrage ou intoxication)
  Pas de valium si âge > 70 ans ou confusion

**Surveillance obligatoire**

- Date et heure de la contention
- Fréquence 30min, 1h, 2h, 3h puis toutes les 2h
  - FC, FR, Sa02, Niveau de vigilance
  - Zones de compression: douleur, positionnement, caractère non compressif
- Assurer soins d'hygiène, la nutrition, l'hydratation et l'élimination.
- Heure de levée de la contention

# 21. COOPERATION PROFESSIONNELLE IOA – URGENCES : PRESCRIPTION DE RADIOGRAPHIE

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH — Hôpital Paris Saint-Joseph

**COOPERATION PROFESSIONNELLE**
**IOA URGENCES**

**1URG-PRT-021**
**Version : 01**

| | |
|---|---|
| **Emetteur : SJ - Urgences** | **Date d'application : 01/07/2021** |
| Rédigée par : Dr Mehdi LAFI | signature : ML |
| Approuvé et validée par : Dr Mehdi LAFI / Dr Olivier GANANSIA | signature : ML/OG |

**Objet :** coopération professionnelle aux urgences

**Domaines d'application :** URGENCES

**Vocabulaire : IOA :** infirmières organisatrices de l'accueil

**Documents associés ou de référence :** Proc douleur IOA urgences ; Fiche prescription imagerie. HAS coopération professionnelle.

**CONDUITE A TENIR :**

Dans le cadre de la coopération professionnelle aux urgences, des actes diagnostiques et thérapeutiques sont délégués aux infirmières par les médecins.

**Cas 1 :**
Prise en charge de la douleur à l'accueil des Urgences.
Les IOA sont formés à la prise en charge de la douleur dès l'accueil des urgences. Une prescription d'antalgique fait suite à une évaluation de la douleur. Les infirmiers sont formés à l'évaluation de la douleur et à l'administration d'antalgiques selon un protocole défini.
Cf : Formation IOA, protocole douleur

**Cas 2 :**
Prescription anticipée de radio dès l'accueil
Les IOA prescrivent des radios pour les patients dès l'accueil.
Elles reçoivent une formation spécifique en interne et peuvent prescrire des radios dans le cadre de mono-traumatisme des membres.

***PRESCRIPTION DE RADIOGRAPHIES ANTICIPÉE PAR L'IDE***

***FAISABILITÉ*** :
Patient coopérant, inspection facile, valide
Traumatisme distal mono-articulaire

***EXCLUSION*** :
Douleur non traumatique
Patient non valide
Traumatismes multiples (> ou = 2 localisations)
Traumatisme proximal (rachis, face)
Critères de gravité (instabilité hémodynamique)
Femmes enceintes

***PRESCRIPTION*** :
Localisation+ COTE+ Incidences minimum (F/P)
**Epaule** : F/P, + ou - Clavicule (facultatif)
**Coude** : F/P, Tête radiale
**Avant-bras** : F/P
**Poignet** : F/P, + ou - incidence scaphoide
**Main/Doigts :** F/P (préciser doigt, phalange P1P2P3)
**Hanche** : F/P, toujours bassin de face (facultatif)
**Genou** : F/P
**Jambe** : F/P
**Cheville** : F/P,+ ou - Pied F/P
**Pied/Orteil** : Pied F/P

**La mise en application implique des droits de prescription spécifiques dans Dxcare. Un profil spécifique au service des urgences a été mis en place.**
**Seules les infirmières formées au protocole peuvent l'exécuter.**

# 22. PROTOCOLE DE COOPERATION PROFESSIONNELLE : INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE (CO)

| Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph | **PROTOCOLE DE COOPERATION PROFESSIONNELLE**<br>**INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE (CO)** | **Indexation :**<br>**Urgences/I/PROT-172-4/ 04-07-2018** |
|---|---|---|
| | **Emetteur : Service des Urgences** | **Nombre de pages : 2**<br>**Date de création : JUIN 2018**<br>**Nombre d'exemplaires : 1** |
| | ***manuel de certification : V2014*** | |
| | rédigé par<br>V. POUYET, médecin<br>A. BOUREAU, cadre de santé | signature :<br>VP<br>AB |
| | validé par O. GANANSIA | signature : OG |
| | approuvé par D. SUMBAL | signature : DS |

**INFORMATIONS GENERALES :**

**Objet :** Montée en compétences des IDE + amélioration de la prise en charge des patients

**Domaines d'application :** IDE du Service des Urgences

**Vocabulaire :**

**Documents associés ou de référence :**
Lecomte F., Rogowska K., Allo JC. Intoxication au CO. Urgences-online 2015,
Intoxication aiguë par le monoxyde de carbone, Réan Urg 1992 ; 1 : 723,735,
Ellrodt A. Guide pratique des urgences médicales. Ed. Estem,
Fiche ARS Nord-Pas-de-Calais. Intoxication au monoxyde de carbone, mai 2014

## Pathologie :

Intoxication par inhalation de CO. Le CO (gaz inodore, incolore, insipide, volatil et explosif) est produit lors d'une combustion incomplète (appareil de chauffage mal réglé ou inadapté, ventilation insuffisante, fumées d'incendie).

Les signes non spécifiques sont fonction de la dose : céphalée (100ppm), fatigue et nausée (200ppm), vomissements et syncope (500ppm), coma (1000ppm). L'intoxication est à évoquer dans son caractère collectif, récidivant et/ou fonction de l'environnement.

L'intoxication associe une hypoxie et une toxicité cellulaire.

Le CO a une affinité 200 fois supérieure à l'$O^2$ sur l'hémoglobine.

La saturation est faussement rassurante (les deux gaz sont fixés).

## Critères de gravité :

- Perte de connaissance depuis l'intoxication.
- Trouble de la conscience (somnolence, confusion, désorientation)
- Femme enceinte (CO ayant une affinité majeure pour l'HB fœtale)
- Signes de choc

➔ Si signe de gravité, et après avis régulateur, installation en SAUV

En fonction de la clinique et du mode d'intoxication, l'oxygénothérapie hyperbare peut être recommandée (contacter le centre hyperbare de l'hôpital de Garches 01.47.10.77.82).

En cas d'intoxication aux fumées d'incendie, l'intoxication cyanée doit être évoquée, et prise en charge conjointement (cyanokit®).

**Conduite à tenir, intoxication CO simple = AUCUN CRITERE DE GRAVITE**

## IOA

- Oriente le patient vers la zone 1 (zone 2 si pathologie associée)
- Préviens l'IDE concernée
- Demande si le patient est fumeur ou non (modification du taux d'HbCO de base)

## IDE Zone

- Installation en position assise
- Mise en place oxygénothérapie haute concentration (MHC 8-10L d'$O^2$)
- Dosage de CO veineux
- Réalisation ECG à faire signer par médecin
- Evaluation par le médecin de zone dès que possible

# 23. PROTOCOLE DE COOPERATION PROFESSIONNELLE : RETENTION AIGUË D'URINE

| Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph | **PROTOCOLE DE COOPERATION PROFESSIONNELLE**<br>**RÉTENTION AIGUË D'URINES** | **Indexation :**<br>**Urgences/I/PROT-172-6/ 04-07-2018** |
|---|---|---|
| | **Emetteur : Service des Urgences** | **Nombre de pages : 2**<br>**Date de création : JUIN 2018**<br>**Nombre d'exemplaires : 1** |
| | ***manuel de certification : V2014*** | |
| | rédigé par<br>V. POUYET, médecin<br>A. BOUREAU, cadre de santé | signature :<br>VP<br>AB |
| | validé par O. GANANSIA | signature : OG |
| | approuvé par D. SUMBAL | signature : DS |

**INFORMATIONS GENERALES :**

**Objet :** Montée en compétences des IDE et amélioration de la prise en charge des patients

**Domaines d'application :** IDE du Service des Urgences

**Vocabulaire :**

**Documents associés ou de référence :**

**Pathologie** :

Incapacité complète ou partielle à uriner malgré une vessie pleine (A différencier de l'anurie).

Elle peut être simple ou la conséquence d'un caillotage post chirurgie urologique
Le bladder scan confirme la rétention à partir de 500ml d'urine dans la vessie.

**Ne seront pas inclus dans le protocole:**

- 1er sondage vésical chez l'homme
- Sténose urétrale connue
- Traumatisme de l'urètre
- Prostatite aiguë (diagnostiquée ou en cours de traitement)
- Infections des voies urinaires hautes ou basses de la femme (diagnostiquée ou en cours de traitement)
- Post opératoire des voies urinaires et prostate dans les 30 jours
- Bricker ou chirurgie reconstructrice des voies urinaires

**Conduite à tenir** :

**IOA**

- Rechercher signe de globe urinaire au bladder scan :
  - Dernière miction ?
  - Chirurgie prostatique récente ?
  - Hématurie ? Avec ou sans caillots ?
  - Douleur ? (Si oui, cf protocole douleur IAO)
- Prévenir MAO si chirurgie urologique récente pratiquée à ST JO
- Patient à inscrire en zone 2 systématiquement

Après installation en box, prévenir IDE qui prendra en charge le patient avant qu'il soit vu par un médecin.
Mettre le dossier dans la bannette des « installés non vus »

**IDE Zone** :

| Rétention simple | Rétention sur hématurie |
|---|---|
| - Pose de sonde de Foley (Clamper à partir de 500ml obtenus au moment de la pose, et déclamper après 15 minutes)<br>- BU + ECBU systématiques<br>- Faire la traçabilité dans Dx care (Pancarte – Surveillances – Diagramme de soin – Soins techniques)<br>- Bilan sanguin : NFS – IONO – TP/INR -TCA | - Pose de sonde double courant et commencer le lavage vésical<br>- Bilan entrées – sorties<br>- BU + ECBU systématiques<br>- Faire la traçabilité dans Dx care (Pancarte – Surveillances – Diagramme de soin – Soins techniques)<br>- Bilan sanguin : NFS – IONO – TP TCA (+INR si AVK) (Prélever des groupes + RAI au cas où déglobulisation) |

**PRISE EN CHARGE MÉDICALE DÈS QUE POSSIBLE**

# 24. PROTOCOLE DE COOPERATION PROFESSIONNELLE : PEC DES PLAIES

| Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph | **PROTOCOLE DE COOPERATION PROFESSIONNELLE**<br>**PeC des PLAIES** | **Indexation :**<br>**Urgences/I/PROT-172-5/ 04-07-2018** |
|---|---|---|
| | **Emetteur : Service des Urgences** | **Nombre de pages : 1**<br>**Date de création : JUIN 2018**<br>**Nombre d'exemplaires : 1** |
| | ***manuel de certification : V2014*** | |
| | rédigé par<br>V. POUYET, médecin<br>A. BOUREAU, cadre de santé | signature :<br>VP<br>AB |
| | validé par O. GANANSIA | signature : OG |
| | approuvé par D. SUMBAL | signature : DS |

**INFORMATIONS GENERALES :**

**Objet :** Montée en compétences des IDE et amélioration de la prise en charge des patients

**Domaines d'application :** IDE du Service des Urgences

**Documents associés ou de référence :**

**Port de gants de soins obligatoire (pas de gants stériles)**

**Quelles plaies?**

Plaies d'allure suturable, sans saignement important, de moins de 12 heures au niveau:
- Du cuir chevelu
- Du visage SAUF les paupières
- Des membres supérieurs et inférieurs

**Conduite à tenir**

**Si plaie non souillée** : Rincer abondamment à l'**eau du robinet ou eau en flacon** ou encore Sérum Physiologique
**Si plaie souillée (gravier, terre etc…)** : lavage **eau et savon** et enlever les corps étrangers superficiels

Essuyer en douceur la plaie avec la compresse mouillée d'eau
Pas d'indication à une désinfection d'emblée

Pulvériser **Xylocaïne Spray 5%** après le nettoyage (ou à défaut Xylocaïne gel)
Répartir les pulvérisations entre la plaie et la compresse
Ne pas dépasser 10 pulvérisations (pas de risque allergique, mais dose limite)

Le délai d'action en application sur les muqueuses et en infiltration est de 5 à 10 min et sa durée d'action est de 20 à 30 min.

Maintenir une compresse humide imbibée de Xylocaïne Spray 5% jusqu'à la suture

# 25. ACR CHEZ L'ENFANT

| | | |
|---|---|---|
| GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH — Hôpital Paris Saint-Joseph | **ARRET CARDIO RESPIRATOIRE DE L'ENFANT** | **1URG-PRT-035**<br>**Version 01** |
| **Emetteur : Service d'Accueil des Urgences** | | **Date d'application : 18/01/2022**<br>**Date de création : Mars 2012** |
| ***Certification V 2020*** | | Réf 25 ; critère 25.a (PEP) |
| Rédigé par Dr A PARIENTE urgentiste | | Signature : AP |
| Validé par Dr JL AIM adjoint chef de service desurgences | | Signature : JLA |
| Approuvé par Dr. O GANANSIA chef de servicedes urgences. | | Signature : OG |

**INFORMATIONS GENERALES :**

**Références :**

***Certification V 2020 : Réf 25 Prise en charge dans le service des urgences – critère 25 a : prise en charge des urgences et des soins non programmés***

- *AHA* 2010
- *European Council Guidelines for Resuscitation* 2015 Resuscitation 58-2015 1219 1276
- *Recommandations SFAR* 2018

**Objet :** Protocole de prise en charge d'un enfant présentant un arrêt cardiorespiratoire

**Domaines d'application :** Service d'Accueil des Urgences

**Mots clés :**

MCE : Massage cardiaque externe
MHC : Masque haute concentration
IOT : Intubation oro trachéale
TV : Tachycardie ventriculaire
RCP : Réanimation cardio pulmonaire

## PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE

**Ne concerne pas le nouveau-né**

**IAO : RECONNAITRE l'ACR**

- Apnée, respiration agonique, gasp
- Absence de réactivité neurologique
- Absence de pouls centraux (carotidien, fémoral), asystolie

## ALERTER, INSTALLATION EN BOX

- **Alarme arrêt cardiaque**
- **Appel médecin Régulateur 7790 + ALERTE ARRET CARDIAQUE 7333**
- **NEONAT DE GARDE AU 6708**
- **Déchoquage**
- **Appel du SAMU pour SMUR Pédiatrique**

## CONDUITE A TENIR

| A = airways | B = breathing | C = circulation |
|---|---|---|
| Libérer les voies aériennes | Ventiler | Masser |

Dans le même temps ➔ CHARIOT D'URGENCE PEDIATRIQUE

- VVP de gros calibre
- Ventilation au masque
- Bilan sanguin : NFS, CRP, Ionogramme sanguin, GDS, Lactate artériels, TP, TCA

## ALGORITHME DE PRISE EN CHARGE

- MCE 15/2
- Oxygénation ventilation MHC O2 15 L/min FiO2 100%
- Tenter l'Intubation orotrachéale
  - La ventilation est aussi efficace que l'IOT, l'essentiel est d'assurer une bonne oxygénation
  - Diamètre de la sonde= (Age/4) + 3 ou N°4 pour 10kg +/- 0.5 pour 5kg
- Défibrillateur externe, scope (ECG, TA, SaO2, FR)

## SELON LE RYTHME CARDIAQUE :

**Asystolie**

MCE (100pression/min) 15/2

Adrénaline = 10 µg /kg en (IV/IO) ou 100 µg/kg en intra trachéal

Puis analyse du rythme si toujours asystolie ➔ recommencer (MCE, adrénaline)

**TV/FV**

CEE 4J/Kg et massage et ventilation

Adrénaline toutes les 3 minutes

Si persistance de TV : Amiodarone (5 mg /kg max 300mg pour 1ère injection et 150mg pour 2ème)

**Torsade de pointe**

Sulfate de magnésium : 3 à 10mg/kg, max 2g

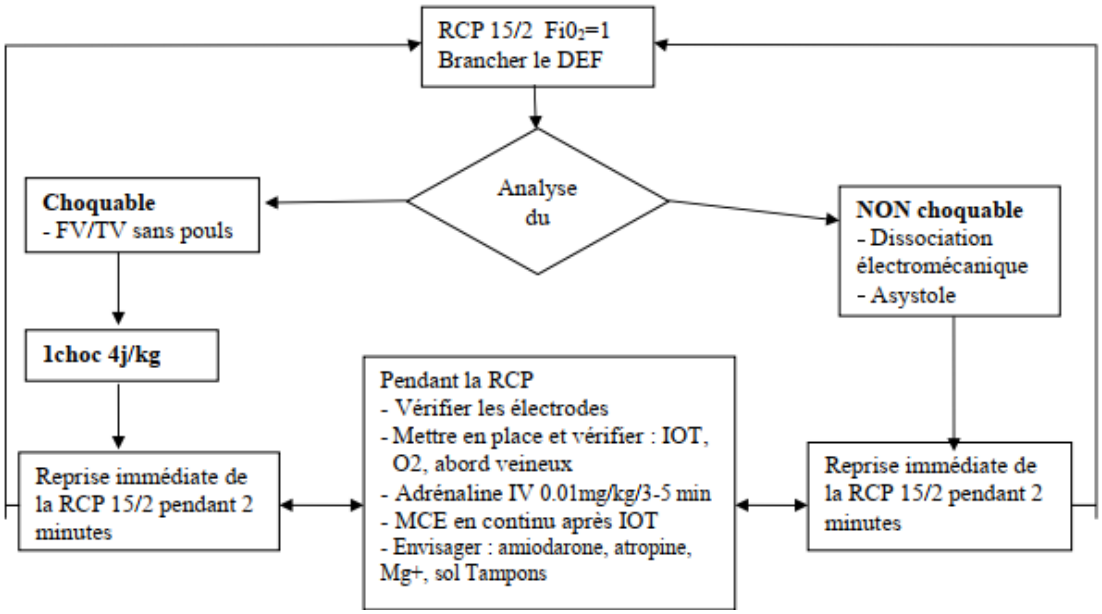
## PAR AILLEURS PENSER A CORRIGER LES CAUSES REVERSIBLES

- **hypoxie +++ = $0_2$**
- **hypovolémie** = remplissage vasculaire NaCl0.9% 20ml/kg IV10mn

- hyper ou hypokaliémie
- hypocalcémie
- thromboemboliques
- **hypoglycémie** = glucose IV
- acidose
- surdosages thérapeutiques
- pneumothorax compressif = exsufflation à l'aiguille
- tamponnade = ponction péricardique sous-xiphoïdienne (à discuter avec les réanimateurs)

## STABILISATION

- Contrôler l'oxygénation et la ventilation
- Traiter la douleur et l'angoisse
- Monitorer l'hémodynamique
- Prévenir toute agression cérébrale supplémentaire :
  - Pas d'hyperventilation
  - Si coma : envisager hypothermie 32 à 34°C
  - Traiter activement toute hyperthermie
  - Traiter les convulsions : rechercher et traiter hypoglycémie, hyponatrémie
- Eviter les médicaments néphrotoxiques
- Appeler le SAMU pour transfert secondaire vers une réanimation pédiatrique



# 26. ALERTE THROMBOLYSE

## Protocole alerte thrombolyse :

**Alerte thrombolyse : Tous signes neurologiques (présent ou résolutif) < 6h**

→ Appel MAO pour déclencher l'alerte thrombolyse

- AVC de moins de 6h
- AVC du réveil de moins de 4h30
- AIT de moins de 4h30

**Signes cliniques :**

Déficit moteur, sensitif, troubles du langage, troubles de la vision, examen des pupilles, vertiges.

**A l'IOA :**

- Décubitus 0° strict
- Prise de tension aux deux bras
- Pouls
- Saturation
- Dextro
- Température
- Déshabillage +/-
- Glasgow

→ **ECG + BS + VVP fait en SAUV**

# 27. HYPERKALIEMIE

## Hyperkaliémie :

**Connaître les définitions :**

- Hyperkaliémie = K+>5,5 mmol/l
- Hyperkaliémie menaçante = K+>6,5 mmol/l ou toute hyperK avec signes ECG
- Hyperkaliémie sévère chez dialysé chronique : K+ >7 avec signes ECG et/ou signe clinique
- Evoquer le diagnostic :
  Trouble du rythme cardiaque, parésie inexpliquée, prise de traitements hyperkaliémiants (potassium, spironolactone, digoxine), insuffisance rénale connue, contexte de rhabdomyolyse, contexte d'acidocétose diabétique

**Réaliser un ECG**

# 28. PROTOCOLE ECG A L'IOA

## Protocole ECG à l'IOA

- Douleur thoracique /épigastrique
- Douleur dorsale et/ou épaule gauche SANS trauma
- Tous les malaises
- Anomalie du bilan sanguin
  - Hyper/HypoKaliémie
  - Troponine augmentée
- Pouls sup à 120 ou inf à 45
- Anémies inférieures à 7g hb avec ATCD : IDM-Stent-Pontage
- IMV
- Trauma thoracique (nécessitant d'être allongé)

**SAUF POUR LES PATIENTS INSTALLES DIRECTEMENT EN SAUV POUR UN AUTRE MOTIF (L'IDE/AS du SAUV le fera).**

# 29. GESTION DES EFFETS PERSONNELS DES PATIENTS

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT-JOSEPH — Hôpital Paris Saint-Joseph

**Gestion des effets personnels des patients**

**1URG-PRC-003**
**Version : 05**

| **Emetteur : Service des Urgences** | **Date d'application : 25/01/2022**<br>**Date de création : 01/07/2014** |
|---|---|
| Rédigée par : Constance FRECHET Cadre de Santé des Urgences | signature : CF |
| Validée par : Laurence LECOCQ, Coordinatrice paramédicale | signature : LL |
| Approuvée par : Davina SUMBAL, Responsable des Relations Patients | signature : DS |

**INFORMATIONS GENERALES :**

***Manuel de certification*** :
« Sécurité des biens et des personnes – E1 : Les situations mettant en jeu la sécurité des biens et des personnes sont identifiées. Les responsabilités en matière de sécurité des biens et des personnes sont identifiées ».

**Objet :** Cette procédure vise à améliorer la qualité de la prise en charge des patients en diminuant la perte de leurs effets personnels.

**Domaines d'application :**

**Vocabulaire :**

**Documents associés ou de référence :**
Code de la santé publique - Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre Ier : Droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Chapitre III : Responsabilité des établissements à l'égard des biens des personnes accueillies
Articles L1113-1 à L1113-10

Procédure dépôt de biens et de valeurs des patients hospitalisés RP-PRC-004-1

**CONDUITE A TENIR :**

## I. Accueil administratif du patient

L'agent administratif s'engage à remettre **immédiatement** au patient les documents prouvant son identité (Carte nationale d'identité) et ses droits d'ouverture (carte vitale) à la suite de leur vérification, ***exception faite pour le patient qui est hors d'état d'exprimer sa volonté, ou devant recevoir des soins urgents, pour lequel l'agent administratif dépose alors les documents administratifs dans le classeur situé sur le bureau de la borne d'accueil des urgences (trieur).***

L'agent administratif de nuit respecte cette procédure.
Il doit vérifier les documents restés le jour précédent dans le classeur, les mettre dans une enveloppe datée et signée par lui-même et la transmettra à son collègue de jour pour dépôt à la caisse centrale.

L'agent administratif doit **obligatoirement** tracer cet accueil administratif pour chaque séjour du patient dans DxCare – (type de pièces d'identité présentées, remises à qui, lieu de consignation).

**AUCUN DOCUMENT ADMINISTRATIF ORIGINAL NE DOIT RESTER PRESENT DANS UN DOSSIER DE SOIN.**

## II. Prise en charge par l'Infirmière d'Orientation et d'Accueil (IOA)

Les effets personnels du patient sont réunis dans un sac nominatif (étiquettes).
Si nécessaire, identifier : les cannes, fauteuils roulants, béquilles, téléalarmes.

Pour les patients déshabillés par l'IOA :

- ✓ Troubles cognitifs avec risque de fugue,
- ✓ Pathologie psychiatrique pouvant entraîner une mise en danger (IMV, risque suicidaire, risque de fugue),
- ✓ Patient nécessitant une contention physique.

**AUCUN INVENTAIRE ne doit être REALISE par l'IOA mais sera effectué par l'aide soignant en binôme avec un autre soignant dès l'installation du patient.**
**(Car la mission prioritaire de l'IOA est d'évaluer le degré d'urgence des patients).**

## III. Cas du patient hors d'état d'exprimer sa volonté ou devant recevoir des soins urgents :

Tout patient **hors d'état d'exprimer sa volonté ou devant recevoir des soins urgents** (article L1113-3) **doit obligatoirement bénéficier d'un inventaire détaillé et d'un dépôt au coffre de ses biens de valeurs.**

Il s'agit de patients :

- ✓ Ayant des troubles de la conscience
- ✓ Ayant des troubles cognitifs
- ✓ Nécessitant une prise en charge en réanimation
- ✓ Nécessitant une prise en charge au bloc opératoire
- ✓ Nécessitant une contention physique
- ✓ Sous protection juridique (tutelle)

**L'inventaire est alors réalisé par l'aide-soignant en binôme avec un autre soignant**

## IV. En cas d'hospitalisation :

Tout patient hospitalisé (**Hors cas particuliers ci-dessus**) doit bénéficier d'un inventaire à l'entrée du service d'hospitalisation.

Lors des transferts de patients vers les services d'hospitalisation, le brancardier doit vérifier auprès des soignants si des effets personnels n'ont pas été mis en sécurité au vestiaire, il doit veiller à ne rien laisser sous le brancard.
Lorsqu'un patient doit aller au bloc opératoire, le brancardier achemine ses effets personnels vers le service (dès connaissance de celui-ci) qui l'accueillera en post opératoire ➔demande réalisée sur THEO par les AS.

## V. Suivi des effets personnels

### 1. Au SAU :

Tous les jours, l'aide soignant du SAU vérifie les effets personnels déposés au vestiaire.
Si vêtements non étiquetés : prévenir le cadre ou IDE référente.
Si vêtements étiquetés : localiser le patient et les lui faire parvenir.

Tous les mercredis une vérification sera faite par l'aide soignante en binôme avec l'infirmier référent.

Si le patient n'est plus à l'hôpital, lui demander de venir chercher ses effets personnels et tracer sur le registre.

Le premier mercredi de chaque mois l'aide soignante aidée de l'infirmier référent trie les effets consignés depuis 1 an.

### 2. Aux lits d'urgences :

L'aide soignant doit être présent pour chaque sortie ou transfert des patients.
Tous les après-midi, il vérifie s'il reste des vêtements et les fait acheminer ou contacte le patient.

**Lorsqu'un objet est trouvé sans nom,**
**prévenir dès que possible l'infirmier référent ou le cadre de jour comme de nuit**

# IV. AUTRES

## 1. REGLES DE BONNES PRATIQUES IOA

### Note de service : Règles de bonnes pratiques à l'IOA

## A. IOA :

- **Missions de l'IOA1 :**
  1. Prend les **transmissions** Ambu/Pompiers/autres secours (2 en même temps maximum)
  2. Voit en premier les patients présentant des **signes de détresse** (avec l'aide si besoin de l'IOA2)
  3. Tri les patients par **ordre d'arrivée**

- **Missions de l'IOA2** : régule le flux en prenant
  1. Les patients par **ordre d'arrivée**
  2. Ne prend **pas de transmission** ambu/pompiers/secours
  3. Les patients présentant des **signes de détresse**
  4. Si des patients sont en attente depuis **plus de 30 min**, les voir en premier
  5. L'IOA 2 peut solliciter **l'aide de l'aide-soignant** de l'IOA 1 à tout moment si besoin

- **Missions de l'IOA 3 :**
  1. **Triple** l'IOA dès qu'il y a plus de **5 patients en attente et/ou plus de 30 min** d'attente.
  2. Avant de tripler, l'IDE fait ses transmissions à un IDE du service.
  3. Voit uniquement les **patients valide**
  4. Reprend son poste par la suite.

- Les patients **couchés non autonome** doivent être impérativement **déshabillés dès l'accueil** (2 blouses)

- **L'installation en box** est réalisée par les IOA dès que le flux le permet

- **Respecter l'échelle de tri** notamment les indications à la surveillance **scopée**

- **Appel MAO (régulation de proximité) : 7863**
  - Pour valider un **ECG**
  - Pour TOUTES **réorientations** (CMT, L.Bellan, Procto, Necker…)
  - Pour prévenir d'un **CNA**
  - Pour tous **signes neurologiques** (vertiges compris) inférieurs à **4h30**
  - Pour enlever tout **matériel d'immobilisation** en place à l'arrivée du patient
  - **Aide au tri** si besoin

- **Transfert à la SAUV : appel IDE SAUV (7277) pour prévenir.**

**ATTENTION pas de validation nécessaire par médecin de la SAUV si les critères de tris sont réunis.**

- **Réévaluation à l'IOA :**
  - Patients ORANGE :
    - Prise de constantes **toutes les 2h** AS et/ou IDE
  - Patients JAUNE :
    - Prise de constantes **toutes les 4h** AS et/ou IDE
  - Tous patients :
    - **Prise de constantes pour toutes plaintes** (douleur tho, dyspnée…) avec réajustement de la prise en charge et adaptation du tri couleur si besoin.
    - Réévaluation de la **douleur à 45min**

## B. MEDECINS :

- **Pas de double régulation médicale** des dossiers déjà triés **ni de changement de couleurs de tri** si critères de tris respectés (cf. échelle de tri)
- **Pas d'interruption des IOA** pour modifier/discuter un tri.
- **Si désaccord sur un tri : débriefe à froid quand l'IOA est disponible**
- Si une décision de **réorientation** est prise pour un patient **déjà triés et en attente d'être vu** au SAU :
  - Si **l'IOA n'a pas fait régulé** le dossier et que le médecin veut le réorienter**, l'IOA s'en charge** elle-même
  - Un dossier **déjà régulé** par le MAO, peut être réorienté, mais par **le médecin** qui souhaite la réorientation.

**Attention :** si le patient a déjà passé **plus d'une heure en salle d'attente** après IOA il **ne doit pas être réorienté SAUF si le flux me nécessite**

## 2. IOA 3 (TRIPLAGE DE L'IOA)

# TRIPLAGE DE L'IOA :

**Objectifs :** Sécurisation du patient et de la salle d'attente non vus couchés

- **Missions de l'IOA3** :

1. Il se déclenche seul à partir de 30 minutes d'attente à l'IOA et/ou de 5 patients présents
2. Il voit tout le circuit valide dans l'ordre d'arrivée
3. Il garde ses patients (de zone) et ne les transmets que si nécessaire

- **En cas de patient non valide seulement (1 IDE + AS IOA) :**

1. Il se déclenche à partir de 30 minutes d'attente à l'IOA et/ou de 5 patients présents
2. Il met le bracelet d'identification.
3. Il prend les constantes : TA, Pouls, Température, Saturation, EN.

4. Il pose les questions sur les isolements et valide le questionnaire IOA.
5. En cas de besoin il se réfère à l'IOA 1 (listing)

Quand le flux repasse en dessous des 30 min d'attente et/ou de patients, l'AS et l'IOA 3 reprennent leurs places respectives à l'IOA.

## 3. RE-EVALUATION A L'IOA

En cas de flux important, avec patient ne pouvant être installés en box.

Prise de constantes de la salle d'attente non vus couchés (TA, Pouls, Sat, Température, EN)

- A 11h : Infirmier des pauses qui reprend l'IOA 1 à 11h30
- A 14h : L'aide-soignant de l'IOA1
- A 17h : L'infirmier 11-23h avant de revenir sur le flux.
- A 20h : L'aide-soignant de 11-23h
- A 23h: L'IOA 2
- A 2h, 5h, 8h : L'IOA 1

- A tout moment :
  - Prise de constantes pour toutes plaintes (douleur tho, dyspnée…) avec réajustement de la prise en charge et adaptation du tri couleur si besoin.
  - Réévaluation de la douleur à 45min

# 4. IOA EN MODE EN PROCEDURE DEGRADEE

En cas de coupure programmée ou non du logiciel DxCare.

Hôpital Paris Saint-Joseph

GROUPE HOSPITALIER PARIS SAINT JOSEPH

Etiquette patient

Service d'accueil des Urgences

Tél : 01 44 12 34 58

## ACCUEIL IOA

**Procédure mode dégradé**

Date : ...../...../20.....

**Heure de prise en charge :**

.....h.....

**Tri IOA :**

*Entouré la couleur de tri réalisé*

Vert Jaune

Bleu Orange Rose

Violet Rouge

**I.O.A :**

**M.A.O :**

**Motif de recours**

Accompagné par : .....

- ☐ Accident du travail
- ☐ Courrier du médecin
- ☐ Equipe de psychiatrie prévenue
- ☐ Médecin traitant
- ☐ Personne à prévenir

| Heure | FC Fréquence cardiaque | TA Tension artérielle | T° Température | $SaO^2$ Saturation en Oxygène | FR Fréquence respiratoire | Douleur | HGT | Hemocue | ... |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

10/01/2022 1URG-ENR-051

## Antécédents :

**Médicaux :**

**Chirurgicaux :**

**Allergies :**

**Traitements anticoagulants significatifs :**

**Facteurs de risques cardio-vasculaire :**

- ☐ Homme > 50 ans
- ☐ Femme > 60 ans
- ☐ Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans.
- ☐ Antécédents familiaux d'IDM ou mort subite chez le père ou la mère avant 60 ans.
- ☐ AVC avant l'âge de 45 ans.
- ☐ HTA permanente traitée ou non.
- ☐ Diabète de type 2 traitée ou non.
- ☐ Hypercholestérolémie

## Notion d'isolement :

**Hospitalisation ou soins à l'étranger au cours des 12 derniers mois ? ☐ Oui ☐ Non**

**Bracelet d'identification ☐**

**Soins effectuées :** ☐ ECG

☐ Deshabillage ☐ Vêtement détruits ☐ Vestiaire ☐ Dépôt coffre

☐ Pansement ☐ Pot à ECBU donnée ☐ Oxygène ☐ Radio prescrite

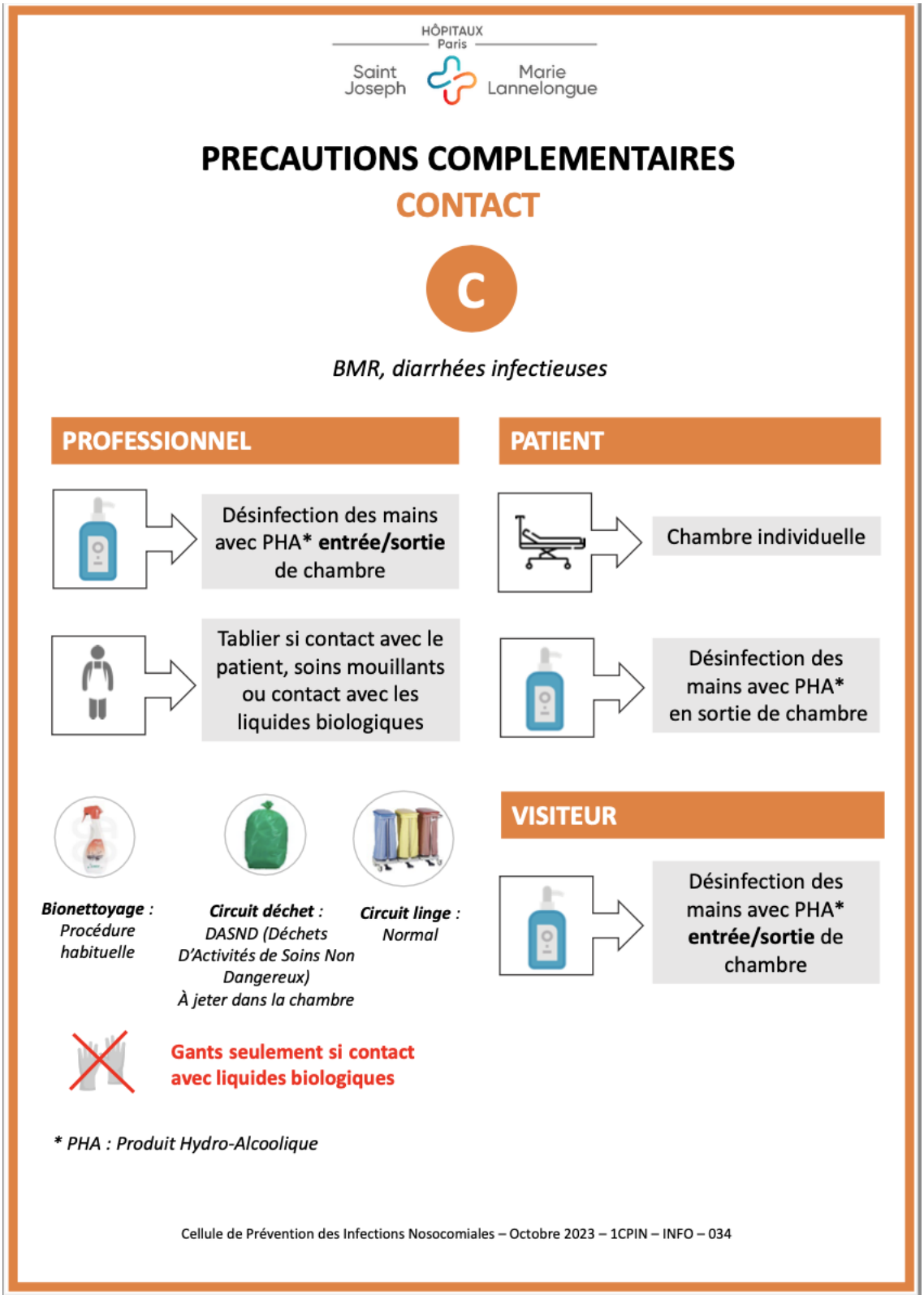
**Effets personnels :** ☐ Prothèse dentaire Haut ☐ Prothèse dentaire Bas

☐ Prothèse auditive Gauche ☐ Prothèse auditive Droite ☐ Lunettes / Etui à lunettes

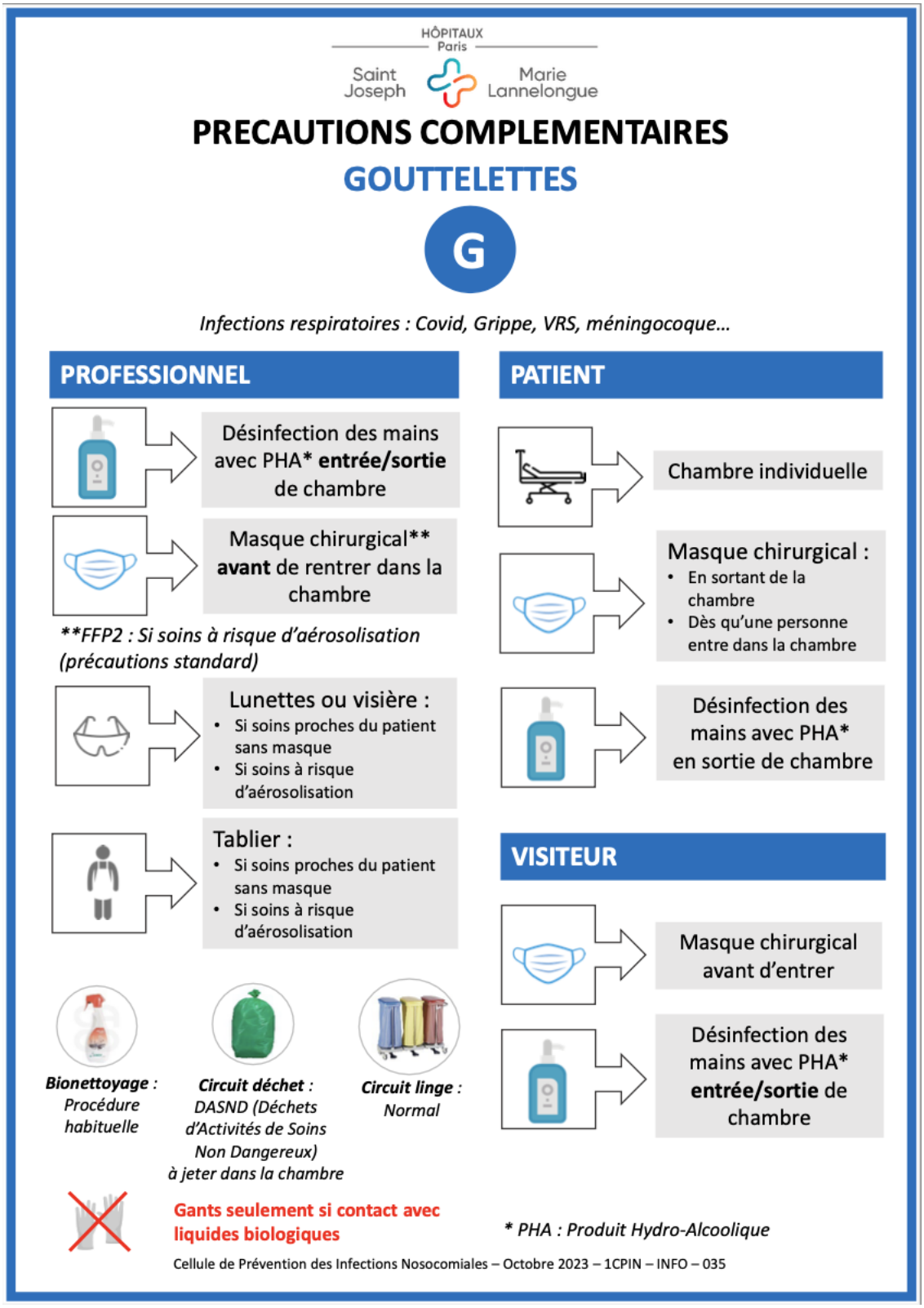
# 5. FICHES DE PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES

Il existe 8 types de précautions (anciennement appelé isolement) au sein de l'établissement.

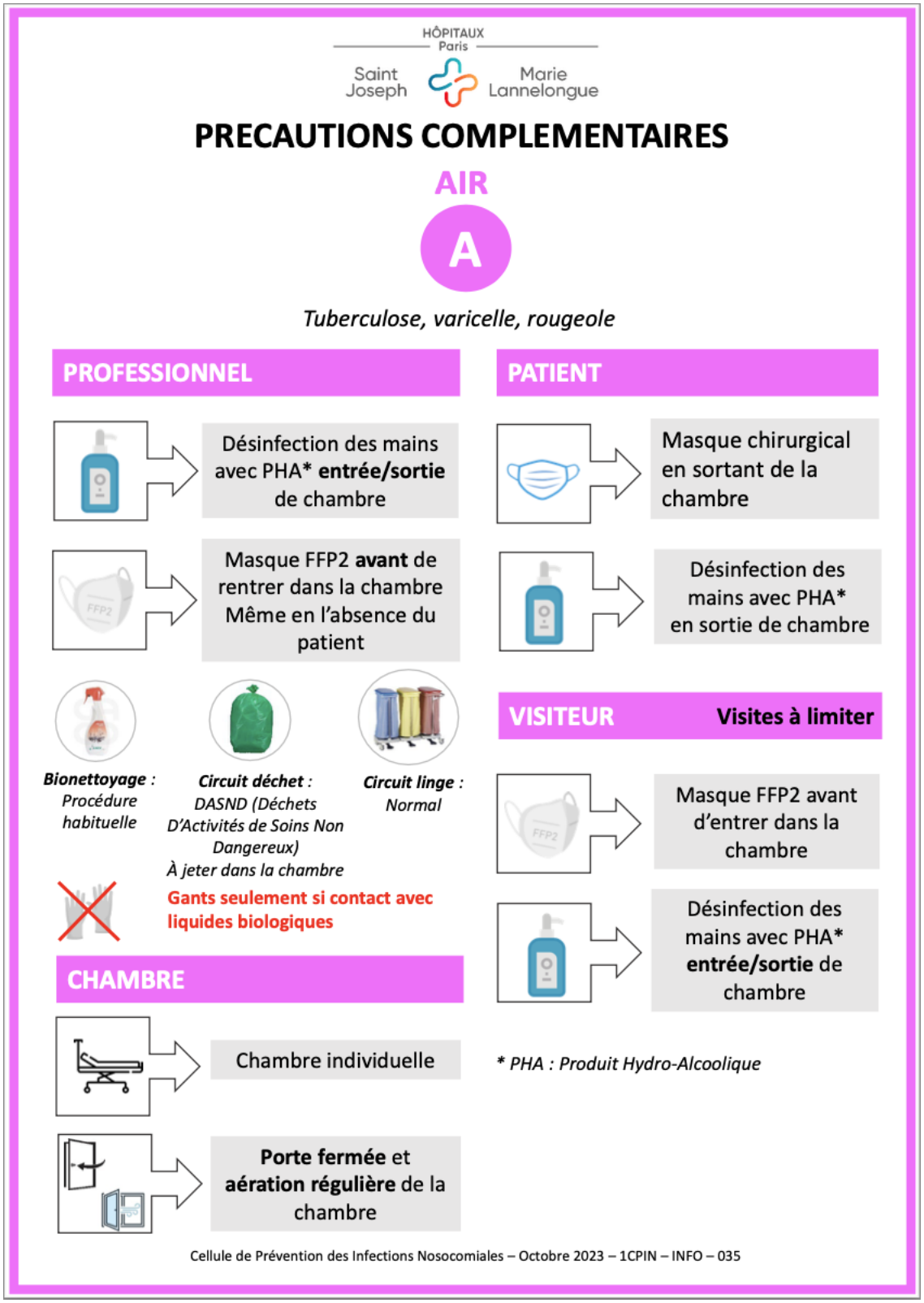
## 5.1. PRECAUTION COMPLEMENTAIRE : CONTACT



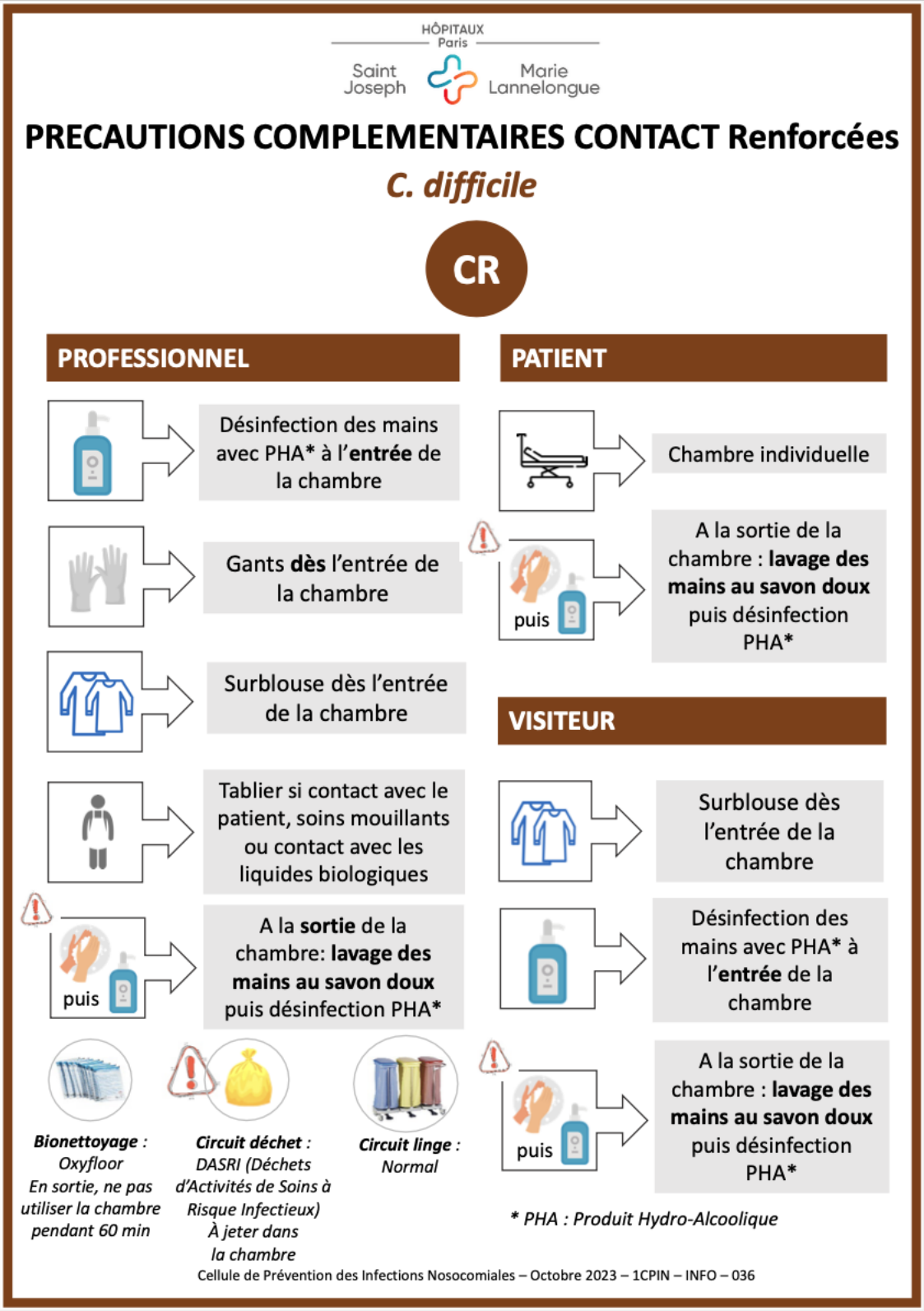
## 5.2. PRECAUTION COMPLEMENTAIRE : GOUTELETTES



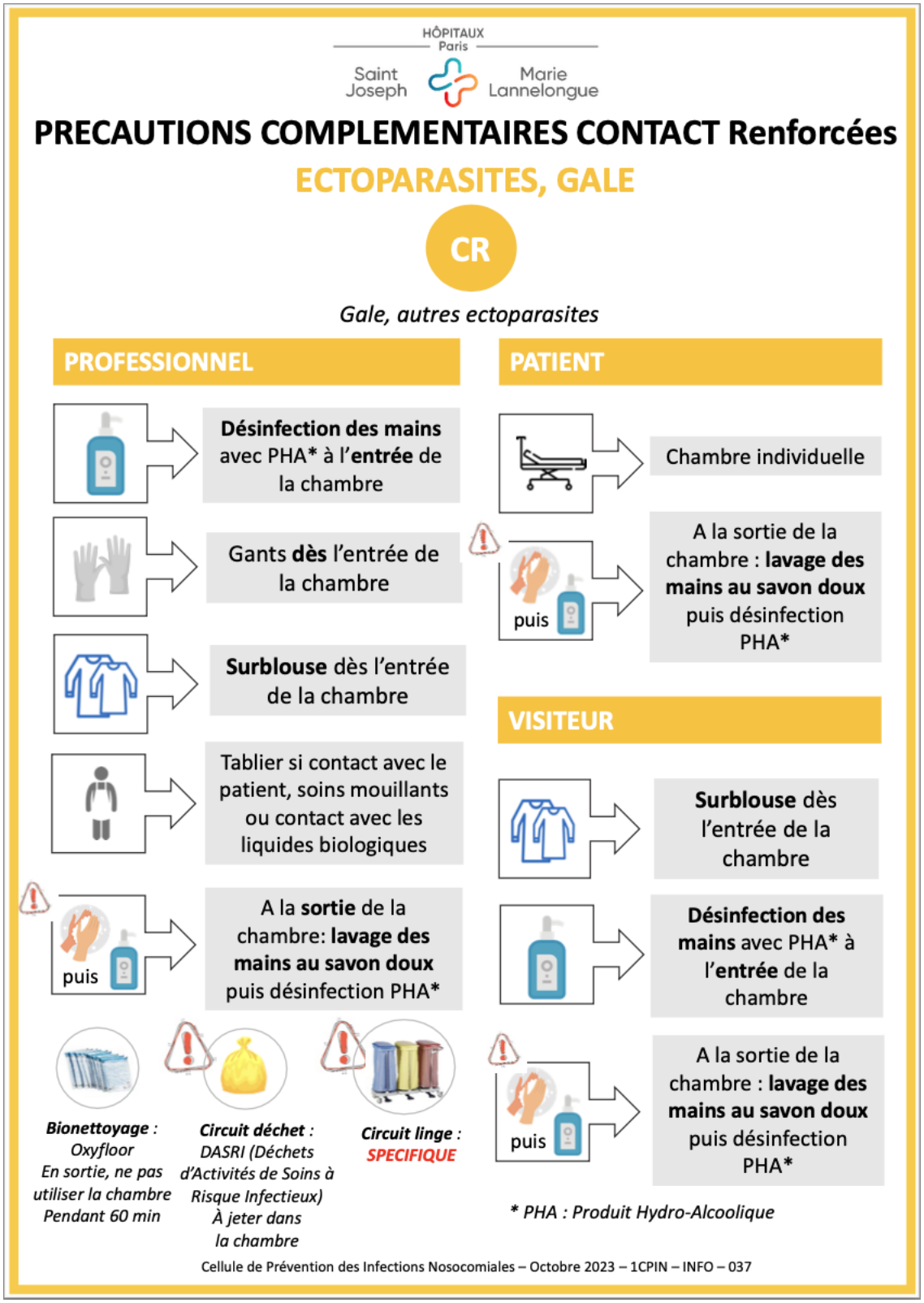
## 5.3. PRECAUTION COMPLEMENTAIRE : AIR



## 5.4. PRECAUTION COMPLEMENTAIRE CONTACT RENFORCEES : C. DIFFICILE



## 5.5. PRECAUTION COMPLEMENTAIRE CONTACT RENFORCEES : ECTOPARASITES, GALE



## 5.6. PRECAUTION COMPLEMENTAIRE CONTACT RENFORCEES : BHRE

HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

# PRECAUTIONS COMPLEMENTAIRES CONTACT Renforcées

## BHRe

**CR**

*Bactéries Hautement Résistantes émergentes*

### PROFESSIONNEL

**Désinfection des mains** avec PHA* **entrée/sortie** de chambre

**Surblouse dès l'entrée** de la chambre

Tablier si contact avec le patient, soins mouillants ou contact avec les liquides biologiques

***Bionettoyage :*** *Procédure BHRe*

***Circuit déchet :*** *DASND (Déchet d'Activités de Soins Non Dangereux) à jeter dans la chambre*

***Circuit linge :*** *Normal*

**Gants seulement si contact avec liquides biologiques**

### PATIENT

Chambre individuelle

**Désinfection des mains** avec PHA* **entrée/sortie** de chambre

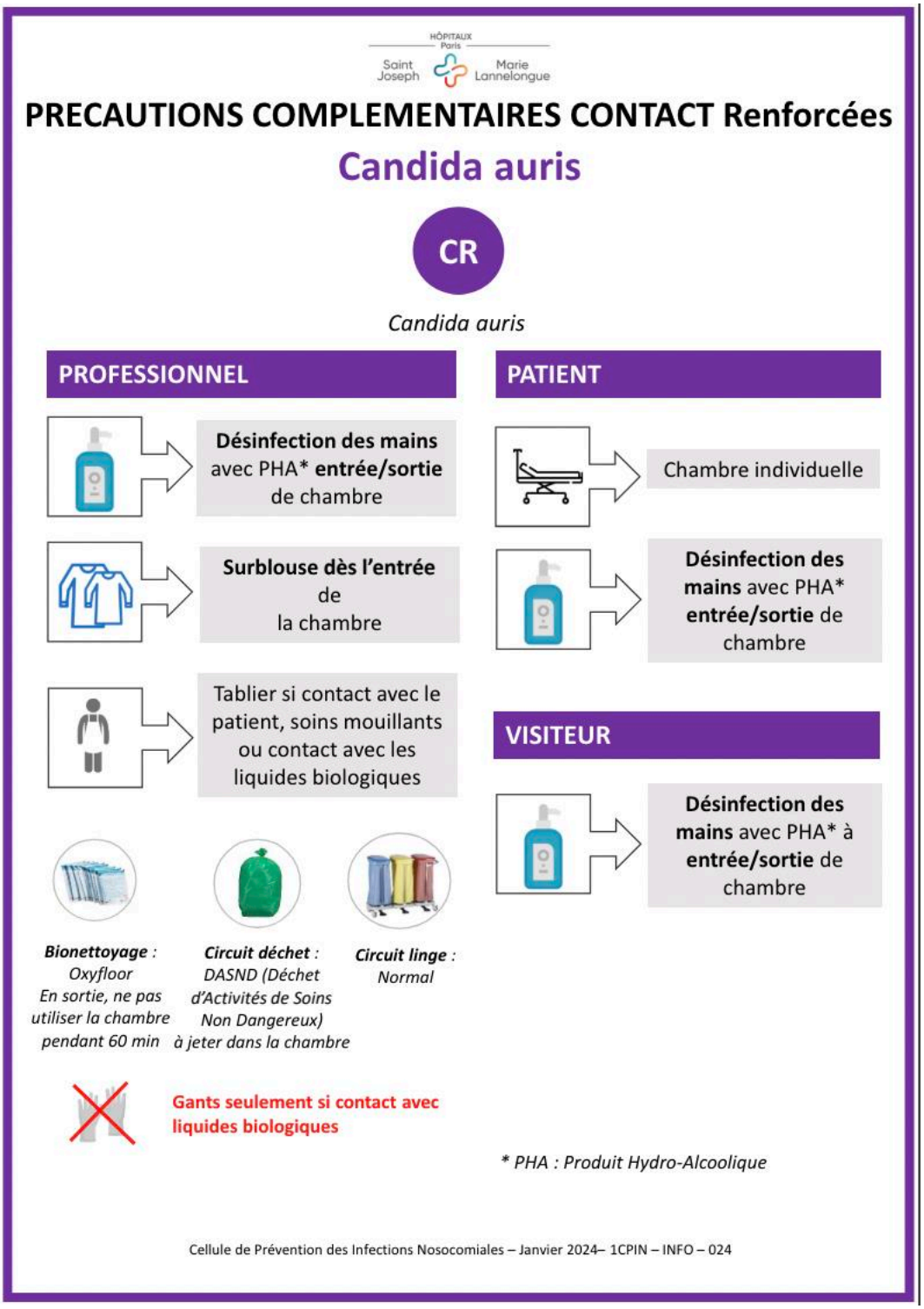
### VISITEUR

**Désinfection des mains** avec PHA* à **entrée/sortie** de chambre

** PHA : Produit Hydro-Alcoolique*

Cellule de Prévention des Infections Nosocomiales – Octobre 2023 – 1CPIN – INFO – 038

## 5.7. PRECAUTION COMPLEMENTAIRE CONTACT RENFORCEES : CANDIDA AURIS



## 5.8. ISOLEMENT PROTECTEUR

HÔPITAUX Paris
Saint Joseph Marie Lannelongue

# ISOLEMENT PROTECTEUR

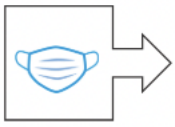
**P**

*Patients à risque élevé d'infections fongiques, bactériennes ou virales graves*

## PROFESSIONNEL



Désinfection des mains avec PHA* **entrée/sortie** de chambre



Masque chirurgical **NEUF dès l'entrée** de la chambre



***Bionettoyage (En dernier)** : Procédure habituelle, désinfection matériel partagé entrée/sortie de chambre*



***Circuit déchet** : DASND (Déchets D'Activités de Soins Non Dangereux)*

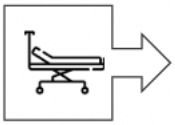


***Circuit linge** : Normal*

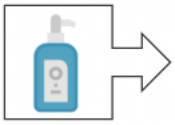


**Gants seulement si contact avec liquides biologiques**

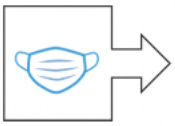
## PATIENT



Chambre individuelle



Désinfection des mains avec PHA* **entrée/sortie** de chambre



Masque chirurgical en sortant de la chambre

## VISITEUR



Désinfection des mains avec PHA* **entrée/sortie** de chambre



Masque chirurgical **NEUF dès l'entrée** de la chambre

** PHA : Produit Hydro-Alcoolique*

Cellule de Prévention des Infections Nosocomiales – Janvier 2024 -1CPIN – INFO – 024